



APRESENTA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

CONHECER PARA CUIDAR

Material de formação para missionários, líderes cristãos,
voluntários e agentes comunitários

LUENA
MOXICO
ANGOLA

PROJETO MISSIONÁRIO
CAMININA PARA CRISTO

LUENA • MOXICO • ANGOLA

Aliano Rafael

2026

PREFÁCIO

ONDE ESTA HISTÓRIA COMEÇOU

Esta apostila nasceu antes de tudo de uma necessidade missionária.

Muito antes de existir a ideia de transformá-la em um material disponível para outras pessoas, existia uma comunidade, uma família missionária e o desejo de servir.

Essa história começa em Angola, na província do Moxico, mais precisamente no município do Luena.

Ao sul da cidade encontra-se o bairro Caminina, uma comunidade que, segundo o levantamento realizado pelo projeto missionário, reúne aproximadamente entre 3.500 e 5.000 habitantes.

Ali vivem famílias que enfrentam diferentes desafios sociais. Entre as necessidades identificadas estão dificuldades relacionadas ao acesso à água, serviços de saúde e educação.

É também uma comunidade formada por pessoas que trabalham, criam seus filhos, desenvolvem pequenos negócios, atuam no serviço público, dedicam-se à agricultura e constroem diariamente suas histórias.

Foi olhando para essa comunidade que nasceu o projeto:

CAMININA PARA CRISTO.

UMA MISSÃO QUE COMEÇOU COM UM CHAMADO

O Caminina para Cristo integra o Projeto Missionário Moxico, uma iniciativa desenvolvida pela Agência Missionária Hora de Profetizar (AMHP), em cooperação com a Igreja Cafarnaum Internacional (ICI).

Seu propósito é levar o Evangelho às comunidades da província do Moxico, começando pelo bairro Caminina, por meio da evangelização, do discipulado, da formação de uma comunidade cristã local e do cuidado com necessidades encontradas entre a população.

A motivação missionária encontra suas raízes nas palavras de Jesus:

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações.”

Mateus 28:19

À frente desse trabalho em Caminina estão os missionários Eduardo e Ester Kanganjo.



Eduardo e Ester Kanganjo com seus filhos Kitilson, Acácia e Adriel.
Família missionária envolvida no projeto Caminina para Cristo, em Luena, província do Moxico, Angola.

UMA FAMÍLIA NO CAMPO MISSIONÁRIO

Eduardo e Ester são angolanos e residem em Luena.

Ao lado dos filhos Kitilson, Acácia e Adriel, eles estão envolvidos em uma missão que não acontece à distância.

Eles estão próximos da comunidade que desejam alcançar.

O planejamento inicial do projeto previa uma primeira fase dedicada à oração e ao conhecimento da comunidade entre junho e dezembro de 2026, seguida pelo desenvolvimento mais amplo do trabalho de campo a partir de 2027.

Entretanto, a aproximação com Caminina começou a produzir frutos ainda durante essa fase preparatória.

No relatório referente a setembro de 2026, Eduardo informou que 50 pessoas haviam sido alcançadas pelas ações de evangelização.

Dessas, 11 demonstraram interesse em caminhar com Jesus e passaram a ser acompanhadas no processo de discipulado.

Uma célula foi iniciada.

Durante o mês foram realizados três cultos, que reuniram respectivamente 17, 22 e 31 pessoas.

Também teve início uma turma do curso “A Vida Abundante”, com sete participantes.

Aquilo que estava sendo preparado começava, portanto, a ganhar rostos, nomes e histórias.

UMA NECESSIDADE ENCONTRADA NO CAMINHO

À medida que Eduardo conhecia melhor a realidade da comunidade, outra necessidade chamou sua atenção.

Entre os problemas encontrados estavam situações relacionadas ao consumo de álcool e maconha (cannabis).

Diante dessa realidade surgiu uma questão muito prática.

Como ajudar?

Boa vontade é indispensável.

Compaixão é indispensável.

Fé é indispensável para aqueles que assumem esta missão a partir de uma perspectiva cristã.

Mas, quando lidamos com o sofrimento humano, precisamos também reconhecer que boas intenções não são suficientes.

Para cuidar de pessoas é preciso também compreender pessoas.

Era necessário compreender melhor o que é dependência.

Como ela se desenvolve.

O que acontece no cérebro e no comportamento.

Por que algumas pessoas conseguem interromper o consumo enquanto outras encontram enorme dificuldade.

O que é abstinência.

Por que a interrupção do álcool pode, em determinadas situações, representar risco à saúde.

O que são redução de danos, lapso e recaída.

Como a família pode ajudar sem assumir responsabilidades que pertencem à própria pessoa.

Qual pode ser o papel da igreja.

Quando é necessário procurar profissionais e serviços de saúde.

E, principalmente, como se aproximar de alguém que sofre sem reduzi-lo à substância que utiliza.

Foi dessas perguntas que esta apostila começou a nascer.

DE CAMININA PARA ALÉM DE CAMININA

Inicialmente, este material possuía um destinatário muito claro.

Ele estava sendo preparado para auxiliar Eduardo em sua preparação e oferecer conhecimentos básicos que pudessem contribuir para uma atuação mais responsável diante das situações que encontraria no campo missionário.

Por isso, Caminina aparece tantas vezes nestas páginas.

Os exemplos procuram aproximar o conhecimento da realidade na qual ele será utilizado.

Entretanto, enquanto o material crescia, algo começou a ficar evidente.

As perguntas encontradas em Caminina não pertencem somente à Caminina.

Em muitos lugares existem famílias tentando compreender por que alguém que amam não consegue simplesmente parar de beber ou usar uma substância.

Existem igrejas desejando ajudar, mas sem saber exatamente como.

Existem pessoas que confundem dependência com falta de caráter.

Existem outras que acreditam que somente boa vontade será suficiente.

Existem pessoas em recuperação tentando reconstruir relacionamentos, rotina, trabalho, confiança e propósito.

Existem voluntários bem-intencionados que precisam aprender também os limites de sua atuação.

A realidade específica que motivou este material em Caminina envolve o álcool e a cannabis.

Entretanto, muitos dos princípios necessários para compreender dependência, recuperação, comportamento, família, recaída e reinserção social possuem aplicação mais ampla.

Foi então que surgiu uma segunda decisão:

este conhecimento não deveria permanecer restrito ao primeiro lugar para o qual foi preparado.

UM MATERIAL PARA SER COMPARTILHADO

Por isso, esta apostila passa também a ser disponibilizada gratuitamente por meio do projeto Jesus na Web.

Ela não pretende formar médicos.

Não pretende formar psicólogos.

Não pretende substituir tratamento.

Não pretende oferecer respostas para todas as situações relacionadas à dependência.

E muito menos pretende sugerir que a igreja deva ocupar o lugar dos profissionais e serviços de saúde.

Sua proposta é outra.

Oferecer uma introdução acessível e responsável para missionários, líderes cristãos, voluntários, familiares e outras pessoas que desejam compreender melhor a dependência e aprender maneiras mais responsáveis de se aproximar daqueles que enfrentam esse problema.

Ao longo dos capítulos, ciência, cuidado comunitário e fé cristã aparecerão lado a lado.

Não porque sejam a mesma coisa.

Mas porque reconhecer a dimensão espiritual de uma pessoa não exige ignorar sua saúde física e mental.

Da mesma maneira, reconhecer a necessidade de tratamento não exige abandonar a esperança, a oração, a comunidade e o cuidado espiritual.

UMA APOSTILA QUE TAMBÉM PRECISA CONTINUAR APRENDENDO

Este material não deve ser considerado uma palavra final.

O conhecimento científico continua avançando.

Realidades locais são diferentes.

Serviços disponíveis mudam de uma região para outra.

E nenhuma apostila consegue substituir a experiência de profissionais capacitados ou o conhecimento daqueles que vivem diariamente dentro de uma comunidade.

Por isso, uma das mensagens que acompanhará estas páginas será:

quando não soubermos, precisamos perguntar.

Quando ultrapassar nossa capacidade, precisamos encaminhar.

Quando houver risco à vida, precisamos procurar atendimento adequado.

Reconhecer limites não diminui o cuidado.

Também é uma maneira de cuidar.

CAMININA CONTINUA SENDO O PONTO DE PARTIDA

Ao disponibilizar esta apostila para outras pessoas, poderíamos retirar as referências à Caminina e transformá-la em um material completamente genérico.

Decidimos não fazer isso.

Porque esta apostila possui uma história.

Ela nasceu de uma conversa.

De uma necessidade encontrada no campo missionário.

De perguntas feitas por pessoas reais.

De uma comunidade real.

E do desejo de preparar alguém para servir melhor.

Se algum missionário utilizar estas páginas em outro lugar de Angola;

se uma igreja utilizá-las no Brasil;

se uma família encontrar aqui uma explicação que a ajude a compreender alguém que ama;

se um voluntário aprender que existem situações nas quais precisa procurar ajuda profissional;

ou se alguém que esteja em recuperação perceber nestas páginas que sua história ainda pode ser reconstruída;

então aquilo que começou diante de uma necessidade localizada terá alcançado lugares que não imaginávamos no início.

Mas não queremos esquecer de onde ela veio.

Esta apostila pode viajar.

Pode ser copiada.

Pode ser estudada.

Pode atravessar fronteiras.

Pode chegar a pessoas que talvez nunca conheçam pessoalmente Eduardo e Ester.

Mas sua história continuará apontando para uma pequena comunidade ao sul de Luena, onde uma família missionária decidiu aproximar-se de pessoas e servir.

Caminina, portanto, não será retirada desta história.

É justamente onde esta história começa.

INTRODUÇÃO

CONHECER PARA CUIDAR

Esta apostila foi preparada com um propósito essencialmente prático:

oferecer conhecimentos básicos sobre dependência química para pessoas que desejam acolher, orientar e acompanhar indivíduos e famílias afetados pelo consumo problemático de álcool e outras substâncias.

Seu primeiro contexto de aplicação é o Projeto Missionário Caminina para Cristo, no bairro Caminina, em Luena, província do Moxico, Angola.

Na realidade encontrada nessa comunidade, uma atenção especial surgiu diante de problemas relacionados ao consumo de álcool e maconha (cannabis).

Entretanto, ao longo da elaboração deste material, percebemos que muitos dos conhecimentos necessários para compreender essas situações são úteis também em outros contextos.

Por isso, esta apostila foi organizada de maneira que possa servir não apenas aos missionários envolvidos no Caminina para Cristo, mas também a líderes cristãos, agentes comunitários, voluntários, familiares e outras pessoas interessadas em compreender melhor a dependência e o processo de recuperação.

PARA QUEM FOI ESCRITA

Este material foi pensado principalmente para pessoas que não possuem formação especializada na área da saúde.

Não é necessário conhecer medicina, psicologia ou neurociência para iniciar a leitura.

Os conceitos foram apresentados, sempre que possível, em linguagem acessível e acompanhados de exemplos práticos.

Isso não significa abandonar o rigor.

Ao contrário.

Um dos objetivos desta apostila é justamente tornar conhecimentos importantes mais compreensíveis sem transformar questões complexas em explicações simplistas.

O QUE VAMOS ESTUDAR

Ao longo dos capítulos, construiremos o conhecimento progressivamente.

Começaremos entendendo o que é dependência química e como determinadas substâncias atuam sobre o organismo e o comportamento.

Falaremos especificamente sobre cannabis e álcool, duas substâncias diretamente relacionadas à realidade que motivou inicialmente este material.

Depois avançaremos para questões fundamentais como:

- síndrome de abstinência;
- funcionamento do cérebro e desenvolvimento da dependência;
- mudança de comportamento e padrões de pensamento;
- recuperação;
- redução de danos;
- lapso e recaída;
- prevenção de recaídas;
- participação da família;
- papel da comunidade e da igreja;
- reinserção social;
- reconstrução da vida;
- abordagem inicial e encaminhamento de pessoas que procuram ajuda.

O objetivo não é apenas responder:

“O que a droga faz?”

Queremos também compreender:

“O que aconteceu com essa pessoa?”

“O que mantém esse comportamento?”

“O que pode ajudá-la a mudar?”

“Como podemos ajudá-la sem causar novos danos?”

“Quando precisamos reconhecer nossos limites e procurar ajuda especializada?”

DEPENDÊNCIA NÃO É APENAS UMA QUESTÃO DE VONTADE

Uma ideia acompanhará toda esta apostila:

dependência química é um fenômeno complexo.

Ela envolve a interação de diferentes fatores.

Aspectos biológicos.

Psicológicos.

Familiares.

Sociais.

Ambientais.

Comportamentais.

E, dentro da proposta cristã deste material, reconhecemos também a importância da dimensão espiritual da pessoa.

Por isso, explicações como:

“Ele usa porque quer.”

“É só parar.”

“Falta força de vontade.”

ou

“Se tivesse fé suficiente isso não aconteceria.”

não são suficientes para compreender a dependência.

Isso também não significa retirar da pessoa toda responsabilidade por suas escolhas.

Uma parte importante da recuperação será justamente reconstruir responsabilidade, autonomia e capacidade de tomar decisões.

Precisamos aprender a manter duas verdades juntas:

a pessoa precisa assumir responsabilidade por sua recuperação;

e essa recuperação pode exigir ajuda.

FÉ E CUIDADO EM SAÚDE

Esta apostila nasce dentro de uma iniciativa missionária cristã.

Por isso, a fé estará presente.

Falaremos sobre esperança.

Transformação.

Perdão.

Comunidade.

Oração.

Responsabilidade.

Reconciliação.

Propósito.

E sobre a mensagem do Evangelho que motiva o Caminina para Cristo.

Entretanto, existe um princípio que precisa ficar claro desde o início:

CUIDADO ESPIRITUAL NÃO SUBSTITUI CUIDADO MÉDICO OU PROFISSIONAL QUANDO ELE É NECESSÁRIO.

Orar por alguém e encaminhá-lo para atendimento não são atitudes contraditórias.

Acompanhar uma pessoa espiritualmente e reconhecer que ela necessita de tratamento também não são atitudes contraditórias.

Existem situações relacionadas ao álcool e outras substâncias que podem representar risco grave à saúde e até à vida.

Nesses momentos, procurar atendimento adequado é parte do cuidado responsável.

ESTA APOSTILA NÃO É UM MANUAL DE DIAGNÓSTICO

Outro limite precisa ser estabelecido.

Este material não capacita o leitor a diagnosticar dependência química ou outros transtornos.

Também não autoriza alguém a prescrever medicamentos, realizar desintoxicação por conta própria ou substituir profissionais especializados.

Seu objetivo é oferecer conhecimento básico suficiente para:

compreender melhor;

acolher melhor;

observar melhor;

fazer perguntas melhores;

reconhecer situações de risco;

orientar dentro dos próprios limites;

e encaminhar quando necessário.

Às vezes, uma das atitudes mais responsáveis que podemos tomar é dizer:

“Eu não sei resolver isso sozinho. Vamos procurar alguém que possa nos ajudar.”

COMO UTILIZAR ESTA APOSTILA

Embora seja possível consultar capítulos isoladamente, recomendamos que, na primeira leitura, o material seja estudado na ordem apresentada.

Os capítulos foram organizados para que um assunto prepare o próximo.

Ao final de cada capítulo existem momentos de reflexão e uma síntese da ideia principal.

Esses elementos podem ser utilizados individualmente ou em pequenos grupos de estudo.

Missionários e voluntários podem, por exemplo:

ler previamente um capítulo;

reunir-se para conversar sobre ele;

discutir as situações apresentadas;

comparar o conteúdo com aquilo que encontram na comunidade;

levantar dúvidas;

e procurar orientação adicional quando necessário.

O objetivo não é decorar conceitos.

É aprender a utilizá-los com responsabilidade.

CONHECIMENTO PRECISA PRODUZIR UMA MANEIRA DIFERENTE DE OLHAR

Talvez uma das mudanças mais importantes proporcionadas pelo estudo da dependência não aconteça naquilo que fazemos.

Talvez aconteça primeiro na maneira como enxergamos.

Onde alguém vê apenas um “bêbado”, precisamos aprender a enxergar uma pessoa.

Onde alguém vê apenas um “drogado”, precisamos aprender a enxergar uma história.

Onde existe comportamento destrutivo, precisamos reconhecer responsabilidade, mas também procurar compreender aquilo que contribui para mantê-lo.

Onde existe recaída, precisamos avaliar o que aconteceu antes de concluir que tudo foi perdido.

Onde existe uma família desesperada, precisamos perceber que ela também pode precisar de orientação e cuidado.

E onde nossas capacidades terminam, precisamos reconhecer que outras pessoas e serviços deverão continuar aquilo que não podemos fazer.

CONHECER PARA CUIDAR

O título desta apostila foi escolhido por uma razão:

DEPENDÊNCIA QUÍMICA — CONHECER PARA CUIDAR.

Conhecimento não substitui compaixão.

Mas compaixão sem conhecimento pode cometer erros.

Podemos desejar ajudar alguém e, sem perceber, facilitar comportamentos prejudiciais.

Podemos aconselhar uma pessoa a interromper imediatamente o álcool sem saber que determinadas formas graves de abstinência podem exigir atendimento de saúde.

Podemos assumir responsabilidades que deveriam permanecer com a própria pessoa.

Podemos interpretar uma recaída apenas como fracasso moral.

Podemos tentar resolver sozinho situações que ultrapassam nossa preparação.

Por isso queremos unir duas coisas:

CORAÇÃO DISPOSTO E MENTE PREPARADA.

Precisamos de pessoas que estejam dispostas a aproximar-se.

Mas precisamos também de pessoas dispostas a aprender.

ANTES DE COMEÇAR

Ao iniciar esta leitura, talvez você já conheça alguém que enfrenta dependência.

Talvez faça parte de uma igreja ou projeto social.

Talvez seja familiar de alguém.

Talvez esteja estudando simplesmente porque deseja estar preparado para ajudar.

Ou talvez algumas destas páginas também façam você pensar sobre sua própria história.

Independentemente do motivo que o trouxe até aqui, existe uma postura que desejamos incentivar desde o primeiro capítulo:

não leia apenas procurando respostas.

Leia também aprendendo a fazer perguntas.

Pergunte.

Observe.

Escute.

Estude.

Reconheça limites.

Procure ajuda quando necessário.

E nunca permita que o problema faça você esquecer a pessoa.

É com esse espírito que começamos.

Conhecer para compreender.

Compreender para cuidar.

E cuidar preservando sempre a dignidade da pessoa que está diante de nós.

SUMÁRIO

PREFÁCIO

Onde esta história começou

INTRODUÇÃO

Conhecer para cuidar

CAPÍTULO 1 — ENTENDENDO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

1. Antes de falar em dependência, precisamos falar em substâncias psicoativas
2. O que é dependência química
3. Uso, uso problemático e dependência
4. Como a dependência se desenvolve
5. Dependência não é simplesmente falta de caráter ou força de vontade

CAPÍTULO 2 — CANNABIS: COMEÇANDO DO PRINCÍPIO

1. O que é cannabis
2. Como a cannabis age no organismo
3. Efeitos do uso
4. Riscos associados ao consumo
5. Cannabis e dependência
6. O que observar na comunidade

CAPÍTULO 3 — ÁLCOOL: QUANDO UMA SUBSTÂNCIA COMUM SE TORNA UM PROBLEMA

1. O que é o álcool
2. Como o álcool age no organismo
3. Efeitos do consumo
4. Uso frequente e dependência
5. Consequências para a saúde
6. Bebidas artesanais e riscos adicionais
7. O álcool e a realidade comunitária

CAPÍTULO 4 — SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA: QUANDO O ORGANISMO REAGE À FALTA DA SUBSTÂNCIA

1. O que é abstinência
2. Por que o organismo reage quando a substância é retirada
3. Abstinência de cannabis
4. Abstinência de álcool
5. Quando a abstinência pode ser perigosa
6. A importância de procurar atendimento adequado

CAPÍTULO 5 — O CÉREBRO, O COMPORTAMENTO E O CAMINHO DA DEPENDÊNCIA

1. O cérebro aprende
2. O sistema de recompensa
3. Dopamina e reforço
4. Tolerância e adaptação
5. Gatilhos e memória
6. Ambiente e dependência
7. O que aprendemos com o Rat Park
8. Mudança de padrões de pensamento
9. Comportamentos também precisam mudar

CAPÍTULO 6 — RECUPERAÇÃO: RECONSTRUINDO A VIDA

1. O que significa recuperação
2. Parar de usar é apenas uma parte
3. Mudança de comportamento
4. Mudança de padrões de pensamento
5. Rotina e ambiente
6. Relacionamentos
7. Responsabilidade
8. Propósito
9. Recuperação como processo

CAPÍTULO 7 — REDUÇÃO DE DANOS: PROTEGER A VIDA ENQUANTO A MUDANÇA ACONTECE

1. O que é redução de danos
2. Reduzir danos não significa incentivar o uso
3. Começar pela realidade da pessoa
4. Estratégias para diminuir riscos
5. Um cuidado especial com o álcool
6. A pessoa é maior que a substância
7. Redução de danos como ponte para mudanças

8. Aplicação na realidade de Caminina

CAPÍTULO 8 — LAPSO, RECAÍDA E PREVENÇÃO: QUANDO A RECUPERAÇÃO ENCONTRA DIFICULDADES

1. Recuperação nem sempre acontece em linha reta
2. O que é um lapso
3. O que é recaída
4. A recaída pode começar antes do consumo
5. Gatilhos
6. Sinais de alerta
7. O que fazer depois de um lapso
8. Responsabilidade sem condenação
9. Plano de prevenção de recaídas
10. Quando existe uma emergência

CAPÍTULO 9 — A FAMÍLIA DIANTE DA DEPENDÊNCIA: AJUDAR SEM ADOECER JUNTO

1. A dependência afeta toda a família
2. Compreendendo a chamada codependência
3. Ajudar não é impedir todas as consequências
4. Apoiar ou facilitar?
5. Amar também significa estabelecer limites
6. A família não controla a recuperação
7. Reconstruindo confiança
8. Violência nunca deve ser normalizada
9. A família também precisa de cuidado
10. O papel da família na recuperação

CAPÍTULO 10 — A COMUNIDADE E A IGREJA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: ACOLHER, ACOMPANHAR E CONHECER NOSSOS LIMITES

1. Recuperação também precisa de pertencimento
2. Acolher antes de julgar
3. Acolhimento não significa aprovação de todo comportamento
4. O perigo do estigma
5. O testemunho é importante, mas não é uma fórmula
6. Oração e tratamento não são adversários
7. Quando encaminhar
8. A igreja como ponte
9. Recuperação continua depois do tratamento
10. Pessoas em recuperação também podem servir
11. O papel do Caminina para Cristo
12. Preparando voluntários

CAPÍTULO 11 — REINSERÇÃO SOCIAL E RECONSTRUÇÃO DA VIDA: RECUPERAR É APRENDER A VIVER NOVAMENTE

1. Abstinência e recuperação não são exatamente a mesma coisa
2. Reconstruir uma rotina
3. Aprender novamente a assumir responsabilidades
4. Trabalho é importante, mas não é apenas dinheiro
5. Educação também reconstrói possibilidades
6. Dinheiro também precisa ser reaprendido
7. Reconstruir confiança leva tempo
8. Algumas relações precisarão mudar
9. Lazer também precisa ser reaprendido
10. Cuidado com a pressa de recuperar tudo
11. O passado pode ensinar sem determinar o futuro
12. Propósito protege a recuperação
13. Não transformar a recuperação na única identidade
14. Reinserção não acontece somente pelo esforço individual
15. Caminina para Cristo e a reconstrução da vida
16. A dimensão espiritual da reconstrução

CAPÍTULO 12 — DO CONHECIMENTO À AÇÃO: PRIMEIROS PASSOS PARA QUEM DESEJA AJUDAR

1. Comece pela pessoa, não pela droga
2. Não comece com um sermão
3. Faça perguntas simples e importantes
4. Observe antes de orientar
5. Saiba reconhecer alguns sinais de perigo
6. Um cuidado especial com o álcool
7. Não prometa aquilo que não pode cumprir
8. Não tente ser o salvador da pessoa
9. Confidencialidade e respeito
10. Cuidado ao utilizar testemunhos
11. Construa uma rede antes de precisar dela
12. Registre sem transformar a pessoa em um número
13. Acompanhar depois do encaminhamento
14. Prepare um plano simples para cada pessoa
15. Nem toda pessoa estará pronta para mudar
16. Se houver um lapso, retome o caminho
17. Quem cuida também precisa ser cuidado
18. Comece pequeno e faça bem feito
19. Uma possível sequência de atendimento
20. O que o Caminina para Cristo não precisa ser
21. Conhecimento, compaixão e sabedoria
22. A dimensão espiritual do serviço

CONCLUSÃO

Conhecer para cuidar — e cuidar para transformar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONHEÇA E APOIE O CAMINHA PARA CRISTO

Oração, contatos e formas de contribuição

CAPÍTULO 1 — ENTENDENDO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

1. Antes de falar em dependência, precisamos falar em substâncias psicoativas

Chamamos de substância psicoativa uma substância capaz de atuar no sistema nervoso e alterar, em diferentes graus, funções como percepção, humor, consciência, pensamento ou comportamento.

Isso nos leva a uma primeira informação importante:

Droga não é sinônimo apenas de substância ilegal.

O álcool, por exemplo, contém etanol, uma substância psicoativa capaz de produzir intoxicação e dependência. Portanto, embora o consumo de bebidas alcoólicas seja socialmente aceito em muitos lugares, o álcool também precisa ser compreendido dentro deste assunto.

A cannabis também é uma substância psicoativa. Seu principal componente responsável pelos efeitos intoxicantes é o THC (tetraidrocanabinol). Outro componente bastante conhecido é o CBD (canabidiol), que não produz os mesmos efeitos intoxicantes do THC.

Neste material estudaremos principalmente álcool e cannabis porque são as substâncias identificadas pelos missionários como relevantes na comunidade em que atuarão.

2. Usar uma substância não significa automaticamente ser dependente

Essa distinção é fundamental.

Uma pessoa pode consumir álcool e não apresentar dependência. Da mesma maneira, alguém que utilizou cannabis algumas vezes não deve automaticamente ser chamado de dependente.

Existem diferentes padrões de consumo e diferentes níveis de prejuízo.

O uso prejudicial ocorre quando um padrão de consumo já está causando danos significativos à saúde física ou mental da pessoa.

A dependência é algo diferente e mais complexo. Ela envolve uma alteração progressiva da capacidade de regular e controlar o consumo.

Por isso, uma primeira regra será importante durante todo o nosso estudo:

Não devemos diagnosticar uma pessoa simplesmente porque sabemos que ela bebe ou utiliza cannabis.

Nosso primeiro trabalho é observar, ouvir e compreender.

3. O que é dependência?

A dependência envolve fenômenos comportamentais, cognitivos e, em determinadas situações, fisiológicos que aparecem depois do uso repetido de uma substância.

Uma de suas características centrais é um forte impulso para continuar utilizando a substância.

Esse processo pode aparecer como:

- dificuldade de controlar o consumo;
- prioridade cada vez maior dada à substância;
- continuação do uso apesar das consequências negativas;
- desejo intenso ou dificuldade para permanecer sem a substância;
- tolerância;
- sintomas de abstinência em determinadas situações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve a dependência como uma condição em que aparecem, entre outras características, dificuldade de controlar o uso, prioridade crescente da substância e persistência do consumo apesar dos prejuízos.

Isso significa que chegamos a uma ideia muito importante:

Dependência não pode ser explicada simplesmente como falta de força de vontade.

4. Como alguém chega à dependência?

Não existe uma única história.

Algumas pessoas experimentam determinada substância e nunca desenvolvem dependência. Outras começam a apresentar problemas progressivamente.

Por isso, devemos tomar cuidado com esquemas rígidos como:

Experimentou → gostou → tornou-se dependente.

A realidade é muito mais complexa.

Fatores biológicos, psicológicos, familiares, sociais e ambientais podem interagir no desenvolvimento dos transtornos relacionados ao uso de substâncias.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e a Organização Mundial da Saúde trabalham com a compreensão dos transtornos relacionados ao uso de drogas como condições de saúde que necessitam de prevenção, cuidado e tratamento adequados.

Imagine duas pessoas que consomem álcool.

Uma bebe ocasionalmente e consegue passar longos períodos sem beber.

A outra começa a beber com frequência. Com o passar do tempo, percebe que necessita consumir quantidades maiores. Passa a organizar parte de sua rotina em torno da bebida. Tenta diminuir, mas encontra grande dificuldade. A família começa a sofrer as consequências. Mesmo assim, ela continua bebendo.

Externamente podemos enxergar apenas:

“Ele continua bebendo.”

Mas por trás daquele comportamento pode existir uma dependência.

Compreender essa diferença muda completamente nossa maneira de nos aproximarmos dessa pessoa.

5. Três conceitos importantes

Tolerância

Com o uso repetido de determinadas substâncias, uma pessoa pode precisar consumir quantidades maiores para alcançar efeitos semelhantes aos que anteriormente conseguia com quantidades menores.

Isso é chamado de tolerância.

A tolerância pode fazer parte da dependência, mas sua presença isoladamente não é suficiente para concluir que uma pessoa seja dependente.

Fissura ou craving

É um desejo ou impulso intenso de consumir a substância.

Uma pessoa pode realmente desejar parar e, ainda assim, experimentar momentos de forte vontade de consumir.

Esse fenômeno nos ajuda a compreender uma frase frequentemente pronunciada por pessoas que enfrentam uma dependência:

“Eu quero parar, mas não consigo.”

Não devemos interpretar automaticamente essa frase como mentira, falta de compromisso ou ausência de força de vontade.

Abstinência

Quando alguém utiliza determinadas substâncias repetidamente durante algum tempo e depois interrompe ou reduz significativamente o consumo, pode surgir um conjunto de sintomas.

Chamamos isso de síndrome de abstinência.

A forma e a gravidade desses sintomas dependem da substância utilizada, do padrão de consumo, das condições de saúde da pessoa e de outros fatores.

Mais adiante teremos um capítulo específico sobre abstinência.

No caso do álcool, essa questão exigirá atenção especial porque alguns quadros de abstinência podem tornar-se graves e representar uma emergência médica.

6. Dependência não significa que a pessoa esteja sem esperança

Este é um dos conceitos mais importantes para alguém que trabalhará diretamente com pessoas que utilizam álcool ou cannabis.

Quando a substância começa a ocupar um lugar central na vida, outras coisas podem progressivamente perder espaço: família, trabalho, responsabilidades, relacionamentos e atividades que anteriormente eram importantes.

Por isso, simplesmente dizer:

“Pare de beber.”

ou

“Pare de usar cannabis.”

pode ser insuficiente.

A recuperação pode envolver mudanças comportamentais, sociais, familiares e ambientais, além de tratamento de saúde quando disponível.

Os padrões internacionais da OMS e do UNODC defendem tratamento baseado em evidências, cuidado comunitário e respeito à dignidade das pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias.

7. Uma primeira mudança de olhar

Antes de prosseguirmos, queremos que o missionário guarde quatro ideias fundamentais:

A pessoa não é a droga que utiliza.

Nem toda pessoa que utiliza uma substância é dependente.

Uma pessoa dependente não deve ser reduzida à ideia de “falta de força de vontade”.

Dependência é uma condição para a qual existem possibilidades de cuidado, tratamento e recuperação.

Essa será nossa base para os próximos capítulos.

CAPÍTULO 2 — CANNABIS: COMEÇANDO DO PRINCÍPIO

1. O que é cannabis?

Cannabis é o nome utilizado para plantas do gênero Cannabis, das quais podem ser obtidas diferentes preparações.

A palavra maconha é um dos nomes populares utilizados no Brasil para preparações da planta destinadas principalmente ao consumo por seus efeitos psicoativos.

Em Angola, entretanto, os nomes populares utilizados pela comunidade podem ser diferentes. Por isso, durante o trabalho de campo, é importante descobrir como a própria comunidade chama a substância, sem presumir que os termos utilizados no Brasil sejam conhecidos.

A cannabis contém diversas substâncias químicas chamadas canabinoides.

Duas das mais conhecidas são:

THC — tetraidrocanabinol: principal componente responsável pelos efeitos intoxicantes característicos da cannabis.

CBD — canabidiol: outro componente da cannabis, mas que não produz a intoxicação característica do THC.

Para nosso estudo sobre uso não medicinal e dependência, o THC terá maior importância.

A Organização Mundial da Saúde considera a cannabis uma substância psicoativa e reconhece que seu uso pode levar ao desenvolvimento de dependência em parte das pessoas que a utilizam.

2. Como a cannabis é consumida?

Existem diferentes formas de preparação e consumo.

Uma das mais conhecidas é utilizar partes secas da planta, que podem ser fumadas, inclusive enroladas de maneira semelhante a um cigarro.

Também existem resinas, extratos, óleos e produtos que podem ser ingeridos.

Isso é importante porque uma pessoa que nunca teve contato com esse universo pode imaginar que cannabis significa necessariamente determinado tipo de cigarro.

Não significa.

Cannabis é a planta e também um termo geral relacionado a suas preparações; a forma de apresentação e consumo pode variar.

Também não devemos ensinar características como aparência ou cheiro como se fossem suficientes para identificar com segurança aquilo que alguém está consumindo.

No campo, o melhor caminho será perguntar à própria pessoa o que utiliza e como utiliza.

3. O que acontece quando alguém usa cannabis?

Quando a cannabis contendo THC é consumida, o THC atua no chamado sistema endocanabinoide, que participa da regulação de diversas funções do organismo.

O consumo pode produzir alterações em funções como:

- percepção;
- memória;
- atenção;
- coordenação;
- tempo de reação;
- julgamento;
- emoções.

A pessoa pode experimentar relaxamento, euforia e alterações na percepção do tempo e do ambiente.

Mas os efeitos não são iguais para todos.

Algumas pessoas podem apresentar ansiedade, medo, pânico, confusão ou paranoia.

Produtos ou doses com maior quantidade de THC podem aumentar a possibilidade de efeitos adversos. A cannabis também pode prejudicar capacidades necessárias para atividades como conduzir veículos ou operar equipamentos.

Há ainda associações entre o uso de cannabis e determinados problemas de saúde mental. Essas relações são complexas e não devem ser apresentadas como se toda pessoa que utiliza cannabis necessariamente desenvolvesse um transtorno psiquiátrico.

Essa distinção será importante durante todo este material:

Risco não significa destino.

Não devemos ensinar:

“Quem usa cannabis ficará assim.”

Devemos ensinar:

“O uso de cannabis pode aumentar determinados riscos, que variam conforme a pessoa, frequência e padrão de consumo, quantidade de THC, idade e outras circunstâncias.”

4. Cannabis pode causar dependência?

Sim.

Nem toda pessoa que experimenta ou utiliza cannabis desenvolve dependência.

Entretanto, seu uso repetido pode resultar em um transtorno relacionado ao uso de cannabis, incluindo dependência.

Com o tempo, algumas pessoas podem perceber:

“Estou usando com mais frequência.”

Depois:

“Tentei diminuir, mas não consegui.”

Ou:

“Quando fico sem usar, sinto muita vontade.”

E eventualmente:

“Continuo usando mesmo sabendo dos problemas que isso está causando.”

É nesse momento que precisamos abandonar uma interpretação simplista.

O problema já não pode ser resumido a:

“Ele gosta de fumar.”

Pode existir uma dificuldade real de controlar o consumo.

5. Tolerância

Uma pessoa que utiliza cannabis repetidamente pode desenvolver tolerância.

Isso significa que determinada quantidade pode deixar de produzir o mesmo efeito que produzia anteriormente, podendo ocorrer aumento do consumo na tentativa de obter efeitos semelhantes.

Mas é importante repetir algo aprendido no primeiro capítulo:

Tolerância isoladamente não permite diagnosticar dependência.

Ela é uma das características que podem aparecer dentro de um quadro mais amplo.

6. Existe abstinência de cannabis?

Sim.

Esse é um ponto que muitas pessoas desconhecem.

Uma pessoa que fez uso frequente e prolongado de cannabis pode apresentar sintomas depois de interromper ou reduzir significativamente o consumo.

Entre os sintomas que podem aparecer estão:

- irritabilidade;
- ansiedade ou nervosismo;
- dificuldade para dormir;
- inquietação;
- diminuição do apetite;
- alterações do humor;
- desejo de voltar a consumir.

Também podem ocorrer alguns sintomas físicos.

Portanto, se alguém disser:

“Quando fico sem fumar, fico irritado e não consigo dormir.”

isso não deve ser automaticamente interpretado como desculpa.

Pode fazer parte de uma síndrome de abstinência de cannabis.

7. Cannabis e álcool não são iguais

Esta distinção será muito importante para o trabalho na comunidade.

Tanto o álcool quanto a cannabis podem estar associados à dependência.

Mas os riscos de abstinência não são iguais.

A abstinência de cannabis pode ser bastante desconfortável e contribuir para que a pessoa volte a consumir. Entretanto, em geral, não apresenta o mesmo potencial de emergência médica encontrado na abstinência grave do álcool.

A interrupção ou redução abrupta do consumo de álcool em uma pessoa com dependência importante pode provocar complicações graves, incluindo convulsões, alucinações e delirium, entre outras manifestações.

Por isso, quando estudarmos o álcool, haverá uma orientação específica de segurança.

Uma informação precisa ficar bem compreendida:

Se uma pessoa apresenta forte dependência de álcool, simplesmente mandá-la parar de beber imediatamente, sem avaliar a necessidade de assistência de saúde, pode ser perigoso.

8. Efeitos e riscos do uso frequente

O uso frequente ou prolongado de cannabis pode estar associado a prejuízos em diferentes áreas.

Durante a intoxicação, pode haver comprometimento da memória, atenção, coordenação e outras funções cognitivas.

Quando fumada, a cannabis também expõe o aparelho respiratório aos produtos da combustão.

Existem preocupações especiais com o uso frequente entre adolescentes e jovens, período em que o cérebro ainda está em desenvolvimento.

Há também associação entre o uso de cannabis e determinados problemas de saúde mental, especialmente em pessoas mais vulneráveis.

Isso exige cuidado na maneira como ensinamos.

Não devemos dizer:

“Cannabis causa loucura.”

Essa afirmação é imprecisa e estigmatizante.

É mais adequado dizer:

“O consumo de cannabis, especialmente quando frequente e envolvendo maior exposição ao THC, está associado a determinados riscos para a saúde mental, e algumas pessoas apresentam maior vulnerabilidade que outras.”

9. Uma orientação importante para o missionário

Quando o missionário encontrar alguém utilizando cannabis, seu primeiro objetivo não será descobrir se aquela pessoa merece o rótulo de “dependente”.

Ele deve procurar compreender a relação da pessoa com a substância.

Algumas perguntas simples podem ajudar:

Com que frequência você usa?

O que você sente quando usa?

O que acontece quando tenta ficar sem usar?

Já tentou diminuir ou parar?

O consumo está trazendo algum problema para sua vida, família, trabalho ou relacionamentos?

Essas perguntas começam a revelar algo muito mais importante que simplesmente o nome da substância:

a relação daquela pessoa com ela.

10. Para guardar deste capítulo

Cannabis é uma substância psicoativa.

THC é o principal componente responsável pelos seus efeitos intoxicantes.

Nem toda pessoa que utiliza cannabis é dependente.

O uso frequente pode produzir tolerância e dependência em algumas pessoas.

Existe síndrome de abstinência de cannabis.

Dependência de cannabis pode ser tratada.

O missionário não precisa diagnosticar. Ele precisa saber ouvir, reconhecer sinais de problema, oferecer apoio e compreender quando é necessário procurar ajuda profissional.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).
The health and social effects of nonmedical cannabis use: technical brief. Geneva: World Health Organization; 2026.

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).
Cannabis. Informações técnicas sobre efeitos agudos e crônicos, prejuízo psicomotor e dependência relacionada ao uso de cannabis.

OMS e UNODC — Organização Mundial da Saúde e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Geneva: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime; 2020.

CAPÍTULO 3 — ÁLCOOL: QUANDO UMA SUBSTÂNCIA COMUM SE TORNA UM PROBLEMA

1. O que é o álcool?

Quando falamos em álcool neste material, estamos nos referindo principalmente ao etanol (álcool etílico), substância responsável pelos principais efeitos intoxicantes das bebidas alcoólicas.

O álcool não está presente apenas em bebidas produzidas industrialmente. Em diferentes comunidades, bebidas alcoólicas também são produzidas localmente por processos tradicionais ou artesanais, frequentemente utilizando a fermentação de matérias-primas disponíveis na região.

Independentemente de a bebida ser comprada pronta ou produzida artesanalmente, o etanol é uma substância psicoativa. Isso significa que atua no sistema nervoso e pode alterar comportamento, julgamento, coordenação, percepção, emoções e outras funções.

O álcool também é capaz de produzir tolerância, dependência e síndrome de abstinência.

Uma característica importante do álcool é sua ampla presença social e cultural. Em muitas comunidades, beber pode estar associado a encontros, festas, celebrações, costumes locais ou simplesmente fazer parte da rotina.

Essa familiaridade pode dificultar o reconhecimento do momento em que o consumo começa a provocar prejuízos.

Por isso, precisamos aprender desde o princípio:

Uma substância não deixa de apresentar riscos simplesmente porque seu consumo é social ou culturalmente aceito.

2. Bebidas artesanais e tradicionais

Em algumas comunidades, bebidas alcoólicas são produzidas localmente por meio da fermentação de cereais, frutas ou outras matérias-primas.

Durante a fermentação, microrganismos, especialmente leveduras, transformam determinados açúcares presentes na matéria-prima e produzem álcool.

Por isso, uma bebida não precisa ter sido fabricada por uma indústria para conter álcool suficiente para provocar:

- intoxicação;
- prejuízo da coordenação e do julgamento;

- acidentes;
- problemas de saúde;
- tolerância;
- dependência.

O fato de uma bebida ser artesanal ou tradicional não significa automaticamente que seja mais perigosa, mas também não significa que seja segura.

Quando não existe padronização da produção, pode ser difícil saber exatamente quanto álcool aquela bebida contém.

Duas preparações aparentemente semelhantes podem apresentar concentrações alcoólicas diferentes.

Além disso, dependendo da matéria-prima utilizada, das condições de higiene, do armazenamento, do processo de fabricação e da existência ou não de destilação ou adulteração, podem existir outros riscos.

Por isso, não devemos fazer afirmações específicas sobre uma bebida artesanal sem conhecer sua composição e seu processo de produção.

No trabalho em Caminina, será importante descobrir:

- como a comunidade chama essas bebidas;
- quais matérias-primas são utilizadas;
- como são produzidas;
- se são apenas fermentadas ou também destiladas;
- como são armazenadas;
- aproximadamente quanto as pessoas costumam consumir;
- qual papel essas bebidas desempenham na vida social e cultural da comunidade.

Essas informações poderão permitir posteriormente um estudo específico sobre as bebidas encontradas na região.

Por enquanto, o missionário deve guardar um princípio fundamental:

Uma pessoa pode desenvolver problemas relacionados ao álcool e dependência tanto com bebidas industrializadas quanto com bebidas produzidas artesanalmente.

3. O que acontece quando uma pessoa bebe?

Depois que uma bebida alcoólica é ingerida, o álcool é absorvido pelo organismo, passa para o sangue e alcança diferentes órgãos, inclusive o cérebro.

Seus efeitos variam de acordo com diversos fatores, como:

- quantidade consumida;
- rapidez do consumo;
- concentração alcoólica da bebida;
- alimentação;
- características individuais;
- condições de saúde;
- uso simultâneo de medicamentos ou outras substâncias.

No caso das bebidas artesanais, existe uma dificuldade adicional: a pessoa pode não saber a concentração de álcool presente naquilo que está bebendo.

Algumas pessoas inicialmente apresentam sensação de relaxamento, desinibição e maior facilidade para falar ou interagir.

À medida que aumenta a quantidade de álcool no organismo, podem aparecer:

- redução do julgamento;
- dificuldade de concentração;
- fala alterada;
- perda de coordenação;
- dificuldade para caminhar;
- alterações de comportamento;
- sonolência;
- confusão;
- náuseas e vômitos.

Em intoxicações graves podem ocorrer perda de consciência, comprometimento da respiração e outras complicações potencialmente fatais.

Portanto, a intoxicação alcoólica não deve ser tratada simplesmente como alguém que está “muito bêbado”.

Em determinadas circunstâncias, é uma emergência médica.

4. Álcool é estimulante ou depressor?

Algumas pessoas acreditam que o álcool é uma substância estimulante porque, no início do consumo, alguém pode ficar mais falante, agitado ou desinibido.

Entretanto, o álcool é classificado como uma substância depressora do sistema nervoso central.

A aparente estimulação inicial ocorre, em parte, porque o álcool reduz determinados mecanismos de controle e inibição do cérebro.

Por isso, a pessoa pode falar coisas que normalmente não falaria, assumir riscos maiores ou apresentar comportamentos que não teria quando sóbria.

Conforme aumenta a intoxicação, os efeitos depressores tornam-se mais evidentes: piora da coordenação, redução dos reflexos, sonolência e, nos casos graves, comprometimento de funções vitais.

5. Toda pessoa que bebe é dependente?

Não.

Assim como aprendemos no capítulo sobre cannabis, consumo e dependência não são sinônimos.

Existem pessoas que consomem bebidas alcoólicas sem apresentar dependência.

Outras podem desenvolver um padrão de consumo que começa a provocar prejuízos físicos, psicológicos, familiares, sociais ou profissionais.

E algumas desenvolvem dependência.

Por isso, não devemos olhar simplesmente para a existência do consumo.

Precisamos observar a relação da pessoa com o álcool e as consequências desse consumo.

Uma pergunta importante não é apenas:

“Você bebe?”

Mas também:

“O que acontece na sua vida quando você bebe?”

6. Quando o consumo começa a tornar-se um problema?

Não existe apenas um sinal.

Alguns comportamentos podem indicar que o álcool está ocupando um espaço cada vez mais problemático na vida da pessoa.

Por exemplo:

- beber com frequência crescente;

- consumir quantidades cada vez maiores;
- ter dificuldade para parar depois que começa;
- tentar diminuir e não conseguir;
- sentir forte desejo de beber;
- faltar ao trabalho ou deixar responsabilidades por causa da bebida;
- apresentar conflitos familiares relacionados ao consumo;
- gastar recursos necessários à família com bebida;
- continuar bebendo mesmo percebendo prejuízos;
- precisar beber para sentir-se “normal”;
- apresentar sintomas quando reduz ou interrompe o consumo.

Nenhum desses sinais deve ser analisado isoladamente pelo missionário como se ele estivesse realizando um diagnóstico médico.

Eles servem para mostrar que aquela pessoa pode precisar de avaliação, apoio e cuidado.

7. Como a dependência de álcool pode se desenvolver?

Não existe uma única trajetória.

Uma pessoa pode começar bebendo em situações sociais.

Outra pode utilizar o álcool como maneira de lidar com sofrimento, solidão, ansiedade, problemas familiares ou dificuldades da vida.

Outra pode viver em um ambiente no qual o consumo frequente é comum.

Existem ainda fatores biológicos, psicológicos, familiares, sociais e ambientais que podem aumentar ou diminuir a vulnerabilidade de uma pessoa.

Com o uso repetido, algumas pessoas desenvolvem tolerância.

A quantidade que anteriormente produzia determinado efeito pode deixar de produzir o mesmo resultado.

A pessoa passa então a consumir mais.

Progressivamente, o álcool pode ganhar maior importância na rotina.

O que antes era:

“Eu quero beber.”

pode transformar-se em:

“Eu preciso beber.”

Essa mudança é muito importante para compreendermos a dependência.

8. O que é tolerância ao álcool?

Tolerância significa que o organismo passa a responder de maneira diferente ao uso repetido da substância.

Uma pessoa pode perceber que precisa beber mais para alcançar efeitos semelhantes aos que anteriormente conseguia com quantidades menores.

Isso pode levar a uma falsa impressão:

“Ele bebe muito e continua de pé. Então o organismo dele aguenta.”

Isso não significa necessariamente saúde ou resistência.

Pode ser justamente um sinal de tolerância desenvolvida pelo uso frequente.

E existe outro perigo.

Uma pessoa tolerante a alguns efeitos do álcool ainda pode sofrer danos físicos importantes.

Conseguir consumir grandes quantidades sem aparentar estar tão intoxicado não significa que o álcool deixou de prejudicar o organismo.

9. O álcool pode afetar todo o organismo

O consumo de álcool está associado a diversos problemas de saúde.

Os riscos aumentam conforme fatores como quantidade, frequência e padrão de consumo, embora danos também possam ocorrer em episódios isolados, como acidentes e intoxicações.

Entre os problemas associados ao consumo de álcool estão:

- doenças do fígado;
- doenças cardiovasculares;
- alguns tipos de câncer;
- problemas digestivos;
- alterações neurológicas;
- problemas de saúde mental;
- lesões e acidentes;

- violência;
- intoxicação alcoólica.

O consumo durante a gravidez também pode prejudicar o desenvolvimento do bebê.

Além disso, o álcool pode interagir perigosamente com determinados medicamentos e outras substâncias.

Portanto, quando falamos dos danos provocados pelo álcool, não estamos falando apenas de dependência.

Uma pessoa pode sofrer consequências graves relacionadas ao álcool mesmo sem apresentar dependência.

10. Os prejuízos não atingem somente quem bebe

Uma característica importante dos problemas relacionados ao álcool é que suas consequências podem alcançar outras pessoas.

O consumo problemático pode contribuir para:

- conflitos familiares;
- negligência de responsabilidades;
- dificuldades financeiras;
- acidentes;
- violência;
- perda ou dificuldade de manutenção do trabalho;
- rompimento de relacionamentos;
- sofrimento dos filhos e familiares.

Entretanto, precisamos tomar cuidado para não transformar isso em uma acusação contra todas as pessoas que apresentam dependência.

O objetivo deste material não é ensinar o missionário a dizer:

“Veja tudo o que você fez com sua família.”

O objetivo é ajudá-lo a compreender que a recuperação frequentemente precisará envolver não apenas a interrupção ou redução do consumo, mas também a reconstrução de áreas da vida afetadas pelo álcool.

11. Quando beber deixa de ser somente uma escolha?

Esta é uma pergunta importante.

No início, uma pessoa pode decidir consumir álcool voluntariamente.

Mas, à medida que uma dependência se desenvolve, sua capacidade de controlar o consumo pode ficar significativamente prejudicada.

Ela pode acordar dizendo:

“Hoje não vou beber.”

E algumas horas depois estou bebendo novamente.

Pode prometer à família que vai parar.

Pode realmente desejar cumprir essa promessa.

E ainda assim não conseguir.

Isso não significa que todas as escolhas e responsabilidades da pessoa desapareceram.

Significa que precisamos compreender que existe uma diferença entre uma decisão comum e uma situação na qual se desenvolveu um transtorno relacionado ao uso de álcool.

Por isso, humilhação, ameaças e acusações dificilmente constituem uma resposta adequada ao problema.

A pessoa precisa assumir responsabilidade por sua recuperação, mas também pode precisar de apoio, acompanhamento e tratamento.

12. Um ponto de atenção: beber para evitar passar mal

Existe uma situação que o missionário precisa aprender a reconhecer.

Algumas pessoas com dependência importante podem começar a beber não apenas para buscar prazer ou intoxicação, mas também para evitar sintomas desagradáveis que aparecem quando ficam algum tempo sem álcool.

Podem surgir, por exemplo:

- tremores;
- suor;
- ansiedade;
- agitação;
- náuseas;
- dificuldade para dormir;
- forte mal-estar.

A pessoa então bebe novamente e percebe que os sintomas diminuem.

Forma-se um ciclo:

bebe → o álcool diminui no organismo → aparecem sintomas → bebe novamente para aliviar os sintomas.

Nesse momento, a dependência pode ter também um componente físico importante.

E aqui chegamos a uma das orientações de segurança mais importantes de todo este material:

Uma pessoa com dependência importante de álcool não deve ser simplesmente orientada a interromper abruptamente o consumo sem considerar os riscos da abstinência.

Em algumas pessoas, a abstinência alcoólica pode evoluir para quadros graves, incluindo convulsões, alucinações e delirium, podendo representar risco de morte.

Estudaremos isso detalhadamente em um capítulo próprio.

—

13. O álcool pode levar à morte

É importante falar sobre este assunto com clareza, sem exageros e sem utilizar o medo como instrumento.

O consumo de álcool pode, em determinadas circunstâncias, levar à morte.

Isso pode acontecer de diferentes maneiras.

Intoxicação alcoólica grave

Quando uma quantidade muito grande de álcool é consumida, especialmente em pouco tempo, a concentração de álcool no organismo pode atingir níveis capazes de comprometer funções essenciais.

A pessoa pode apresentar:

- confusão intensa;
- vômitos;
- dificuldade para permanecer consciente;
- perda de consciência;
- convulsões;
- respiração lenta ou irregular;
- incapacidade de ser despertada.

Uma pessoa profundamente intoxicada não deve ser simplesmente deixada sozinha para “dormir até passar”.

Mesmo depois que ela parou de beber, o álcool que permanece no estômago e intestino ainda pode continuar sendo absorvido. Além disso, uma pessoa inconsciente ou com consciência muito reduzida pode vomitar e aspirar o conteúdo para os pulmões ou apresentar comprometimento da respiração.

Quando houver dificuldade para despertar a pessoa, alteração importante da respiração, convulsões ou perda de consciência, deve-se procurar atendimento de emergência imediatamente.

Abstinência alcoólica grave

Existe também um perigo que parece contraditório:

uma pessoa com dependência importante pode correr risco quando interrompe abruptamente o consumo de álcool.

A abstinência alcoólica pode começar com sintomas como tremores, ansiedade, suor, náuseas, agitação e dificuldade para dormir.

Em determinados casos, porém, pode evoluir para manifestações graves, incluindo convulsões, alucinações e delirium, podendo colocar a vida da pessoa em risco.

Por isso, o missionário não deve tentar realizar sozinho a desintoxicação de alguém com forte dependência de álcool.

Esse assunto será estudado detalhadamente no capítulo sobre síndrome de abstinência.

Consequências do consumo prolongado

O álcool também pode contribuir para doenças que se desenvolvem ao longo dos anos.

O consumo prolongado e prejudicial está associado, entre outros problemas, a doenças do fígado. Entre as formas mais graves de dano hepático encontra-se a cirrose, condição na qual o fígado sofre cicatrização e perda progressiva de sua capacidade de funcionamento.

O álcool também está associado a doenças cardiovasculares, determinados tipos de câncer e outras condições que podem contribuir para morte prematura.

Portanto, existem diferenças importantes:

Uma pessoa pode morrer em consequência de uma intoxicação alcoólica grave.

Uma pessoa com dependência importante pode sofrer complicações potencialmente fatais durante a abstinência.

Uma pessoa pode desenvolver, depois de anos de consumo prejudicial, doenças graves que podem levar à morte.

Conhecer esses riscos não significa afirmar que toda pessoa que bebe terá essas consequências.

Significa compreender que o álcool é uma substância capaz de provocar danos graves e, em determinadas circunstâncias, fatais.

14. Quando procurar ajuda com urgência?

O missionário não precisa tornar-se médico para ajudar uma pessoa.

Mas precisa aprender a reconhecer seus limites.

Uma pessoa intoxicada por álcool necessita de avaliação urgente quando apresenta sinais como:

- dificuldade para permanecer consciente ou impossibilidade de ser despertada;
- respiração muito lenta, irregular ou dificuldade para respirar;
- convulsões;
- confusão intensa;
- vômitos repetidos associados à redução da consciência;
- queda ou traumatismo importante;
- comportamento que coloque a própria pessoa ou outras em perigo.

Quando houver suspeita de intoxicação grave, a prioridade é buscar o atendimento de saúde disponível.

Não se deve simplesmente deixar uma pessoa profundamente intoxicada “dormir até passar”.

Também não se deve provocar vômito em uma pessoa inconsciente ou com consciência muito reduzida.

Quando houver acesso a serviços de emergência, eles devem ser acionados.

15. Uma mudança importante de linguagem

A maneira como falamos também interfere na maneira como cuidamos.

Expressões humilhantes ou rótulos podem fazer com que a pessoa seja definida pelo problema que enfrenta.

Em vez de enxergar apenas:

“um bêbado”

podemos aprender a enxergar:

“uma pessoa que apresenta problemas relacionados ao uso de álcool”

ou

“uma pessoa com possível dependência de álcool.”

Isso não diminui a gravidade do problema.

Ao contrário.

Permite separar a pessoa da condição que ela enfrenta.

Uma pessoa pode ter causado danos, quebrado relacionamentos e tomado decisões prejudiciais durante anos de consumo.

Essas consequências precisam ser enfrentadas.

Mas aquela pessoa continua sendo uma pessoa.

16. Perguntas que ajudam a compreender

Durante uma conversa, algumas perguntas podem ajudar o missionário a conhecer melhor a situação:

Que tipo de bebida você costuma consumir?

Essa bebida é comprada ou produzida aqui na comunidade?

Com que frequência você bebe?

Quando você começa a beber, consegue parar quando deseja?

Já tentou diminuir ou parar? O que aconteceu?

Quando fica algum tempo sem beber, sente alguma coisa diferente no corpo?

Sua família já demonstrou preocupação com sua maneira de beber?

O álcool já trouxe problemas para seu trabalho, família, saúde ou vida financeira?

Você já bebeu pela manhã ou logo depois de acordar para aliviar tremores ou mal-estar?

Essas perguntas não substituem uma avaliação profissional.

Elas servem para abrir uma conversa e compreender melhor a realidade da pessoa.

17. PARA GUARDAR DESTE CAPÍTULO

Álcool é uma substância psicoativa capaz de produzir intoxicação e dependência.

O álcool também pode estar presente em bebidas tradicionais ou produzidas artesanalmente.

Uma bebida artesanal não é automaticamente perigosa nem automaticamente segura.

Quando a produção não é padronizada, a concentração de álcool pode ser desconhecida e variar entre preparações.

Uma pessoa pode desenvolver dependência tanto de bebidas industrializadas quanto de bebidas artesanais.

Ser uma substância social ou culturalmente aceita não significa ser uma substância sem riscos.

Nem toda pessoa que bebe apresenta dependência.

Problemas relacionados ao álcool podem existir mesmo sem dependência.

Tolerância pode fazer com que uma pessoa consuma quantidades cada vez maiores.

Dependência pode diminuir significativamente a capacidade da pessoa de controlar o consumo.

Algumas pessoas passam a beber para aliviar sintomas que aparecem quando ficam sem álcool.

A abstinência alcoólica pode ser perigosa e, em determinados casos, potencialmente fatal.

O missionário não deve tentar realizar sozinho uma desintoxicação de uma pessoa com dependência importante de álcool.

A pessoa que apresenta dependência continua merecendo dignidade, cuidado e respeito.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).

Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders.
Geneva: World Health Organization; 2024.

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).
Alcohol. Ficha informativa sobre etanol, riscos à saúde, transtornos relacionados ao uso de álcool e dependência. Atualização de 2024.

OMS e UNODC — Organização Mundial da Saúde e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Geneva: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime; 2020.

CAPÍTULO 4 — SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA: QUANDO O ORGANISMO REAGE À FALTA DA SUBSTÂNCIA

1. O que é síndrome de abstinência?

Quando uma pessoa utiliza repetidamente determinadas substâncias, seu organismo pode adaptar-se à presença delas.

Se, depois de um período de uso frequente, essa pessoa interromper ou reduzir significativamente o consumo, podem surgir alterações físicas e psicológicas.

Esse conjunto de manifestações é chamado de síndrome de abstinência.

A abstinência não ocorre da mesma maneira com todas as substâncias nem com todas as pessoas.

Sua intensidade pode depender de fatores como:

- substância utilizada;
- quantidade consumida;
- frequência do consumo;
- tempo de uso;
- condições de saúde;
- idade;
- uso de outras substâncias ou medicamentos;
- histórico anterior de abstinências.

Por isso, não podemos simplesmente perguntar:

“Ele está em abstinência?”

Também precisamos perguntar:

“Abstinência de qual substância e com quais sintomas?”

Essa diferença pode ser decisiva.

2. Abstinência não é simplesmente “vontade de usar”

É importante distinguir dois fenômenos.

Uma pessoa pode apresentar fissura, também chamada de craving: desejo ou impulso intenso de consumir determinada substância.

A síndrome de abstinência é mais ampla.

Ela pode envolver alterações físicas, emocionais e comportamentais decorrentes da interrupção ou redução do consumo depois de determinado padrão de uso.

A pessoa pode apresentar fissura durante a abstinência, mas os dois conceitos não significam exatamente a mesma coisa.

Também é importante compreender que sintomas de abstinência não devem ser interpretados automaticamente como fingimento ou tentativa de conseguir a substância.

O sofrimento pode ser real.

3. Abstinência de cannabis

Depois da interrupção ou redução importante do consumo frequente e prolongado de cannabis, algumas pessoas podem desenvolver síndrome de abstinência.

Entre os sintomas que podem aparecer estão:

- irritabilidade;
- ansiedade ou nervosismo;
- inquietação;
- dificuldade para dormir;
- sonhos intensos ou alterações do sono;
- redução do apetite;
- alterações do humor;
- desejo intenso de voltar a usar cannabis.

Também podem ocorrer sintomas físicos em algumas pessoas, como desconforto abdominal, suor, tremores, dor de cabeça ou mal-estar.

Os sintomas não aparecem necessariamente todos juntos e sua intensidade varia entre as pessoas.

Uma consequência importante é que o desconforto pode favorecer o retorno ao consumo.

A pessoa pode pensar:

“Se eu fumar novamente, isso vai passar.”

E, ao voltar a usar cannabis, pode realmente experimentar alívio de alguns sintomas.

Isso pode dificultar a manutenção da mudança.

4. Abstinência de cannabis é uma emergência?

Na maioria dos casos, a síndrome de abstinência de cannabis não apresenta o mesmo risco de complicações potencialmente fatais encontrado na abstinência grave de álcool.

Isso não significa que ela deva ser desprezada.

Ansiedade intensa, alterações importantes do humor, sofrimento psicológico, insônia persistente ou outros sintomas podem exigir avaliação profissional quando houver atendimento disponível.

E existe uma regra importante:

Nunca devemos presumir que todo sintoma apresentado por alguém que parou de usar cannabis seja causado pela abstinência.

A pessoa também pode estar apresentando outro problema de saúde.

Se houver alteração grave de comportamento, confusão importante, risco de agressão, risco de suicídio, perda de consciência, convulsão ou qualquer situação que coloque a vida em perigo, deve-se procurar atendimento de saúde com urgência.

5. Abstinência de álcool: atenção especial

A abstinência alcoólica exige cuidado muito maior.

Uma pessoa que apresenta dependência importante pode ter adaptado seu organismo à presença frequente do álcool.

Quando o consumo é interrompido ou reduzido abruptamente, o sistema nervoso pode tornar-se excessivamente ativo.

Os primeiros sintomas podem incluir:

- tremores, especialmente nas mãos;
- suor;
- ansiedade;
- agitação;
- irritabilidade;
- náuseas ou vômitos;
- dor de cabeça;
- dificuldade para dormir;
- aumento dos batimentos cardíacos;
- sensação intensa de mal-estar.

Em algumas pessoas, o quadro permanece relativamente leve.

Em outras, pode evoluir.

E não é possível para um missionário sem formação clínica prever com segurança, apenas olhando para a pessoa, quem desenvolverá uma complicação grave.

6. Por que parar de beber pode ser perigoso para algumas pessoas?

Esta afirmação pode parecer estranha:

“O álcool faz mal, mas parar abruptamente também pode representar perigo para uma pessoa fortemente dependente.”

Não significa que a pessoa deva continuar bebendo indefinidamente.

Significa que a interrupção do consumo pode precisar ser acompanhada por profissionais de saúde.

Na dependência física importante, o organismo adaptou-se à presença repetida do álcool.

Quando ele é retirado abruptamente, podem surgir alterações intensas do sistema nervoso.

Por isso, dizer simplesmente:

“A partir de hoje você nunca mais vai beber.”

e tentar manter uma pessoa fortemente dependente sem álcool, sem avaliação de saúde, pode colocá-la em risco.

O objetivo continua sendo superar a dependência.

A questão é como fazer isso com segurança.

7. Convulsões

Uma das possíveis complicações da abstinência alcoólica são as convulsões.

Durante uma convulsão, a pessoa pode:

- perder a consciência;
- cair;
- apresentar movimentos involuntários intensos;
- ficar com o corpo rígido;
- apresentar alterações na respiração;
- machucar-se durante a queda ou durante os movimentos.

Uma convulsão durante possível abstinência alcoólica deve ser considerada uma situação que necessita de atendimento médico urgente.

O que fazer enquanto se busca ajuda?

- afaste objetos que possam machucar a pessoa;
- proteja a cabeça contra impactos, se for possível fazê-lo com segurança;
- não tente segurar os movimentos à força;
- não coloque objetos, alimentos, líquidos ou os dedos dentro da boca;
- quando os movimentos cessaram, se a pessoa estiver respirando, coloque-a de lado quando isso puder ser feito com segurança;
- procure atendimento médico urgente.

A pessoa não “engole a língua”.

Colocar objetos na boca durante uma convulsão pode causar ferimentos e dificultar a respiração.

8. Alucinações

Durante uma abstinência alcoólica grave, algumas pessoas podem apresentar alucinações.

Isso significa perceber algo como real quando aquele estímulo não está presente.

A pessoa pode, por exemplo:

- ver coisas que outras pessoas não estão vendo;
- ouvir vozes ou sons inexistentes;
- sentir coisas sobre o corpo que não estão acontecendo.

Para quem está vivendo aquela experiência, aquilo pode parecer completamente real.

Não é adequado ridicularizar, confrontar agressivamente ou simplesmente dizer:

“Isso é coisa da sua cabeça.”

Alucinações durante possível abstinência alcoólica constituem um sinal de alerta que necessita de avaliação de saúde.

9. Delirium tremens

Uma das complicações mais graves da abstinência alcoólica é o chamado delirium tremens.

Ele pode envolver:

- confusão mental intensa;
- desorientação;
- agitação importante;
- tremores;
- suor intenso;
- alterações dos batimentos cardíacos e da pressão;
- alucinações;
- alterações importantes do estado de consciência.

É uma emergência médica potencialmente fatal.

Uma pessoa nesse estado não deve ser tratada apenas com repouso, alimentação, oração ou acompanhamento informal.

Ela necessita de atendimento médico urgente.

A oração e o apoio espiritual podem acompanhar o cuidado.

Não devem substituir o atendimento médico necessário.

10. NÃO TENTE FAZER UMA DESINTOXICAÇÃO ALCOÓLICA SOZINHO

Esta orientação precisa ficar especialmente clara para missionários e agentes comunitários:

Não tente conduzir sozinho a retirada do álcool de uma pessoa com possível dependência importante.

O missionário pode:

- acolher;

- conversar;
- observar sinais de perigo;
- incentivar a busca por ajuda;
- acompanhar a pessoa;
- envolver familiares ou pessoas de confiança quando apropriado;
- ajudar na procura pelo atendimento disponível;
- oferecer apoio durante o processo de recuperação.

Mas não deve assumir a função de médico.

Medicamentos utilizados no tratamento da abstinência alcoólica precisam de avaliação e orientação profissional.

Não ofereça medicamentos por conta própria.

Também não improvise tratamentos utilizando medicamentos de outras pessoas ou recomendações informais.

11. Como perceber que alguém pode apresentar maior risco?

O missionário não fará diagnóstico.

Entretanto, algumas informações devem aumentar a preocupação e reforçar a necessidade de avaliação profissional.

Pergunte, quando for possível:

Quanto você costuma beber por dia?

Há quanto tempo você bebe dessa maneira?

O que acontece quando fica algumas horas ou um dia sem beber?

Você começa a tremer quando fica sem beber?

Já precisou beber pela manhã para parar de tremer ou aliviar o mal-estar?

Já teve convulsão quando tentou parar?

Já ficou muito confuso, viu ou ouviu coisas quando ficou sem beber?

Já precisou ser levado a um hospital quando tentou parar?

Utiliza medicamentos ou outras substâncias?

Um histórico de abstinência grave, convulsões ou delirium é particularmente importante e deve ser comunicado aos profissionais de saúde.

12. “Mas não temos hospital perto. O que fazemos?”

Essa pergunta é especialmente importante em comunidades com acesso precário aos serviços de saúde.

A falta de estrutura não torna a abstinência grave menos perigosa.

Pelo contrário, exige planejamento antecipado.

Antes de incentivar uma pessoa com possível dependência importante de álcool a interromper abruptamente o consumo, o missionário deve procurar descobrir:

- qual é a unidade de saúde mais próxima;
- como chegar até ela;
- quanto tempo leva o deslocamento;
- quem possui transporte;
- quais serviços funcionam em determinados horários;
- quem pode ser chamado em uma emergência;
- quais recursos existem no município do Luena e na Província do Moxico.

Essas informações devem ser levantadas antes da emergência, e não somente quando alguém estiver convulsionando ou apresentando delirium.

O projeto missionário poderá futuramente construir uma pequena lista de referência com serviços e contatos disponíveis na região.

13. Abstinência não é recuperação

Existe outra distinção fundamental.

Uma pessoa pode atravessar o período de abstinência física e continuar apresentando:

- desejo de consumir;
- hábitos associados ao uso;
- conflitos familiares;
- dificuldades emocionais;
- problemas sociais;
- situações que funcionam como gatilhos;
- dificuldade para reorganizar sua rotina.

Superar a síndrome de abstinência não significa que a dependência foi resolvida.

A desintoxicação, quando necessária, pode ser apenas uma etapa.

A recuperação é um processo mais amplo.

É justamente esse processo que estudaremos nos capítulos seguintes.

14. SINAIS DE ALERTA — PROCURE AJUDA URGENTE

Durante possível abstinência de álcool, procure atendimento de saúde urgentemente diante de sinais como:

- convulsões;
- confusão mental intensa;
- desorientação importante;
- alucinações;
- agitação intensa ou comportamento que coloque alguém em perigo;
- perda de consciência ou dificuldade para despertar;
- alterações importantes da respiração;
- vômitos persistentes com piora do estado geral;
- qualquer deterioração rápida ou situação em que a vida pareça estar em risco.

Quando houver dúvida diante de um quadro grave, é mais seguro procurar avaliação profissional do que presumir que “é apenas abstinência e vai passar”.

15. PARA GUARDAR DESTE CAPÍTULO

Abstinência é o conjunto de manifestações que pode surgir depois da interrupção ou redução significativa de determinadas substâncias após um padrão de uso repetido.

Fissura e síndrome de abstinência não são exatamente a mesma coisa.

Cannabis pode produzir síndrome de abstinência.

A abstinência de cannabis pode causar sofrimento e favorecer o retorno ao uso, mas geralmente não apresenta o mesmo risco médico da abstinência grave de álcool.

A abstinência alcoólica pode ser potencialmente fatal.

Convulsões, alucinações, confusão intensa e delirium são sinais que exigem atenção médica urgente.

Uma pessoa com forte dependência de álcool não deve ser simplesmente submetida a uma interrupção abrupta do consumo sem que os riscos sejam considerados.

Missionários e agentes comunitários não devem tentar realizar sozinhos uma desintoxicação alcoólica.

Não se deve administrar medicamentos por conta própria.

Em comunidades distantes dos serviços de saúde, é necessário planejar previamente como conseguir transporte e atendimento em uma emergência.

A abstinência é apenas uma parte do problema. Superá-la não significa que o processo de recuperação terminou.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization). Management of alcohol withdrawal. WHO mhGAP Evidence Centre. Recomendações para manejo seguro da abstinência alcoólica e prevenção de convulsões e delirium.

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization). Management of drug withdrawal. WHO mhGAP Evidence Centre. Recomendações para manejo da abstinência de cannabis e outras substâncias.

OMS e UNODC — Organização Mundial da Saúde e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Geneva: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime; 2020.

Observação para o Projeto Caminina para Cristo:
Antes do início das atividades de abordagem relacionadas à dependência de álcool, recomenda-se levantar os serviços de saúde disponíveis no Bairro Caminina, no município do Luena e em outras localidades acessíveis da província do Moxico, bem como possibilidades de transporte para situações de emergência.

CAPÍTULO 5 — O CÉREBRO, O COMPORTAMENTO E O CAMINHO DA DEPENDÊNCIA

1. Por que algumas pessoas continuam usando mesmo sofrendo?

Esta é uma das perguntas mais importantes para quem deseja compreender a dependência.

À primeira vista, pode parecer simples:

“Se a droga está destruindo a vida dessa pessoa, por que ela simplesmente não para?”

Mas a dependência não funciona dessa maneira.

Nos capítulos anteriores aprendemos que fatores biológicos, psicológicos, familiares, sociais e ambientais podem participar do desenvolvimento da dependência.

Agora precisamos entender outra parte desse processo:

o cérebro aprende.

E aquilo que o cérebro aprende repetidamente pode transformar-se em comportamento automático, hábito e, em determinadas circunstâncias, comportamento compulsivo.

2. Como o cérebro aprende aquilo que deve ser repetido?

Nosso cérebro possui sistemas envolvidos em recompensa, motivação, aprendizagem e sobrevivência.

Comer quando estamos com fome, beber água quando estamos com sede, relacionar-nos com outras pessoas e realizar atividades prazerosas podem ativar esses sistemas.

Um dos mensageiros químicos envolvidos nesse processo é a dopamina.

A dopamina é principalmente um neurotransmissor no contexto que estamos estudando. Neurotransmissores são substâncias químicas utilizadas pelos neurônios para transmitir sinais.

É comum ouvir que dopamina é simplesmente a “substância do prazer”.

Essa explicação é incompleta.

A dopamina participa fortemente da motivação, aprendizagem e reforço de comportamentos.

Quando algo importante acontece, sinais envolvendo dopamina ajudam o cérebro a aprender:

“Preste atenção nisso. Isso merece ser lembrado. Talvez você deva fazer isso novamente.”

Esse mecanismo é necessário para a vida.

O problema é que determinadas substâncias psicoativas podem interferir nesses sistemas.

3. O que as drogas fazem no cérebro?

Diferentes drogas agem de maneiras diferentes.

Não existe um único mecanismo que explique todas as dependências.

Álcool, cannabis, cocaína, nicotina, opioides e outras substâncias atuam em diferentes receptores e sistemas químicos do cérebro.

Entre os neurotransmissores e sistemas que podem estar envolvidos, dependendo da substância, estão:

- dopamina;
- GABA;
- glutamato;
- serotonina;
- sistemas opioides naturais;
- sistema endocanabinoide.

Portanto, seria incorreto dizer simplesmente:

“A pessoa usa uma droga, o cérebro libera dopamina e ela fica dependente.”

O processo é muito mais complexo.

Entretanto, muitas drogas conseguem direta ou indiretamente produzir alterações importantes nos circuitos relacionados à recompensa e ao reforço.

Com a repetição, o cérebro pode aprender uma associação muito poderosa:

substância → efeito → recompensa → repetir comportamento.

4. A droga começa a ganhar importância

Imagine uma pessoa que experimenta determinada substância e sente um efeito que considera agradável.

Ela utiliza novamente.

E novamente.

Com o tempo, o cérebro começa a associar não somente a substância, mas também diversas coisas ao seu redor com aquela experiência.

Por exemplo:

- determinadas pessoas;
- lugares;
- músicas;
- horários;
- dinheiro no bolso;
- festas;
- discussões;
- solidão;
- sofrimento;
- determinados cheiros;
- determinados caminhos;
- certos estados emocionais.

Esses elementos podem transformar-se em gatilhos.

A pessoa pode passar diante de determinado lugar e sentir vontade de usar.

Pode encontrar determinada pessoa e imediatamente pensar na substância.

Pode receber dinheiro e surgir o desejo.

Pode sentir tristeza, raiva ou solidão e lembrar da droga.

Às vezes isso acontece depois de meses ou mesmo anos sem consumir.

Isso ocorre porque o cérebro aprendeu associações.

5. Quando “querer” começa a transformar-se em “precisar”

Nas fases iniciais, o consumo pode estar fortemente relacionado à busca de prazer.

Com a progressão da dependência, entretanto, a situação pode mudar.

A pessoa pode começar a utilizar a substância não apenas para sentir prazer, mas também para:

- evitar sofrimento;
- aliviar ansiedade;
- diminuir sintomas de abstinência;
- fugir temporariamente de problemas;
- conseguir dormir;
- enfrentar determinadas situações;
- sentir-se “normal”.

A substância começa a ocupar um espaço cada vez maior na vida.

Outras fontes de satisfação podem perder importância.

Família, trabalho, estudo, relacionamentos, alimentação, atividades comunitárias e projetos pessoais podem progressivamente ser deixados de lado.

A vida começa a organizar-se ao redor da substância.

6. Por que mudar apenas a substância pode não ser suficiente?

Imagine uma pessoa que utilizava álcool todos os dias.

Ela para de beber.

Mas continua:

- frequentando os mesmos ambientes;
- encontrando as mesmas pessoas com quem bebia;
- vivendo a mesma rotina;
- reagindo da mesma maneira aos problemas;
- sem outras atividades significativas;
- sem apoio;
- sem aprender novas maneiras de lidar com sofrimento;
- sem reconstruir relacionamentos;
- sem novos objetivos.

A substância saiu.

Mas grande parte da estrutura que sustentava aquele comportamento permaneceu.

Isso ajuda a entender por que a recuperação precisa envolver mais do que simplesmente retirar uma droga.

7. O experimento conhecido como “Rat Park”

Na década de 1970, o psicólogo canadense Bruce Alexander e seus colaboradores realizaram uma série de experimentos com ratos que posteriormente ficou conhecida como Rat Park — “Parque dos Ratos”.

Os pesquisadores questionaram se as condições em que os animais viviam poderiam influenciar o consumo de uma solução contendo morfina.

Em muitos experimentos tradicionais, ratos permaneciam isolados em pequenas gaiolas.

Alexander e sua equipe construíram um ambiente muito maior e enriquecido, onde os animais tinham espaço, alimentação, possibilidade de interação com outros ratos e diferentes estímulos.

Os pesquisadores observaram diferenças no consumo da solução contendo morfina entre animais mantidos em diferentes condições.

O experimento tornou-se conhecido porque ajudou a levantar uma questão importante:

O ambiente também influencia o comportamento relacionado às drogas?

A resposta oferecida pelas pesquisas posteriores é que o ambiente realmente importa.

Mas precisamos tomar cuidado com uma conclusão muito popular que surgiu posteriormente.

Às vezes o Rat Park é contado assim:

“Os ratos felizes não quiseram drogas. Portanto, dependência é causada apenas por sofrimento ou isolamento.”

Essa conclusão é simplista.

O Rat Park não demonstrou que drogas deixam de possuir propriedades capazes de produzir dependência quando alguém vive em boas condições.

Também não demonstrou que todas as dependências são causadas pelo ambiente.

Experimentos com animais possuem limitações e não podem ser simplesmente transportados para toda a complexidade da experiência humana.

A principal lição que podemos utilizar é mais equilibrada:

A substância importa. O cérebro importa. A história da pessoa importa. E o ambiente também importa.

8. A pergunta não deve ser somente “Qual droga você usa?”

Quando encontramos alguém com problemas relacionados ao álcool ou cannabis, é natural perguntar:

“O que essa pessoa está usando?”

Mas existe outra pergunta igualmente importante:

“O que está acontecendo na vida dessa pessoa?”

Precisamos tentar compreender:

- Como ela vive?
- Com quem vive?
- Quais são seus relacionamentos?
- Existe violência?
- Existe fome ou insegurança?
- Existe trabalho?
- Existe isolamento?
- Existem oportunidades?
- Como ela enfrenta sofrimento?
- Quando começou a usar?
- O que estava acontecendo naquela época?
- O que a substância oferece para ela naquele momento?
- O que acontece imediatamente antes de ela procurar a substância?

Isso não significa justificar comportamentos prejudiciais.

Significa tentar compreender a função que a substância passou a exercer na vida daquela pessoa.

9. Um exemplo

Imagine dois homens que consomem álcool.

O primeiro bebe principalmente em determinadas ocasiões sociais.

O segundo percebe que sempre procura álcool depois de conflitos familiares.

Quando está angustiado, bebe.

Quando está sozinho, bebe.

Quando se sente fracassado, bebe.

Depois de algum tempo, seu cérebro começa a aprender uma associação:

sofrimento → álcool → alívio temporário.

Agora imagine que simplesmente retiramos o álcool.

O sofrimento continua.

Os conflitos continuam.

A solidão continua.

Mas retiramos justamente a estratégia que aquela pessoa aprendeu a utilizar para lidar com tudo isso.

É por isso que dizer somente:

“Pare de beber.”

pode ser insuficiente.

Também precisamos ajudá-la a desenvolver outras maneiras de viver e enfrentar aquilo que antes enfrentava através do álcool.

10. O comportamento precisa mudar

Aqui encontramos um princípio fundamental da recuperação:

Interromper o consumo é uma mudança importante, mas a recuperação também exige aprender novas maneiras de viver.

A pessoa pode precisar aprender a:

- reconhecer seus gatilhos;
- evitar determinadas situações de alto risco;
- reorganizar sua rotina;
- construir relacionamentos mais saudáveis;
- pedir ajuda;
- lidar com frustrações;
- controlar impulsos;
- enfrentar conflitos sem recorrer à substância;
- ocupar seu tempo;
- desenvolver responsabilidades;
- reconstruir vínculos familiares;
- encontrar atividades significativas;
- desenvolver novos objetivos.

Isso não acontece de um dia para o outro.

Durante anos, determinados comportamentos podem ter sido repetidos centenas ou milhares de vezes.

A recuperação envolve aprender e praticar novos comportamentos repetidamente.

11. O ambiente também precisa ser considerado

Às vezes pedimos que uma pessoa mude enquanto todo o ambiente ao redor dela continua empurrando-a na direção contrária.

Imagine alguém tentando abandonar o álcool enquanto:

- todos ao redor bebem;
- a bebida está sempre disponível;
- seus principais relacionamentos estão ligados ao consumo;
- não possui trabalho;
- não possui atividades;
- vive conflitos constantes;
- não possui apoio;
- não enxerga perspectivas para o futuro.

Isso não significa que a recuperação seja impossível.

Significa que será mais difícil.

Por isso, quando possível, a recuperação também procura construir fontes alternativas de recompensa e significado:

trabalho, estudo, família, comunidade, amizades saudáveis, atividades físicas, responsabilidades, lazer, projetos pessoais e outras experiências que permitam reconstruir a vida.

Para uma comunidade cristã, a fé, a comunhão, o serviço e o pertencimento comunitário também podem ser fontes importantes de significado e apoio.

Mas o acompanhamento espiritual não deve substituir atendimento médico ou psicológico quando estes forem necessários.

12. Então a droga não é o problema?

Precisamos tomar cuidado com essa conclusão.

Seria errado dizer:

“A droga não é o problema; o problema é apenas aquilo que leva a pessoa à droga.”

A própria substância pode produzir danos, intoxicação, alterações cerebrais, dependência, abstinência e doenças.

Mas também seria incompleto dizer:

“O único problema é a droga.”

Uma compreensão mais adequada seria:

A dependência nasce da interação entre a substância, o indivíduo e o ambiente em que ele vive.

É por isso que duas pessoas podem utilizar a mesma substância e apresentar trajetórias completamente diferentes.

E é por isso que uma recuperação consistente precisa olhar para a pessoa inteira, e não apenas para aquilo que ela consumia.

13. O cérebro pode aprender novamente

Até aqui poderíamos transmitir uma impressão pessimista.

Se o cérebro aprendeu tantas associações relacionadas à droga, existe esperança?

Sim.

O cérebro continua sendo capaz de aprender.

Novas rotinas podem ser construídas.

Novas associações podem ser formadas.

Novas respostas aos gatilhos podem ser praticadas.

Relacionamentos podem ser reconstruídos.

Habilidades podem ser desenvolvidas.

Uma pessoa pode aprender que:

tristeza não precisa significar beber;

dinheiro não precisa significar comprar droga;

conflito não precisa significar fugir para a substância;

encontrar antigos conhecidos não precisa significar voltar ao consumo.

Esse processo exige tempo, repetição, apoio e responsabilidade.

É uma das razões pelas quais recuperação deve ser compreendida como processo, e não apenas como um acontecimento.

14. PARA GUARDAR DESTE CAPÍTULO

Dependência não é explicada por uma única substância química ou uma única região do cérebro.

Dopamina é um neurotransmissor importante para aprendizagem, motivação e reforço de comportamentos; não é simplesmente a “substância do prazer”.

Diferentes drogas atuam de maneiras diferentes no cérebro.

Comportamentos repetidos podem fortalecer associações entre substâncias, pessoas, lugares, emoções e situações.

Essas associações podem transformar-se em gatilhos.

O Rat Park ajudou a demonstrar a importância de considerar o ambiente, mas não provou que ambiente seja a única causa da dependência.

A substância importa, o cérebro importa, a história da pessoa importa e o ambiente importa.

Retirar a droga sem modificar os comportamentos e condições que sustentavam o consumo pode deixar grande parte do problema sem solução.

Não existe recuperação consistente sem algum grau de mudança.

Recuperação envolve aprender novas maneiras de pensar, agir, relacionar-se e enfrentar dificuldades.

O cérebro que aprendeu comportamentos relacionados ao consumo também possui capacidade de aprender novos comportamentos.

Por isso, recuperação é possível.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

NIDA — National Institute on Drug Abuse.

Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Material científico sobre dependência, circuitos de recompensa, aprendizagem, motivação e mudanças comportamentais relacionadas ao uso repetido de drogas.

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).

Recovery-oriented services. WHO mhGAP Evidence Centre. Recomendação sobre cuidado continuado, apoio comunitário e serviços orientados para recuperação.

OMS e UNODC — Organização Mundial da Saúde e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Geneva: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime; 2020.

Alexander, B. K. e colaboradores.

Experimentos conhecidos como Rat Park, desenvolvidos para investigar a influência das condições ambientais sobre o consumo de morfina em animais.

Observação: experimentos realizados com animais ajudam a formular e investigar hipóteses científicas, mas seus resultados não devem ser apresentados como explicação completa do comportamento humano.

CAPÍTULO 6 — RECUPERAÇÃO: RECONSTRUINDO A VIDA

1. O que significa recuperação?

Depois de estudarmos dependência, cannabis, álcool, abstinência e os mecanismos envolvidos no comportamento, chegamos a uma pergunta fundamental:

O que significa recuperar-se?

Uma resposta muito comum seria:

“Recuperar-se é parar de usar drogas.”

Parar ou reduzir o consumo prejudicial pode ser uma parte fundamental do processo.

Mas recuperação é algo mais amplo.

Recuperação envolve mudanças que permitem à pessoa construir uma vida mais saudável, estável, responsável e significativa.

Isso pode envolver:

- mudanças no consumo de substâncias;
- cuidado com a saúde;
- mudança de comportamentos;
- mudança de padrões de pensamento;
- reorganização da rotina;
- reconstrução de relacionamentos;
- desenvolvimento de responsabilidades;
- criação de novas fontes de satisfação;

- participação na família e na comunidade;
- construção de objetivos para o futuro.

Por isso, podemos resumir:

Recuperação não é apenas deixar alguma coisa. É também construir alguma coisa.

2. Quando começa a recuperação?

Não existe uma data universal.

Para algumas pessoas, ela começa quando reconhecem que existe um problema.

Para outras, quando pedem ajuda.

Para outras, quando aceitam conversar sobre aquilo que está acontecendo.

Pode começar depois de uma crise familiar, de um problema de saúde ou de alguma consequência do consumo.

Pode começar depois de muitas tentativas anteriores.

Às vezes, antes de conseguir interromper completamente o consumo, a pessoa já começou a tomar decisões que diminuem danos e aproximam-na de uma mudança maior.

Por isso, o missionário deve aprender a reconhecer pequenos movimentos em direção à mudança.

Uma pessoa que diz:

“Eu não consigo continuar vivendo assim.”

Talvez ainda não tenha resolvido o problema.

Mas essa frase pode representar o começo de algo muito importante.

3. Recuperação não acontece da mesma maneira para todos

Não existe uma única história de recuperação.

Algumas pessoas conseguem interromper o consumo e mantêm abstinência por longos períodos.

Outras passam por diversas tentativas.

Algumas precisam de tratamento médico.

Outras necessitam de acompanhamento psicológico ou social.

Algumas participam de grupos de ajuda mútua.

Outras precisam de acolhimento residencial por determinado período.

Muitas se beneficiam de uma combinação dessas formas de apoio.

Família, comunidade, trabalho, estudo, espiritualidade e relacionamentos saudáveis também podem exercer papéis importantes.

Por isso, devemos evitar afirmações como:

“Se funcionou para mim, vai funcionar para você.”

A experiência de alguém que conseguiu se recuperar pode oferecer esperança.

Mas ela não se transforma automaticamente em uma receita para todas as outras pessoas.

4. Abstinência e recuperação não são sinônimos

Esta diferença é fundamental.

Abstinência significa não consumir determinada substância.

Recuperação envolve mudanças mais amplas na maneira de viver.

Imagine alguém que deixou de beber há algumas semanas, mas:

- continua frequentando ambientes diretamente relacionados ao consumo;
- mantém comportamentos violentos;
- continua mentindo constantemente;
- não assume responsabilidades;
- não consegue reconhecer situações de risco;
- permanece isolado;
- não construiu nenhuma nova rotina;
- não procura ajuda quando percebe dificuldades.

Essa pessoa pode estar abstinente.

Mas ainda existem muitas áreas que precisam ser trabalhadas.

Por outro lado, cada mudança positiva pode fortalecer o processo:

- estabelecer uma rotina;
- cuidar da saúde;
- reconstruir confiança;
- trabalhar;
- estudar;
- cumprir compromissos;
- desenvolver relacionamentos saudáveis;
- aprender a lidar com frustrações;
- pedir ajuda.

Por isso:

Abstinência pode ser parte da recuperação, mas recuperação é reconstrução de vida.

5. Não existe recuperação sem mudança

No capítulo anterior aprendemos que o cérebro cria associações entre substâncias, lugares, pessoas, sentimentos e comportamentos.

Por isso, quando alguém deseja construir uma recuperação consistente, alguma coisa precisa mudar.

Às vezes muitas coisas.

Pode ser necessário mudar:

- lugares frequentados;
- determinadas companhias;
- horários;
- maneiras de gastar dinheiro;
- formas de reagir à raiva;
- maneiras de enfrentar tristeza;
- hábitos;
- prioridades;
- rotina;
- relacionamentos;
- respostas aos conflitos;
- maneiras de interpretar determinadas situações.

Isso não significa abandonar todas as pessoas ou fugir de todos os lugares.

Significa aprender a reconhecer:

“O que, na minha vida, favorece o consumo?”

e:

“O que, na minha vida, favorece minha recuperação?”

6. Identificando gatilhos

Chamamos de gatilho uma situação interna ou externa que pode despertar pensamentos, lembranças, emoções ou desejos associados ao consumo.

Um gatilho pode ser externo:

- passar por determinado lugar;
- encontrar alguém;
- receber dinheiro;
- participar de determinada festa;
- ver uma bebida;
- sentir determinado cheiro.

Mas também pode ser interno:

- raiva;
- tristeza;
- solidão;
- ansiedade;
- vergonha;
- frustração;
- euforia;
- sensação de rejeição.

É importante perceber algo:

gatilho não significa recaída inevitável.

O gatilho representa uma situação de risco.

A recuperação envolve aprender a reconhecer essas situações e desenvolver respostas diferentes.

7. Mudando a resposta ao gatilho

Imagine que durante anos alguém respondeu à tristeza bebendo.

O caminho aprendido foi:

tristeza → álcool.

Na recuperação, será necessário construir outro caminho.

Por exemplo:

tristeza → reconhecer o sentimento → procurar alguém → conversar → utilizar uma estratégia saudável → atravessar aquele momento sem beber.

No início, essa nova resposta pode parecer difícil.

A antiga foi praticada muitas vezes.

A nova ainda está sendo aprendida.

Mas, conforme novos comportamentos são repetidos, eles podem tornar-se mais naturais.

Isso é uma parte fundamental da recuperação:

não podemos controlar todas as situações que acontecerão conosco, mas podemos aprender novas maneiras de responder a elas.

8. Mudança de padrão de pensamento

Recuperação não envolve apenas mudar aquilo que fazemos.

Também pode exigir aprender a reconhecer e modificar maneiras de pensar que foram construídas e reforçadas ao longo do tempo.

Pensamentos, emoções e comportamentos frequentemente estão relacionados.

Imagine a seguinte situação:

Uma pessoa em recuperação recebe dinheiro.

O dinheiro, por experiências anteriores, funciona como um gatilho.

Quase automaticamente surge o pensamento:

“Só hoje eu posso beber um pouco.”

Depois:

“Desta vez eu vou conseguir controlar.”

Em seguida:

“Eu trabalhei para conseguir esse dinheiro. Tenho direito de fazer o que quiser.”

Esses pensamentos podem aumentar o desejo e aproximar a pessoa do comportamento antigo.

Por isso, uma parte importante da recuperação é aprender a perceber o próprio pensamento antes de simplesmente obedecê-lo.

Pensamento não é ordem

Um pensamento pode aparecer sem que a pessoa tenha escolhido conscientemente produzi-lo.

Isso não significa que ela precise transformá-lo em ação.

A pessoa pode pensar:

“Quero beber.”

e aprender a responder:

“Estou com vontade de beber, mas não preciso beber.”

Pode pensar:

“Só uma vez não vai fazer diferença.”

e perguntar:

“O que aconteceu das outras vezes em que pensei assim?”

Pode pensar:

“Eu mereço beber porque tive um dia difícil.”

e aprender a perguntar:

“Existe outra maneira de lidar com este dia difícil sem colocar minha recuperação em risco?”

Isso é mudança de padrão de pensamento.

Não significa impedir que pensamentos antigos apareçam.

Significa aprender a não aceitá-los automaticamente como verdade ou como ordem.

Alguns padrões de pensamento que podem aumentar o risco

Durante a recuperação, podem aparecer pensamentos como:

“Agora eu consigo controlar.”

“Só hoje.”

“Só uma bebida não fará mal.”

“Ninguém vai descobrir.”

“Já estou bem, não preciso mais de ajuda.”

“Depois de tudo que aconteceu comigo, eu mereço isso.”

“Se já errei uma vez, então perdi tudo.”

“Nunca vou conseguir mudar.”

“Todo mundo está contra mim.”

Nem todo pensamento desse tipo significa que haverá recaída.

Mas aprender a reconhecê-los pode permitir que a pessoa intervenha antes que o pensamento se transforme em decisão e comportamento.

Aprendendo uma nova maneira de pensar

Mudar um padrão de pensamento não significa simplesmente repetir frases positivas.

Também não significa negar problemas reais.

Significa aprender a examinar aquilo que estamos pensando.

Algumas perguntas podem ajudar:

O que estou pensando neste momento?

O que aconteceu antes desse pensamento?

Esse pensamento está me aproximando ou me afastando da vida que quero construir?

Estou tentando justificar alguma coisa que sei que me coloca em risco?

Estou olhando apenas para o prazer imediato e esquecendo as consequências?

O que minhas experiências anteriores me ensinaram sobre essa situação?

Existe outra maneira de interpretar o que está acontecendo?

Que decisão estará de acordo com a pessoa que estou tentando me tornar?

Com o tempo, pensamentos antigos podem ser reconhecidos mais rapidamente e novas respostas podem ser praticadas.

Pensamento, comportamento e recuperação

Podemos imaginar uma situação assim:

Gatilho → pensamento automático → desejo → comportamento antigo

Por exemplo:

discussão familiar → “ninguém me entende” → vontade de beber → consumo de álcool.

Durante a recuperação, a pessoa pode aprender a interromper essa sequência:

discussão familiar → “estou com raiva e minha mente está procurando a antiga saída” → reconhecer o risco → afastar-se momentaneamente da situação → conversar com alguém de confiança → não beber.

O problema familiar talvez continue existindo.

A diferença é que a resposta começou a mudar.

É assim que novos padrões vão sendo construídos.

Uma mudança mais profunda

Com o tempo, a mudança pode atingir pensamentos ainda mais profundos sobre a própria identidade.

A pessoa pode ter vivido durante anos pensando:

“Eu sou assim mesmo.”

“Não consigo terminar nada.”

“Ninguém pode confiar em mim.”

“Minha vida já acabou.”

“Nunca vou conseguir viver sem isso.”

A recuperação permite começar a questionar essas conclusões.

Não através de ilusões, mas através de novas experiências e novos comportamentos.

Cada compromisso cumprido.

Cada situação difícil atravessada sem consumir.

Cada responsabilidade assumida.

Cada relacionamento reconstruído.

Cada decisão diferente.

Tudo isso oferece novas evidências de que a maneira antiga de enxergar a si mesmo não precisa determinar o futuro.

Por isso, mudança de comportamento e mudança de pensamento caminham juntas:

novos pensamentos podem favorecer novos comportamentos, e novos comportamentos também podem fortalecer novas maneiras de pensar.

Recuperação envolve aprender não apenas:

“Eu preciso viver de maneira diferente.”

Mas também:

“Eu preciso aprender a pensar de maneira diferente sobre aquilo que acontece comigo e sobre como escolho responder.”

9. A importância da rotina

Uma vida completamente desorganizada pode aumentar situações de risco.

Por isso, construir uma rotina costuma ser uma ferramenta importante.

Coisas aparentemente simples podem ter grande valor:

- acordar em horários regulares;
- cuidar da higiene;
- alimentar-se;
- cumprir compromissos;
- trabalhar quando houver oportunidade;
- estudar;
- participar de atividades comunitárias;
- praticar atividades saudáveis;
- reservar tempo para descanso;

- manter contato com pessoas de apoio.

Rotina não significa transformar a vida em uma prisão.

Significa diminuir o espaço do caos.

Com o tempo, atividades saudáveis também podem tornar-se fontes de satisfação, pertencimento e propósito.

10. A pessoa precisa recuperar responsabilidades

Acolher alguém não significa retirar dela toda responsabilidade.

Existe uma diferença entre:

culpabilizar

e

responsabilizar.

Culpabilizar é simplesmente condenar:

“Você destruiu tudo porque quis.”

Responsabilizar é ajudar a pessoa a reconhecer:

“Algumas coisas aconteceram durante minha dependência. Agora preciso participar da reconstrução da minha vida.”

Isso pode significar:

- cumprir compromissos;
- cuidar da própria saúde;
- participar do tratamento;
- reparar danos quando possível e apropriado;
- reorganizar finanças;
- assumir responsabilidades familiares;
- aprender com consequências;
- pedir desculpas quando necessário;
- reconstruir confiança gradualmente.

A dependência ajuda a explicar muitos comportamentos.

Mas recuperação também envolve assumir responsabilidade pelas próximas escolhas.

11. Confiança não volta imediatamente

Durante períodos de consumo problemático podem ocorrer mentiras, promessas não cumpridas, desaparecimentos, dívidas, conflitos e outras situações que prejudicam relacionamentos.

Quando a pessoa começa a mudar, pode pensar:

“Estou há algumas semanas sem usar. Por que ninguém confia em mim?”

Porque confiança não é recuperada apenas com palavras.

Ela é reconstruída principalmente através de comportamentos consistentes ao longo do tempo.

Uma promessa pode ser feita em segundos.

Confiança pode levar meses ou anos para ser reconstruída.

Isso pode ser frustrante, mas faz parte do processo.

A pessoa precisa aprender:

“Não posso exigir confiança. Posso construir condições para que ela volte.”

12. Recuperação também precisa de pertencimento

No capítulo sobre o cérebro vimos a importância do ambiente.

Agora isso ganha uma aplicação prática.

Quando uma pessoa deixa um ambiente relacionado ao consumo, pode surgir um vazio.

Seus antigos companheiros talvez fossem também sua principal convivência social.

Seus lugares de consumo talvez fossem os lugares onde ela se sentia pertencente a algum grupo.

Retirar tudo isso sem construir novas relações pode produzir isolamento.

Por isso, redes saudáveis são importantes:

- família, quando possível e segura;
- amigos que apoiem a mudança;

- comunidade;
- grupos de apoio;
- profissionais;
- atividades de trabalho;
- estudo;
- esporte;
- igreja e outras redes comunitárias.

A recuperação precisa oferecer mais do que:

“Não volte para lá.”

Precisamos também perguntar:

“Para onde essa pessoa poderá ir?”

13. Trabalho, estudo e propósito

Uma pessoa não vive apenas para “não usar drogas”.

Imagine acordar todos os dias com um único objetivo:

“Hoje eu preciso conseguir não beber.”

Isso pode ser necessário no começo.

Mas uma vida inteira precisa de mais.

Com o tempo, perguntas diferentes precisam surgir:

O que quero construir?

O que posso aprender?

Como posso contribuir?

Que responsabilidades posso assumir?

Que futuro desejo construir?

Trabalho, educação, atividades comunitárias, cuidado familiar, projetos pessoais e outras formas de participação social podem ajudar a construir identidade e propósito para além da dependência.

A pessoa deixa progressivamente de enxergar-se apenas como:

“alguém tentando não usar drogas”

e começa a reconstruir outras identidades:

trabalhador, estudante, pai, mãe, filho, amigo, membro da comunidade, profissional, voluntário e tantas outras possibilidades.

14. A família também pode precisar de ajuda

A dependência raramente afeta apenas quem utiliza a substância.

Famíliares podem passar anos vivendo:

- medo;
- raiva;
- frustração;
- desconfiança;
- conflitos;
- dificuldades financeiras;
- expectativas quebradas.

Quando a pessoa começa a recuperação, a família nem sempre consegue simplesmente esquecer tudo o que aconteceu.

Ela também pode precisar de orientação, apoio e tempo.

Por isso, quando for apropriado e seguro, envolver familiares no processo pode ajudar.

Mas existem situações de violência, abuso ou relações prejudiciais nas quais a aproximação familiar precisa ser avaliada com cuidado.

Família pode ser uma grande fonte de apoio, mas não devemos presumir que todo ambiente familiar seja saudável.

15. O papel da comunidade cristã

No contexto do projeto Caminina para Cristo, a comunidade cristã pode desempenhar um papel importante.

A igreja pode oferecer:

- acolhimento;
- pertencimento;
- relacionamentos;

- acompanhamento;
- oportunidades de servir;
- apoio material quando necessário e possível;
- ensino;
- oração;
- esperança;
- espaço para reconstrução de vínculos.

Mas existe um cuidado fundamental.

A dependência não deve ser tratada simplesmente como:

“falta de oração”

ou

“falta de fé”.

Uma pessoa pode amar a Deus e ainda precisar de tratamento médico.

Pode orar e precisar de acompanhamento psicológico.

Pode frequentar a igreja e precisar de ajuda social.

Pode experimentar transformação espiritual e ainda precisar aprender novos comportamentos e novas maneiras de pensar.

Essas coisas não precisam competir entre si.

O cuidado espiritual pode caminhar junto com o cuidado médico, psicológico e social.

16. Conversão não significa que todo problema desapareceu

Para um trabalho missionário cristão, esta distinção merece atenção especial.

Uma pessoa pode encontrar-se com Cristo e experimentar uma transformação profunda de fé, valores e direção de vida.

Isso pode representar uma força extraordinária em sua recuperação.

Mas anos de comportamentos aprendidos, padrões de pensamento, relacionamentos prejudicados, problemas de saúde e consequências sociais não desaparecem necessariamente de maneira imediata.

A pessoa ainda pode precisar:

- aprender a reconhecer gatilhos;
- reconhecer pensamentos que favorecem antigos comportamentos;
- reconstruir sua rotina;
- afastar-se de determinadas situações;
- receber tratamento;
- reparar relacionamentos;
- aprender a administrar dinheiro;
- reconstruir confiança;
- desenvolver disciplina;
- pedir ajuda.

A fé pode dar sentido, esperança, comunidade e motivação para essa caminhada.

Mas discipulado também envolve caminhada, aprendizado e amadurecimento.

17. A recuperação não é uma linha reta

Muitas pessoas imaginam a recuperação assim:

dependência → parar de usar → nunca mais ter dificuldades.

Na realidade, o processo pode apresentar avanços e dificuldades.

Pode haver:

- períodos de grande motivação;
- momentos de desânimo;
- desejos intensos;
- conflitos;
- dificuldades;
- lapsos;
- recaídas;
- retomadas.

Isso não significa que recaídas sejam necessárias ou que devam ser tratadas como algo sem importância.

Significa apenas que dificuldades podem acontecer e precisam ser enfrentadas adequadamente.

Uma recaída pode produzir consequências graves.

Por isso, prevenção é fundamental.

Mas quando acontece, a pergunta não deve ser apenas:

“Por que você fez isso novamente?”

Também precisamos perguntar:

“O que aconteceu antes disso e o que podemos aprender para reduzir o risco de acontecer novamente?”

Estudaremos lapso e recaída em um capítulo específico.

18. Recuperação precisa de acompanhamento

Os primeiros dias sem determinada substância podem receber muita atenção.

Mas, depois de algum tempo, é comum que as pessoas ao redor pensem:

“Agora ele está bem.”

E o acompanhamento diminui.

Entretanto, muitas dificuldades aparecem justamente quando a pessoa começa a retornar à vida cotidiana.

Ela volta a enfrentar:

- dinheiro;
- conflitos;
- relacionamentos;
- trabalho;
- frustrações;
- antigos conhecidos;
- responsabilidades;
- lembranças;
- oportunidades de consumo.

Por isso, recuperação não deve ser entendida apenas como uma intervenção de emergência.

Quando possível, é importante construir acompanhamento continuado.

19. Como o missionário pode ajudar?

O missionário não precisa tornar-se terapeuta.

Seu papel pode ser extremamente importante sem ultrapassar seus limites.

Ele pode:

- ouvir sem humilhar;
- ajudar a pessoa a reconhecer problemas;
- identificar situações de risco;
- incentivar mudanças;
- ajudá-la a reconhecer padrões de pensamento prejudiciais;
- acompanhar progressos;
- reconhecer pequenas conquistas;
- incentivar tratamento quando disponível;
- aproximar a pessoa de redes saudáveis;
- envolver familiares quando apropriado;
- ajudar na construção de rotina;
- estimular responsabilidade;
- oferecer acompanhamento espiritual;
- ajudar a pessoa a encontrar propósito e pertencimento.

E talvez uma das coisas mais importantes:

continuar enxergando uma pessoa onde outros passaram a enxergar apenas um problema.

20. Algumas perguntas úteis

Durante o acompanhamento, o missionário pode perguntar:

O que você gostaria que mudasse na sua vida?

O que normalmente acontece antes de você beber ou usar cannabis?

Quais pessoas ou lugares aumentam sua vontade de usar?

O que costuma passar pela sua cabeça quando a vontade aparece?

Existe algum pensamento que você costuma usar para justificar o consumo?

Quem poderia ajudá-lo quando estiver em dificuldade?

O que você poderia fazer em vez de consumir quando esse desejo aparecer?

Que atividade saudável poderia fazer parte da sua rotina?

Existe algum relacionamento que precisa ser reconstruído?

Que responsabilidade você poderia começar a assumir?

O que você gostaria de estar fazendo daqui a seis meses?

Que tipo de pessoa você deseja tornar-se?

Perceba que essas perguntas não tratam apenas da droga.

Elas tratam da vida.

21. Recuperação é construir uma vida que valha a pena preservar

Existe uma diferença importante entre dizer:

“Você precisa abandonar essa vida.”

e ajudar alguém a descobrir:

“Existe outra vida que pode ser construída.”

Se retirarmos a substância e deixarmos apenas um vazio, a pessoa continuará vulnerável.

Por isso, recuperação envolve substituir progressivamente:

isolamento por pertencimento;

caos por alguma estrutura;

impulsividade por novas respostas;

padrões de pensamento prejudiciais por maneiras mais conscientes de interpretar e responder às situações;
desesperança por possibilidades;
ociosidade por atividades significativas;
relações destrutivas por relações mais saudáveis;
uma identidade centrada na droga por uma identidade muito maior do que ela.
A recuperação não significa construir uma vida sem problemas.
Significa aprender a viver os problemas da vida sem precisar retornar continuamente à substância como resposta.

22. PARA GUARDAR DESTE CAPÍTULO

Recuperação é mais ampla do que abstinência.
Recuperação envolve reconstrução de vida.
Não existe uma única trajetória de recuperação que funcione igualmente para todas as pessoas.
Mudanças de comportamento são fundamentais para uma recuperação consistente.
Recuperação também envolve reconhecer e modificar padrões de pensamento que favorecem comportamentos antigos.
Pensamento não é ordem. Um pensamento pode ser reconhecido, examinado e respondido de outra maneira.
Pensamentos, emoções e comportamentos podem influenciar uns aos outros.
Gatilhos podem ser externos ou internos, mas não determinam inevitavelmente uma recaída.
Novas respostas aos gatilhos podem ser aprendidas e praticadas.
Novos pensamentos podem favorecer novos comportamentos, e novos comportamentos também podem fortalecer novas maneiras de pensar.
Rotina, responsabilidade, relacionamentos saudáveis e propósito podem fortalecer a recuperação.
Confiança é reconstruída por comportamentos consistentes ao longo do tempo.
A pessoa precisa de algo para construir, não apenas de algo para abandonar.
A família pode ser uma fonte importante de apoio, mas nem todo ambiente familiar é saudável.
A comunidade cristã pode oferecer fé, pertencimento, esperança e apoio, sem substituir cuidados médicos, psicológicos ou sociais quando necessários.
Conversão espiritual não significa que todos os padrões de pensamento, comportamentos aprendidos e consequências da dependência desaparecerão imediatamente.
Dificuldades podem ocorrer durante a recuperação e precisam ser enfrentadas, não escondidas.
O missionário pode exercer um papel muito importante sem tentar ocupar o lugar de médico ou terapeuta.
Recuperação é aprender a construir uma vida na qual a substância deixe progressivamente de ocupar o centro.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).
OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).

Recovery-oriented services. WHO mhGAP Evidence Centre; 2023. Recomenda abordagens voluntárias de cuidado continuado, apoio comunitário, manejo de caso, atividades ocupacionais e apoio de pares para adultos com dependência de drogas.

Materiais sobre tratamento, reintegração social e cuidado continuado de pessoas com transtornos relacionados ao uso de drogas.

OMS — Organização Mundial da Saúde (WHO — World Health Organization).

Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2023.

NIDA — National Institute on Drug Abuse.

OMS e UNODC — Organização Mundial da Saúde e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Geneva: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime; 2020.

Abordagens utilizadas no tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias que trabalham, entre outros aspectos, a identificação de situações de risco, pensamentos, respostas comportamentais e desenvolvimento de estratégias alternativas de enfrentamento.

NIDA — National Institute on Drug Abuse.

Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. Material científico sobre dependência, mudanças cerebrais e comportamentais, tratamento e recuperação.

CAPÍTULO 7 – REDUÇÃO DE DANOS: PROTEGER A VIDA ENQUANTO A MUDANÇA ACONTECE

Quando falamos em recuperação da dependência química, nosso desejo é que a pessoa consiga abandonar o uso da substância e construir uma nova maneira de viver. Porém, nem todas as pessoas conseguem chegar a esse ponto imediatamente.

Algumas ainda estão usando. Outras desejam parar, mas não conseguem. Há aquelas que nem sequer reconhecem que precisam de ajuda. E existem pessoas que tentam parar várias vezes antes de conseguirem manter a abstinência.

É nesse contexto que precisamos compreender a redução de danos.

1. O que significa redução de danos?

Redução de danos é um conjunto de atitudes e estratégias destinadas a diminuir os prejuízos provocados pelo uso de álcool e outras drogas, mesmo quando a pessoa ainda não conseguiu interromper completamente o consumo.

Isso não significa dizer que usar drogas é bom.

Também não significa desistir da recuperação.

Significa reconhecer uma realidade: enquanto aquela pessoa ainda usa uma substância, sua vida continua tendo valor e precisa ser protegida.

Imagine alguém que esteja atravessando uma estrada perigosa. Nosso objetivo pode ser ajudá-lo a sair daquela estrada. Mas, enquanto ele ainda estiver nela, não vamos deixá-lo ser atropelado simplesmente porque ele ainda não conseguiu chegar ao outro lado.

Redução de danos começa com uma pergunta muito simples:

“O que podemos fazer agora para diminuir o risco e preservar esta vida?”

2. Redução de danos não é incentivo ao uso

Esse é um dos pontos que mais geram confusão.

Algumas pessoas acreditam que orientar alguém sobre como diminuir os riscos relacionados ao consumo significa autorizar ou incentivar o uso da droga.

Não é isso.

Podemos desejar que uma pessoa pare completamente de beber e, ao mesmo tempo, orientá-la a não dirigir depois de consumir álcool.

Podemos desejar que alguém abandone as drogas e, ao mesmo tempo, tentar impedir que essa pessoa se exponha a violência, doenças, acidentes ou outras situações que possam levá-la à morte.

Uma coisa não anula a outra.

Preservar a vida hoje pode permitir que a recuperação aconteça amanhã.

3. Começar pela realidade da pessoa

Um erro comum no cuidado com pessoas dependentes é oferecer ajuda somente sob determinadas condições:

«“Quando você decidir parar, procure-me.”»

Mas algumas pessoas ainda não conseguem tomar essa decisão.

Como vimos nos capítulos anteriores, a dependência pode modificar profundamente o comportamento, a tomada de decisões, a percepção do risco e a capacidade de controlar o consumo.

Por isso, quem trabalha com essas pessoas precisa aprender a encontrá-las no ponto em que elas estão.

Podemos perguntar:

Você deseja parar?

Se a resposta for sim, podemos ajudá-la nesse caminho.

Mas também podemos encontrar alguém que diga:

“Eu ainda não consigo parar.”

Nesse caso, outra pergunta se torna possível:

“Então, o que podemos fazer para que você corra menos riscos enquanto ainda não consegue?”

Isso mantém aberta a porta do cuidado.

4. Exemplos simples de redução de danos

A redução de danos depende da substância, da pessoa e da realidade em que ela vive.

Algumas atitudes podem parecer pequenas, mas podem evitar consequências graves.

Por exemplo:

- não dirigir nem operar máquinas após consumir álcool ou outras drogas;
- não misturar diferentes substâncias;
- não compartilhar objetos utilizados para consumir drogas;
- procurar atendimento diante de sinais de intoxicação ou alteração importante da consciência;
- não abandonar uma pessoa inconsciente depois do consumo;
- cuidar da alimentação e da hidratação;
- procurar tratamento para feridas, infecções e outros problemas de saúde;
- manter contato com familiares, agentes comunitários ou pessoas de confiança;
- aproximar a pessoa dos serviços de saúde disponíveis;
- incentivar progressivamente a procura por tratamento.

É importante perceber que nenhuma dessas medidas transforma o consumo em algo seguro.

O objetivo é diminuir riscos enquanto trabalhamos para uma mudança maior.

5. O álcool exige um cuidado especial

No caso da dependência de álcool existe uma questão especialmente importante.

Uma pessoa que bebe grandes quantidades diariamente e desenvolveu dependência física pode correr riscos ao interromper o consumo de maneira abrupta e sem acompanhamento adequado.

Como vimos no capítulo sobre abstinência, alguns casos podem evoluir com confusão intensa, convulsões e outras complicações graves.

Por isso, dizer simplesmente:

«“Pare de beber agora.”»

nem sempre é uma orientação suficiente.

Quando existem sinais de dependência física importante, a interrupção deve ser avaliada por profissionais de saúde sempre que isso for possível.

O objetivo continua sendo superar a dependência. Mas queremos que isso aconteça com segurança.

6. A pessoa é maior do que a droga

Talvez uma das maiores contribuições da redução de danos seja mudar a maneira como enxergamos quem está diante de nós.

Não estamos cuidando de “um alcoólatra”.

Não estamos cuidando de “um drogado”.

Estamos diante de uma pessoa que desenvolveu um problema relacionado ao uso de uma substância.

Ela continua tendo história, família, sentimentos, capacidades, sonhos e dignidade.

Quando enxergamos somente a droga, deixamos de enxergar a pessoa.

E quando alguém passa anos sendo tratado apenas como um problema, pode começar a acreditar que realmente não existe mais nada dentro dele além daquele problema.

O cuidado precisa comunicar outra mensagem:

“Sua vida ainda tem valor.”

7. Redução de danos não é o fim do caminho

Precisamos deixar isso muito claro.

Para muitas pessoas com dependência, especialmente quando o consumo já trouxe graves prejuízos, a abstinência pode ser um objetivo importante da recuperação.

Mas a redução de danos pode funcionar como uma ponte.

Uma pessoa talvez não esteja preparada hoje para dizer:

“Nunca mais vou usar.”

Mas talvez esteja preparada para dizer:

“Hoje vou aceitar ajuda.”

Depois:

“Vou diminuir algumas situações de risco.”

Depois:

“Quero entender por que estou usando.”

E talvez, mais adiante:

“Quero parar.”

Mudanças profundas frequentemente acontecem por etapas.

8. Redução de danos e mudança de comportamento

Aqui precisamos ligar este capítulo ao anterior.

Reduzir danos não significa apenas diminuir a quantidade de uma substância.

Se alguém diminui o consumo, mas continua frequentando os mesmos ambientes de risco, repetindo os mesmos comportamentos e utilizando a droga como resposta para todos os seus problemas emocionais, uma parte importante da dependência continua funcionando.

Por isso, mesmo durante uma estratégia de redução de danos, podemos começar a trabalhar:

- rotina;

- relacionamentos;
- maneiras de enfrentar frustrações;
- reconhecimento de gatilhos;
- resolução de problemas;
- responsabilidade pelas escolhas;
- reconstrução dos vínculos familiares;
- trabalho e atividades produtivas;
- espiritualidade;
- novos objetivos de vida.

A recuperação começa a ganhar força quando a pessoa não apenas tenta retirar uma substância da vida, mas começa a construir uma vida na qual aquela substância deixa de ocupar o centro.

9. Redução de danos na realidade de Caminina

Em uma comunidade, muitas vezes o primeiro contato não acontecerá dentro de uma clínica ou de um centro especializado.

Pode acontecer em uma casa.

Na rua.

Na igreja.

Durante uma visita.

Em uma conversa com uma família.

Talvez Eduardo e os demais agentes encontrem uma pessoa alcoolizada que ainda não deseja tratamento.

O primeiro trabalho não precisa ser uma discussão.

Pode começar com relacionamento.

Ouvir.

Conhecer aquela pessoa.

Entender sua história.

Identificar necessidades urgentes.

Orientar a família.

Perceber riscos.

Ajudá-la a chegar a um serviço de saúde quando necessário.

E continuar presente.

Esse relacionamento pode abrir uma porta que uma discussão jamais abriria.

10. E onde entra a fé?

Para o projeto Caminina para Cristo, existe ainda uma dimensão fundamental.

Creemos na transformação que Jesus Cristo pode realizar na vida humana.

Mas anunciar essa esperança não significa ignorar o sofrimento presente da pessoa.

Jesus frequentemente se aproximava das pessoas antes que suas vidas estivessem organizadas. Ele encontrava seres humanos feridos, marginalizados e rejeitados.

Por isso, podemos anunciar transformação sem abandonar quem ainda está no caminho.

Podemos dizer:

“Existe uma vida diferente desta.”

E ao mesmo tempo demonstrar:

“Enquanto você ainda está lutando para chegar até ela, nós não vamos deixar de enxergar você como alguém que merece cuidado.”

A fé cristã não diminui o valor do cuidado. Pelo contrário, aumenta nossa responsabilidade diante daquele que sofre.

“Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me.”

Mateus 25:35

PARA REFLETIR

Imagine que um homem de Caminina procure Eduardo e diga:

“Eu sei que a bebida está destruindo minha família, mas não consigo parar.”

Existem pelo menos duas maneiras de responder.

A primeira seria:

“Quando você estiver disposto a parar, volte aqui.”

A segunda:

“Vamos começar de onde você está. Quero entender o que está acontecendo e ver o que podemos fazer para proteger sua vida e ajudá-lo a caminhar em direção à mudança.”

A segunda resposta não aprova a bebida.

Ela simplesmente se recusa a abandonar o homem.

E talvez seja justamente nesse relacionamento que comece sua recuperação.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

Redução de danos não significa desistir da abstinência ou aceitar passivamente o consumo de drogas. Significa proteger a vida, diminuir riscos e manter aberta a porta do cuidado enquanto a pessoa avança em direção a mudanças maiores.

Às vezes, o primeiro passo da recuperação não é:

“Eu parei.”

Pode ser simplesmente:

“Eu aceitei ajuda.”

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders. 3. ed. Genebra: WHO, 2023. [Organização Mundial da Saúde](#)
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Management of alcohol withdrawal. WHO mhGAP Evidence Centre. Orientações para manejo seguro da abstinência alcoólica e identificação de situações que exigem maior nível de cuidado. [Organização Mundial da Saúde](#)
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. Genebra: WHO, 2024. [Organização Mundial da Saúde](#)
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); UNODC. International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition incorporating results of field-testing. Genebra: WHO; UNODC, 2020. [Organização Mundial da Saúde](#)

- [Organização Mundial da Saúde](#)

CAPÍTULO 8 – LAPSO, RECAÍDA E PREVENÇÃO: QUANDO A RECUPERAÇÃO ENCONTRA DIFICULDADES

A recuperação da dependência química raramente acontece como uma linha reta.

Existem avanços, dificuldades, mudanças, crises e momentos em que antigos pensamentos e comportamentos podem voltar a aparecer.

Algumas pessoas conseguem manter a abstinência desde o início. Outras passam por episódios de retorno ao uso antes de conseguirem estabelecer uma recuperação mais estável.

Por isso, quem acompanha uma pessoa dependente precisa compreender uma diferença muito importante:

um lapso não precisa se transformar em uma recaída.

1. O que é um lapso?

Chamamos de lapso um episódio pontual de retorno ao consumo depois de um período de abstinência ou mudança.

Imagine alguém que permaneceu meses sem beber.

Depois de uma discussão familiar, encontra antigos amigos e bebe novamente naquela noite.

No dia seguinte, percebe o que aconteceu, procura ajuda e retoma imediatamente seu processo de recuperação.

Houve um retorno ao consumo.

Mas isso não significa necessariamente que todo o processo anterior foi perdido.

O problema pode se tornar muito maior quando a pessoa pensa:

“Já estraguei tudo mesmo.”

Esse pensamento pode levá-la a continuar bebendo ou usando a substância.

Por isso, diante de um lapso, uma das primeiras atitudes deve ser:

interromper o uso novamente o mais rapidamente possível e procurar ajuda.

2. O que é recaída?

A palavra recaída costuma ser utilizada para descrever um retorno mais significativo ao padrão problemático de consumo e aos comportamentos associados a ele.

Mas existe algo fundamental:

a recaída muitas vezes começa antes de a substância entrar novamente no organismo.

Ela pode começar na maneira de pensar.

Nas emoções.

Nas escolhas.

Nos lugares frequentados.

Nos relacionamentos retomados.

Na negligência com aquilo que estava ajudando a sustentar a recuperação.

É por isso que prevenção de recaídas não começa quando alguém encontra uma garrafa ou uma droga diante de si.

Ela começa muito antes.

3. A recaída pode ser entendida como um processo

Imagine uma pessoa que esteja há alguns meses em recuperação.

Primeiro ela começa a abandonar algumas atividades importantes.

Depois começa a se afastar das pessoas que a apoiavam.

Passa a guardar seus problemas para si.

Começa novamente a pensar:

“Talvez eu nem tivesse um problema tão sério.”

Depois surge outro pensamento:

“Agora eu consigo controlar.”

Ela começa a lembrar apenas das sensações agradáveis do consumo e esquece as consequências.

Retoma contato com antigos companheiros.

Volta a frequentar determinados lugares.

Até que aparece a oportunidade.

Quando finalmente utiliza a substância, o processo talvez já estivesse acontecendo havia dias ou semanas.

Por isso podemos dizer:

o uso pode ser o último acontecimento visível de uma recaída que começou muito antes.

4. O retorno aos antigos padrões de pensamento

No capítulo anterior sobre recuperação vimos a importância da mudança dos padrões de pensamento.

Aqui percebemos por quê.

Alguns pensamentos precisam ser reconhecidos como sinais de alerta:

“Desta vez vai ser diferente.”

“Só uma vez não vai fazer mal.”

“Eu consigo parar quando quiser.”

“Depois de tanto tempo, já estou curado.”

“Ninguém precisa saber.”

“Eu mereço beber depois de tudo que passei.”

Esses pensamentos podem parecer pequenos, mas precisam ser observados.

Isso não significa que todo pensamento sobre drogas produzirá uma recaída.

Pensamentos aparecem.

A questão é o que fazemos com eles.

A pessoa em recuperação precisa aprender a identificar determinados pensamentos antes que eles se transformem em decisões.

5. O que são gatilhos?

Chamamos de gatilhos situações internas ou externas que aumentam a vontade de consumir uma substância ou fazem antigas associações com o uso reaparecerem.

Os gatilhos não são iguais para todas as pessoas.

Podem ser:

- determinados lugares;
- antigos companheiros de consumo;
- dinheiro disponível;
- festas;
- conflitos familiares;
- solidão;
- raiva;
- frustração;
- ansiedade;
- tristeza;
- lembranças;
- músicas;
- cheiros;
- determinadas datas;
- situações de rejeição;
- sensação de fracasso;
- e até momentos de grande alegria.

Sim, emoções positivas também podem funcionar como gatilho.

Alguém pode pensar:

“Hoje estou feliz. Vou comemorar.”

Por isso, recuperação envolve aprender a conhecer a si mesmo.

6. Conhecer o gatilho não significa fugir da vida

Não é possível eliminar todas as situações difíceis.

A pessoa continuará enfrentando frustrações.

Continuará encontrando pessoas que não concordam com ela.

Haverá problemas financeiros.

Haverá dias ruins.

Haverá perdas.

Haverá tentações.

Portanto, prevenção de recaídas não pode significar apenas fugir dos gatilhos.

No início, evitar determinadas pessoas, lugares e situações pode ser extremamente importante.

Mas, ao longo do processo, a pessoa também precisa desenvolver novas maneiras de responder às dificuldades da vida.

Esse é um dos objetivos centrais da recuperação.

Antes, diante de uma frustração:

problema → substância.

Agora precisamos construir outros caminhos:

problema → reconhecer o que estou sentindo → conversar → pedir ajuda → pensar → escolher uma resposta saudável.

Isso é mudança de comportamento.

E também é mudança do padrão de pensamento.

7. Sinais de alerta

Alguns comportamentos podem indicar que algo está mudando e merecem atenção.

Por exemplo:

- isolamento crescente;
- abandono de atividades importantes;
- afastamento das pessoas que apoiam a recuperação;
- retorno frequente a antigos ambientes;
- romantização do período de consumo;
- irritação quando alguém fala sobre recuperação;

- excesso de confiança;
- negligência com tratamento ou acompanhamento;
- esconder comportamentos;
- mentiras;
- voltar a manter contato secreto com pessoas ligadas ao consumo;
- pensar frequentemente em testar novamente a capacidade de controle.

Nenhum desses sinais, isoladamente, prova que alguém irá usar drogas.

Eles servem como alertas para conversar e investigar o que está acontecendo.

8. A importância de pedir ajuda cedo

Existe uma frase perigosa:

“Eu resolvo sozinho.”

Quando alguém percebe que seus pensamentos estão mudando, que a vontade de usar aumentou ou que antigos comportamentos estão retornando, esse é justamente o momento de procurar ajuda.

Não depois do consumo.

Antes.

A pessoa pode procurar:

- alguém de confiança;
- familiar preparado para ajudá-la;
- profissional de saúde;
- grupo de apoio;
- liderança responsável;
- pastor ou conselheiro;
- serviço especializado, quando disponível.

Pedir ajuda não é sinal de fracasso.

É uma estratégia de proteção.

9. E se acontecer um lapso?

Aqui está uma orientação fundamental para o projeto Caminina para Cristo.

Se alguém retornar ao uso, não devemos dizer:

“Você jogou tudo fora.”

Imagine o efeito dessa frase sobre alguém que já está tomado por vergonha e culpa.

Ela pode pensar:

“Então não adianta mais tentar.”

O caminho deve ser outro.

Primeiro:

interromper o consumo e proteger a pessoa de riscos imediatos.

Depois:

procurar ajuda.

Quando a pessoa estiver em condições, precisamos entender:

O que aconteceu antes do uso?

Onde ela estava?

O que estava sentindo?

O que estava pensando?

Com quem estava?

Qual foi a primeira decisão que começou a aproximá-la novamente da substância?

Quais sinais foram ignorados?

O objetivo não é justificar o comportamento.

Também não é condenar a pessoa.

É aprender com o episódio para fortalecer a recuperação.

10. Responsabilidade sem condenação

Existe uma diferença importante entre acolher e passar a mão na cabeça.

Quem está em recuperação precisa assumir responsabilidade pelas próprias escolhas.

Podemos dizer:

“O que aconteceu é sério e precisamos entender suas escolhas.”

Sem dizer:

“Você não tem jeito.”

Podemos confrontar comportamentos sem destruir a pessoa.

Podemos estabelecer limites sem humilhar.

Podemos ensinar responsabilidade sem retirar esperança.

Essa combinação é essencial:

acolhimento + verdade + responsabilidade + oportunidade de mudança.

11. Um plano de prevenção de recaídas

Toda pessoa em recuperação deveria, sempre que possível, desenvolver um plano simples.

Ela precisa conseguir responder:

Quais são meus principais gatilhos?

Quais pensamentos costumam aparecer antes de eu querer usar?

Quais comportamentos mostram que estou me afastando da recuperação?

Quais pessoas posso procurar?

Quais lugares preciso evitar neste momento?

O que farei quando a vontade de usar aparecer?

Onde posso procurar ajuda profissional?

Um plano feito durante um período de tranquilidade pode ser extremamente útil quando chegar um momento de crise.

12. A família também precisa aprender

A recaída não afeta somente a pessoa dependente.

A família frequentemente vive com medo.

Qualquer mudança de comportamento pode gerar desconfiança.

Isso pode produzir vigilância constante, discussões e acusações.

A família também precisa aprender a observar sinais sem transformar a casa em uma prisão.

Precisa saber estabelecer limites.

Precisa compreender que ajudar não significa encobrir consequências.

E precisa saber onde procurar ajuda quando a situação ultrapassa aquilo que consegue administrar.

13. Quando existe risco imediato

Existem situações em que a prioridade deixa de ser conversar sobre recuperação.

A prioridade passa a ser preservar a vida.

Se a pessoa estiver inconsciente, apresentar dificuldade importante para respirar, convulsões, confusão intensa, comportamento que coloque a própria vida ou a de outras pessoas em risco ou outros sinais graves depois do consumo, deve-se procurar atendimento de emergência disponível na região.

Da mesma forma, abstinência grave de álcool pode exigir atendimento médico.

Nessas situações, oração, aconselhamento e acompanhamento espiritual podem permanecer presentes, mas não substituem atendimento médico de urgência.

14. A dimensão espiritual da prevenção

Para o Caminina para Cristo, a recuperação também envolve vida espiritual.

A Bíblia apresenta repetidamente a importância da vigilância.

«“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.”
Mateus 26:41»

Observe que existem duas ações:

vigiar e orar.

Orar significa reconhecer nossa dependência de Deus.

Vigiar significa também perceber perigos, pensamentos, atitudes e situações que podem nos conduzir novamente a caminhos destrutivos.

Portanto, prevenção de recaídas e vida espiritual não precisam caminhar separadas.

A pessoa pode aprender a reconhecer seus gatilhos, procurar ajuda, mudar comportamentos, seguir orientações profissionais e, ao mesmo tempo, fortalecer sua comunhão com Deus.

PARA REFLETIR

Imagine que um homem permaneceu seis meses sem beber.

Depois de uma discussão familiar, bebe durante uma noite.

Na manhã seguinte procura Eduardo e diz:

“Acabou. Eu fracassei. Voltei para o mesmo lugar.”

Eduardo poderia ajudá-lo a compreender:

“O que aconteceu é sério, mas precisamos olhar para o que aconteceu antes de você beber. Você não precisa transformar essa noite em mais seis meses de consumo. Vamos interromper isso agora, procurar o apoio necessário e entender o que podemos aprender com esse episódio.”

Essa resposta não diminui a responsabilidade.

Ela impede que a culpa seja transformada em desculpa para continuar usando.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

A recaída muitas vezes começa antes do retorno à substância. Por isso, prevenção significa aprender a reconhecer pensamentos, emoções, gatilhos e comportamentos que indicam perigo e agir antes que o consumo aconteça.

E, quando ocorre um lapso:

não transformar um episódio em desistência.

A pergunta mais importante deixa de ser somente:

“Por que você usou?”

E passa também a ser:

“O que estava acontecendo antes de você usar, e o que podemos fazer diferente da próxima vez?”

É assim que uma dificuldade pode se transformar em aprendizado para continuar a caminhada.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders. 3. ed. Genebra: WHO, 2023. [Organização Mundial da Saúde](#)
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Psychosocial interventions for management of alcohol dependence. WHO mhGAP Evidence Centre. Atualização de 2023. [Organização Mundial da Saúde](#)
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Combined psychosocial and pharmacological interventions for adults with alcohol dependence. WHO mhGAP Evidence Centre. Recomendação nova de 2023. [Organização Mundial da Saúde](#)
- NIDA — National Institute on Drug Abuse. Seeking Drug Abuse Treatment: Know What to Ask. Material que destaca que o retorno ao uso pode indicar necessidade de retomar ou ajustar a estratégia de tratamento, e não significa por si só que todo o tratamento tenha fracassado. [Organização Mundial da Saúde](#)

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA DIANTE DA DEPENDÊNCIA: AJUDAR SEM ADOECER JUNTO

Quando uma pessoa desenvolve dependência de álcool ou outras drogas, as consequências raramente atingem somente quem consome a substância.

A dependência entra em casa.

Ela interfere nas relações, modifica rotinas, provoca conflitos, gera medo, desconfiança, frustração e, muitas vezes, dificuldades financeiras.

Pais sofrem.

Esposas e maridos sofrem.

Filhos sofrem.

Irmãos sofrem.

E, depois de algum tempo, toda a família pode começar a organizar sua vida em torno do comportamento de uma única pessoa.

Por isso, quando falamos em recuperação, precisamos olhar também para aqueles que estão ao redor.

1. A família também adoece?

Precisamos ter cuidado com essa expressão.

Não significa que todos os familiares de uma pessoa dependente desenvolverão uma doença.

Significa que viver durante muito tempo em um ambiente marcado por consumo problemático, conflitos, promessas quebradas e crises pode modificar profundamente o comportamento familiar.

Imagine uma esposa que não sabe como o marido chegará em casa.

Ou uma mãe que passa a noite esperando o filho voltar.

Com o tempo, essas pessoas podem viver em permanente estado de preocupação.

A rotina passa a ser determinada pelo comportamento daquele que usa a substância.

“Será que ele bebeu?”

“Onde ele está?”

“Gastou novamente o dinheiro?”

“Vai chegar agressivo?”

“Será que desta vez aconteceu alguma coisa?”

A dependência começa a ocupar o centro da vida não somente do usuário, mas também daqueles que convivem com ele.

Por isso, a família também precisa de cuidado.

2. O que chamamos de codependência?

O termo **codependência** tornou-se popular para descrever determinados padrões de relacionamento nos quais uma pessoa passa a concentrar grande parte de sua vida em controlar, proteger ou administrar o comportamento de outra.

É importante, porém, não transformar essa palavra em um diagnóstico automático.

Nem todo familiar preocupado é codependente.

Nem toda ajuda é prejudicial.

E famílias diferentes reagem de maneiras diferentes à dependência.

O que precisamos observar são **padrões de comportamento que começam a prejudicar tanto quem usa a substância quanto quem tenta ajudá-lo.**

Por exemplo:

- assumir constantemente responsabilidades que pertencem ao usuário;
- esconder repetidamente as consequências do consumo;
- mentir para outras pessoas para protegê-lo;
- pagar continuamente dívidas relacionadas ao uso;
- tentar controlar cada movimento da pessoa;
- abandonar a própria vida para vigiar o familiar;
- tolerar comportamentos abusivos por medo de que estabelecer limites faça a pessoa usar novamente;
- acreditar que é responsável por manter o outro abstinente.

Nesses casos, aquilo que começou como tentativa de ajudar pode acabar aprisionando duas pessoas.

3. Ajudar não é fazer tudo pela pessoa

Existe uma diferença fundamental entre:

ajudar alguém a se recuperar

e

impedir que essa pessoa enfrente qualquer consequência de suas escolhas.

Imagine um homem que gasta repetidamente o dinheiro da alimentação da família com bebida.

Toda vez que isso acontece, outra pessoa consegue dinheiro para cobrir o prejuízo.

Ela pode estar tentando proteger a família.

Mas, se esse padrão continuar indefinidamente, o homem talvez nunca precise enfrentar plenamente uma das consequências de seu comportamento.

Outro exemplo:

alguém falta ao trabalho porque passou a noite usando drogas.

A família liga para o empregador e inventa uma doença para justificar sua ausência.

A intenção foi protegê-lo.

Mas também foi retirada uma consequência diretamente relacionada ao uso.

Isso é diferente de ajudar alguém a procurar tratamento, acompanhá-lo a um serviço de saúde ou ajudá-lo a construir uma rotina de recuperação.

4. Apoiar sem facilitar

Uma pergunta pode ajudar a família:

“Aquilo que estou fazendo aumenta a possibilidade de recuperação ou facilita a continuação do comportamento?”

Apoiar pode significar:

- acompanhar a pessoa na busca por tratamento;
- ajudá-la a encontrar serviços de saúde;
- oferecer alimentação;
- ouvir sem humilhar;
- incentivar atividades saudáveis;
- participar de reuniões familiares ou terapêuticas;
- ajudar a construir um plano de recuperação;
- estabelecer regras claras dentro de casa;
- reconhecer e incentivar mudanças positivas.

Facilitar pode significar:

- entregar dinheiro sabendo que provavelmente será utilizado para comprar álcool ou drogas;
- esconder repetidamente as consequências do consumo;
- assumir todas as responsabilidades da pessoa;
- mentir para protegê-la;
- aceitar violência ou ameaças em nome da recuperação;
- permitir que toda a família seja continuamente prejudicada sem estabelecer limites.

A diferença nem sempre será simples.

Por isso, famílias também podem precisar de orientação profissional.

5. Amor também estabelece limites

Às vezes existe a ideia de que amar significa suportar tudo.

Não significa.

É possível amar profundamente uma pessoa e dizer:

“Eu amo você, mas não vou lhe dar dinheiro para comprar bebida.”

“Eu quero ajudá-lo a procurar tratamento, mas não vou mentir por você.”

“Você pode contar comigo para sua recuperação, mas não posso aceitar violência dentro desta casa.”

Limite não precisa ser vingança.

Não precisa ser abandono.

Não precisa ser humilhação.

Um limite saudável comunica:

“Eu continuo me importando com você, mas existem comportamentos dos quais não participarei.”

6. A família não controla a recuperação

Talvez essa seja uma das verdades mais difíceis.

A família pode ajudar.

Pode incentivar.

Pode orientar.

Pode estabelecer limites.

Pode procurar recursos.

Pode participar do tratamento quando isso for apropriado.

Mas não pode tomar todas as decisões no lugar da pessoa.

Uma mãe pode desejar desesperadamente que o filho pare de beber.

Uma esposa pode fazer tudo que conhece para ajudar o marido.

Um irmão pode oferecer oportunidades.

Ainda assim, cada pessoa precisará participar ativamente de sua própria mudança.

Quando o familiar acredita que **“se eu fizer tudo corretamente, ele nunca mais usará”**, assume uma responsabilidade impossível.

E quando acontece um lapso ou recaída, pode sentir que também fracassou.

A recuperação não pertence somente à família.

7. Cuidado com a culpa

Famílias frequentemente procuram uma explicação.

“Onde foi que eu errei?”

“Foi porque fui um pai ausente?”

“Foi porque nossa família era pobre?”

“Foi porque discutíamos muito?”

A história familiar pode, sim, conter fatores importantes.

Como vimos anteriormente, ambiente, experiências de vida, relações sociais, vulnerabilidades individuais e muitos outros elementos podem contribuir para o desenvolvimento de problemas relacionados às drogas.

Mas dependência é um fenômeno complexo.

Reduzi-la a:

“A culpa é da mãe.”

ou

“A culpa é do pai.”

raramente ajuda.

Conhecer a história é importante para compreender.

Não para encontrar alguém para condenar.

8. A pessoa em recuperação também precisa reparar danos

Evitar a condenação não significa ignorar aquilo que aconteceu.

Durante anos de consumo podem ter ocorrido:

- mentiras;
- dívidas;
- abandono de responsabilidades;
- quebra de confiança;
- agressões;
- perdas financeiras;
- ausência na criação dos filhos;
- promessas repetidamente quebradas.

A abstinência não apaga automaticamente essas consequências.

A pessoa em recuperação precisará compreender que reconstruir confiança leva tempo.

Não basta dizer:

“Eu mudei.”

A família precisará observar essa mudança ao longo do tempo.

Responsabilidade, sinceridade, constância e novas atitudes começam gradualmente a reconstruir aquilo que foi perdido.

9. Perdão e confiança não são exatamente a mesma coisa

Essa distinção é especialmente importante no contexto cristão.

Podemos ensinar sobre perdão sem exigir que uma pessoa volte imediatamente a confiar da mesma maneira.

Imagine alguém que mentiu durante anos por causa do consumo.

Ele inicia sua recuperação.

Sua família pode decidir perdoá-lo.

Mas confiança será reconstruída por meio de comportamento consistente.

Perdoar não significa fingir que nada aconteceu.

E também não significa retirar limites necessários.

Perdão pode ser uma decisão. Confiança normalmente precisa ser reconstruída.

10. Quando existe violência

Existe um limite que precisa ser muito claro.

Dependência química nunca deve ser utilizada como justificativa para violência.

Se houver agressão física, ameaça grave, abuso sexual, violência contra crianças ou qualquer situação de perigo, a prioridade deve ser **proteger quem está em risco e procurar os serviços de proteção, saúde ou emergência disponíveis naquela região.**

Não se deve orientar uma esposa, marido, criança ou outro familiar a permanecer em situação perigosa simplesmente porque:

“Precisamos ajudá-lo.”

Ajudar alguém com dependência não exige colocar outra pessoa em risco.

11. A família também precisa continuar vivendo

Depois de anos concentrando tudo na pessoa dependente, alguns familiares deixam de cuidar de si.

Abandonam amizades.

Param atividades que gostavam.

Deixam de descansar.

Vivem exclusivamente tentando controlar crises.

Parte da recuperação familiar envolve recuperar também a própria vida.

Isso pode incluir:

- conversar com pessoas de confiança;
- procurar aconselhamento;
- participar de grupos de apoio;
- receber acompanhamento psicológico quando disponível;
- manter atividades pessoais;
- cuidar da saúde;
- preservar relacionamentos saudáveis;
- cultivar sua vida espiritual.

Cuidar de si não significa abandonar quem está sofrendo.

Significa reconhecer:

“Eu também sou uma pessoa e também preciso de cuidado.”

12. A família pode participar da recuperação

Apesar de todas as dificuldades, a família pode se tornar uma importante fonte de apoio.

Intervenções familiares fazem parte das abordagens psicossociais utilizadas no tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias, e o envolvimento adequado da família pode contribuir para o processo de recuperação.

Isso pode envolver aprender:

- como funciona a dependência;
- como conversar sem transformar toda conversa em acusação;
- como reconhecer sinais de risco;
- como estabelecer limites;
- como incentivar tratamento;
- como lidar com um lapso;
- como reconstruir relações;
- como elaborar um plano para situações de crise.

A família deixa de agir apenas pelo medo e começa a agir com conhecimento.

13. O papel de Caminina para Cristo

É muito possível que Eduardo e Ester descubram algo importante quando começarem esse trabalho:

muitas vezes quem primeiro pedirá ajuda não será a pessoa que bebe ou usa drogas.

Será a mãe.

A esposa.

O marido.

O irmão.

Talvez alguém chegue dizendo:

“Não sei mais o que fazer.”

Nesse momento, o trabalho do Caminina para Cristo não precisa começar tentando encontrar uma solução instantânea.

Pode começar ouvindo.

Conhecendo aquela família.

Identificando riscos.

Explicando aquilo que já sabemos sobre dependência.

Orientando sobre limites.

Ajudando a procurar serviços disponíveis.

Orando com aquela pessoa.

E permanecendo presente.

Às vezes, cuidar da família será a primeira porta para alcançar também quem está sofrendo com a dependência.

14. A dimensão espiritual da família

A família cristã também precisa tomar cuidado para não transformar a fé em instrumento de culpa.

Frases como:

“Você não tem fé suficiente.”

“Se você realmente tivesse se convertido, isso não estaria acontecendo.”

Podem aumentar vergonha e sofrimento sem necessariamente produzir mudança.

A espiritualidade pode oferecer algo muito diferente:

esperança.

Comunidade.

Perdão.

Responsabilidade.

Reconciliação.

Propósito.

Oração.

E pessoas dispostas a caminhar juntas.

A igreja pode ser um lugar onde uma família cansada encontra pessoas que dizem:

“Vocês não precisam atravessar isso sozinhos.”

“Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.”

Gálatas 6:2

Mas alguns versículos depois encontramos outra afirmação:

“Porque cada qual levará a sua própria carga.”

Gálatas 6:5

Esses dois princípios podem nos ensinar algo precioso.

Existem cargas nas quais precisamos ajudar uns aos outros.

E existem responsabilidades que cada pessoa precisa assumir.

Talvez uma das maiores sabedorias no cuidado com a dependência seja aprender a distinguir uma coisa da outra.

PARA REFLETIR

Uma mãe procura o projeto Caminina para Cristo.

Seu filho adulto bebe diariamente.

Ele já perdeu trabalhos, acumulou dívidas e vendeu objetos de casa.

Toda vez que fica sem dinheiro, procura a mãe.

Ela entrega algum valor porque teme que, se não ajudar, algo ruim aconteça.

Ela diz:

“Eu sei que ele provavelmente vai beber, mas sou mãe. Como vou dizer não?”

A resposta não precisa ser:

“Abandone seu filho.”

Também não deve ser:

“Continue dando dinheiro porque ele precisa de você.”

Podemos ajudá-la a construir uma terceira possibilidade:

“Continue sendo mãe. Continue amando seu filho. Ofereça alimento. Ajude-o a procurar tratamento. Esteja disponível quando ele quiser mudar. Mas você não precisa financiar aquilo que está destruindo a vida dele.”

Isso é amor com limites.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

A dependência afeta toda a família, mas a família não pode assumir a responsabilidade pela recuperação no lugar da pessoa dependente.

Ajudar significa caminhar ao lado.

Não significa carregar todas as consequências.

Não significa controlar todas as escolhas.

E não significa destruir a própria vida tentando salvar outra.

Uma família pode aprender a dizer simultaneamente:

“Eu amo você.”

“Quero ajudá-lo.”

e

“Existem coisas que não farei mais por você.”

Essas três afirmações podem coexistir.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. Genebra: WHO, 2024. O relatório inclui terapia familiar e de casais entre as intervenções psicossociais utilizadas nos transtornos por uso de substâncias.
- **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *Interventions for the management of substance use disorders: an overview*. Eastern Mediterranean Health Journal. A publicação aborda terapia familiar e de casais, comunicação, estratégias de enfrentamento e prevenção de recaídas.
- **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *mhGAP Intervention Guide — Version 2.0*. Genebra: WHO. Guia para manejo de transtornos mentais, neurológicos e relacionados ao uso de substâncias em serviços não especializados.
- **SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA).** *Substance Use Disorder Treatment and Family Therapy — TIP 39*. A publicação aborda participação familiar no tratamento, limites, apoio à recuperação e cuidado com necessidades dos próprios familiares.
- **SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA).** *Navigating Mental Health and Substance Use Care: An Introductory*

Guide for Families. 2026. Material direcionado às famílias que acompanham pessoas em tratamento e recuperação, com atenção também ao bem-estar e à resiliência familiar.

CAPÍTULO 10 – A COMUNIDADE E A IGREJA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: ACOLHER, ACOMPANHAR E CONHECER NOSSOS LIMITES

Até aqui vimos que a dependência química não envolve apenas uma substância.

Ela envolve a pessoa.

Seus pensamentos.

Seus comportamentos.

Sua família.

Seus relacionamentos.

Seu ambiente.

E, conseqüentemente, envolve também a comunidade na qual essa pessoa vive.

Isso significa que a recuperação não precisa acontecer isoladamente.

Uma pessoa pode receber atendimento profissional e, ao mesmo tempo, precisar de algo que nenhum consultório consegue oferecer sozinho:

pertencimento.

Pessoas com quem conversar.

Um lugar onde sejam conhecidas pelo nome.

Uma comunidade onde possam reconstruir relacionamentos.

Oportunidades de servir.

Uma rotina.

Amizades.

Esperança.

E, para aqueles que creem, uma comunidade onde possam desenvolver sua caminhada com Deus.

É nesse espaço que uma igreja pode desempenhar um papel extraordinário.

Mas, para fazer isso de maneira responsável, precisamos compreender também uma verdade:

a igreja pode fazer muito, mas não precisa tentar fazer tudo.

1. A importância de pertencer

Nos capítulos anteriores vimos como ambiente e relacionamentos podem influenciar tanto o desenvolvimento da dependência quanto a recuperação.

Quando alguém decide mudar de vida, frequentemente surge um problema:

“Para onde eu vou agora?”

Talvez grande parte de suas amizades esteja relacionada ao consumo.

Talvez os lugares que frequentava estejam relacionados ao consumo.

Talvez sua rotina inteira tenha sido construída ao redor da substância.

Retirar a droga sem construir novos vínculos pode deixar um enorme espaço vazio.

Por isso, recuperação também envolve **construir uma nova rede de relacionamentos**.

Uma igreja saudável pode oferecer justamente isso.

Não apenas:

“Pare de beber.”

Mas:

“Venha caminhar conosco.”

2. A igreja como lugar de acolhimento

Imagine uma pessoa chegando a uma igreja depois de anos vivendo com dependência.

Talvez sua aparência seja diferente.

Talvez sua roupa esteja suja.

Talvez ainda exista cheiro de álcool.

Talvez ela não saiba como se comportar durante o culto.

Talvez conheça muito pouco da Bíblia.

Talvez tenha uma história que algumas pessoas considerariam difícil de ouvir.

Qual será a primeira mensagem que ela receberá?

Não estamos falando apenas da mensagem pregada no púlpito.

Estamos falando do olhar das pessoas.

Da maneira como alguém se aproxima.

Do lugar oferecido para ela sentar.

Da conversa depois do culto.

Às vezes, antes de alguém ouvir:

“Jesus ama você”,

precisa experimentar uma comunidade cristã que demonstre:

“Sua presença aqui não nos incomoda.”

3. Acolher não significa aprovar tudo

Aqui precisamos recuperar um princípio do capítulo anterior.

Acolhimento e limites podem caminhar juntos.

A igreja pode receber uma pessoa sem aprovar comportamentos destrutivos.

Pode amar sem financiar o consumo.

Pode oferecer alimentação sem entregar dinheiro para drogas.

Pode ouvir sem concordar com todas as escolhas.

Pode oferecer outra oportunidade sem fingir que consequências não existem.

Jesus aproximava-se de pessoas quebradas sem tratar o pecado e a destruição como coisas sem importância.

Portanto, a comunidade cristã não precisa escolher entre:

amor ou verdade.

Precisamos aprender a praticar:

amor com verdade.

4. O perigo do estigma

Pessoas com dependência frequentemente recebem rótulos.

“Bêbado.”

“Drogado.”

“Sem-vergonha.”

“Caso perdido.”

Depois de ouvir essas palavras repetidamente, algumas pessoas começam a enxergar a si mesmas dessa maneira.

A igreja precisa tomar cuidado para não reproduzir o mesmo estigma.

Dependência não deve ser reduzida simplesmente a falta de caráter.

Isso não elimina responsabilidade pessoal.

A pessoa continuará responsável por suas escolhas e precisará aprender novos comportamentos.

Mas compreender a dependência como um problema complexo permite substituir desprezo por responsabilidade acompanhada de compaixão.

Não perguntamos apenas:

“O que há de errado com você?”

Podemos começar a perguntar:

“O que aconteceu em sua vida e como podemos ajudá-lo a construir algo diferente daqui para frente?”

5. Testemunhos são importantes, mas cada história é diferente

Em ambientes cristãos, testemunhos de transformação têm enorme valor.

Alguém pode dizer:

“Eu encontrei Jesus e nunca mais usei drogas.”

Glória a Deus por essa história.

Mas existe um perigo quando transformamos uma experiência individual em regra para todas as pessoas.

Outro homem pode entregar sua vida a Cristo e ainda enfrentar desejos intensos relacionados à substância.

Pode precisar de acompanhamento médico.

Pode precisar de psicoterapia.

Pode precisar de tratamento especializado.

Pode passar por um lapso.

Isso não nos autoriza automaticamente a concluir:

“Então sua conversão não foi verdadeira.”

Cada história possui características diferentes.

A fé pode ser uma força extraordinária na recuperação sem que isso signifique rejeitar os recursos de saúde disponíveis.

6. Oração e tratamento não são adversários

Esse princípio precisa ficar muito claro no trabalho de Caminha para Cristo.

Podemos orar por alguém.

E encaminhá-lo ao médico.

Podemos estudar a Bíblia com alguém.

E incentivá-lo a procurar acompanhamento psicológico.

Podemos jejuar por uma família.

E reconhecer uma emergência médica.

Uma atitude não precisa eliminar a outra.

Se alguém estiver com uma infecção grave, dificilmente diríamos:

“Não procure o hospital porque vamos orar.”

Podemos orar e procurar o hospital.

O mesmo princípio precisa ser aplicado aos transtornos relacionados ao uso de substâncias.

A fé responde a perguntas que a medicina não pretende responder.

A medicina também possui conhecimentos e recursos que um líder espiritual não possui.

Reconhecer isso não diminui nossa fé.

Demonstra responsabilidade.

7. Quando a igreja precisa encaminhar

Eduardo e Ester não precisam se transformar em médicos, psicólogos ou especialistas em dependência para ajudar a comunidade de Caminina.

Precisam aprender a reconhecer **quando determinada situação ultrapassa aquilo que podem fazer**.

Alguns exemplos exigem atenção especial:

- convulsões;
- perda de consciência;
- dificuldade importante para respirar;
- confusão mental intensa;
- suspeita de intoxicação grave;
- abstinência grave de álcool;
- comportamento extremamente desorganizado;
- risco de violência;
- ameaça ou tentativa de suicídio;
- sintomas físicos graves;
- situações envolvendo crianças em risco;
- necessidade de desintoxicação ou tratamento especializado.

Nessas situações, a resposta não deve ser apenas espiritual.

É necessário procurar os recursos de saúde, emergência ou proteção disponíveis na região.

Um dos trabalhos futuros do Caminina para Cristo poderá ser justamente conhecer:

“Para onde encaminhamos alguém quando precisamos de ajuda que não podemos oferecer?”

Construir essa rede será tão importante quanto aprender o conteúdo desta apostila.

8. A igreja pode funcionar como ponte

Talvez uma pessoa tenha medo de procurar tratamento.

Talvez não saiba onde existe atendimento.

Talvez tenha vergonha.

Talvez já tenha sido maltratada em outros lugares.

A igreja pode funcionar como ponte.

Alguém pode acompanhar essa pessoa.

Pode ajudá-la a compreender uma orientação.

Pode conversar com a família.

Pode ajudá-la a permanecer vinculada ao tratamento.

Pode continuar oferecendo apoio depois que ela voltar para casa.

Assim, a igreja não tenta substituir o serviço de saúde.

Ela ajuda a pessoa a **chegar até ele e continuar caminhando depois dele**.

9. A recuperação continua depois do tratamento

Imagine alguém que passe algumas semanas ou meses em tratamento.

Um dia essa pessoa volta para sua comunidade.

Os antigos lugares continuam lá.

Os antigos amigos talvez continuem lá.

Os problemas familiares talvez ainda existam.

As dificuldades financeiras podem continuar.

É justamente nesse momento que uma rede comunitária se torna especialmente importante.

A pessoa precisa reconstruir uma vida.

Isso pode envolver:

- voltar a estudar;
- procurar trabalho;
- aprender uma profissão;
- reconstruir relacionamentos;
- organizar sua rotina;
- desenvolver novas amizades;
- participar de atividades comunitárias;
- servir outras pessoas;
- desenvolver sua espiritualidade;

- aprender maneiras saudáveis de utilizar seu tempo.

Recuperação não é apenas sair das drogas.

É aprender a viver sem precisar voltar para elas.

10. Trabalho, estudo e propósito

Existe uma pergunta importante depois da abstinência:

“Agora vou fazer o quê da minha vida?”

Se não houver resposta, o vazio pode se tornar perigoso.

Por isso, uma comunidade pode ajudar alguém a descobrir capacidades que haviam sido esquecidas.

Talvez saiba trabalhar com construção.

Agricultura.

Mecânica.

Culinária.

Comércio.

Música.

Artesanato.

Tecnologia.

Talvez precise aprender a ler melhor.

Talvez precise terminar os estudos.

Talvez precise apenas de alguém que lhe dê a primeira oportunidade.

Quando uma pessoa volta a perceber que consegue produzir, aprender, contribuir e servir, sua identidade começa a deixar de ser construída exclusivamente ao redor da dependência.

Ela começa a descobrir:

“Eu posso ser útil novamente.”

11. Pessoas que passaram pela dependência podem ajudar outras

Existe um tipo de conhecimento que não vem somente dos livros.

É o conhecimento da experiência.

Alguém que viveu dependência e construiu uma recuperação estável pode compreender medos, pensamentos e situações que talvez sejam difíceis de explicar para quem nunca passou por isso.

Por isso, pessoas em recuperação podem se tornar importantes fontes de apoio para outras.

Mas precisamos tomar cuidado.

Ter vivido uma experiência não transforma automaticamente alguém em profissional de saúde.

A experiência pode produzir empatia, identificação e esperança.

A formação oferece outros conhecimentos.

As duas coisas podem colaborar.

Uma pessoa em recuperação pode dizer:

“Eu conheço esse caminho. Posso caminhar um pouco com você.”

E também saber dizer:

“Para isso que você está enfrentando, precisamos procurar alguém especializado.”

12. O que Caminha para Cristo pode começar fazendo?

No início, talvez o projeto não tenha grandes estruturas.

Isso não significa que não possa fazer muito.

Pode começar com coisas simples:

Escutar.

Visitar.

Orientar.

Orar.

Ensinar.

Aproximar famílias.

Identificar pessoas em risco.

Conhecer os recursos disponíveis na região.

Encaminhar quando necessário.

Continuar acompanhando depois do encaminhamento.

Com o tempo, talvez surjam outras possibilidades:

grupos de apoio;

reuniões para familiares;

estudos sobre dependência;

atividades para jovens;

ações preventivas;

capacitação de voluntários;

parcerias com profissionais;

atividades de reinserção social.

Mas não precisamos começar fazendo tudo.

Um trabalho responsável pode crescer gradualmente.

13. A importância de preparar os voluntários

Boa vontade é indispensável.

Mas boa vontade sem conhecimento também pode causar problemas.

Por isso, pessoas que desejarem participar do Caminha para Cristo precisam receber alguma preparação.

Precisam compreender pelo menos:

- conceitos básicos sobre dependência;
- como ouvir sem humilhar;
- o que não prometer;
- quando encaminhar;
- como preservar confidencialidade;
- como estabelecer limites;
- como agir diante de uma emergência;
- como lidar com familiares;

- como evitar relações de dependência entre voluntário e assistido.

Esta própria apostila pode se tornar um primeiro instrumento para essa formação.

Ela não transforma ninguém em especialista.

Mas pode ajudar alguém a começar a servir com mais responsabilidade.

14. A igreja não precisa ser o centro de tudo

Existe uma tentação quando começamos um projeto:

querer que tudo aconteça dentro dele.

Mas o objetivo não deveria ser fazer a pessoa depender do Caminina para Cristo.

O objetivo é ajudá-la a reconstruir sua própria vida.

Isso significa aprender a trabalhar em rede.

Quando houver um serviço de saúde capaz de ajudar, encaminhamos.

Quando houver uma escola, incentivamos o estudo.

Quando houver oportunidade de trabalho, ajudamos na aproximação.

Quando houver outra organização séria capaz de oferecer algo que não possuímos, podemos colaborar.

O importante não é:

“Quem receberá o crédito?”

A pergunta é:

“O que essa pessoa precisa para continuar avançando?”

15. A missão cristã e a recuperação

O nome do projeto já apresenta sua identidade:

Caminina para Cristo.

Portanto, anunciar Jesus faz parte de sua razão de existir.

Mas talvez uma das maneiras mais poderosas de anunciar o Evangelho seja demonstrar que uma pessoa continua tendo valor quando muitos já desistiram dela.

Jesus disse:

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.”

Mateus 11:28

Muitas pessoas que chegarão até esse trabalho estarão exatamente assim:

cansadas.

oprimidas.

Feridas pelas consequências das próprias escolhas.

Feridas pelas escolhas de outras pessoas.

Algumas talvez tenham perdido família.

Trabalho.

Casa.

Confiança.

Esperança.

A igreja pode apresentar Cristo.

Pode anunciar arrependimento, perdão e nova vida.

E pode demonstrar esse Evangelho através de uma comunidade disposta a caminhar ao lado delas.

PARA REFLETIR

Um homem procura Eduardo depois de um culto.

Ele diz:

“Eu quero parar de beber. Orem por mim.”

Eduardo certamente pode orar.

Mas a conversa não precisa terminar ali.

Pode perguntar:

“Há quanto tempo você bebe?”

“Você bebe todos os dias?”

“Já tentou parar alguma vez?”

“Já passou mal quando ficou sem beber?”

“Sua família sabe que você está procurando ajuda?”

Dependendo das respostas, talvez seja necessário procurar atendimento de saúde.

Então Eduardo poderá dizer:

“Vamos orar. E também vamos procurar a ajuda que você precisa. Eu posso caminhar com você.”

Essa pequena diferença resume grande parte deste capítulo.

A igreja não precisa escolher entre:

fé ou cuidado.

Ela pode oferecer:

fé e cuidado.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

A igreja pode ser uma poderosa comunidade de acolhimento, pertencimento, esperança e acompanhamento durante a recuperação, mas não deve tentar substituir profissionais e serviços especializados.

Caminina para Cristo não precisa possuir todas as respostas.

Precisa aprender a:

acolher quando puder acolher;

acompanhar quando puder acompanhar;

orientar quando estiver preparado para orientar;

e

encaminhar quando a necessidade ultrapassar seus limites.

Talvez uma das frases mais importantes que um cuidador possa aprender seja:

“Eu não sei resolver isso sozinho, mas não vou abandonar você enquanto procuramos quem possa ajudar.”

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *Recovery-oriented services*. mhGAP Evidence Centre, atualização de 2023. Recomenda considerar manejo de caso, cuidado comunitário continuado, atividades ocupacionais e grupos de apoio de pares na recuperação de adultos com dependência de drogas.
- **UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC); WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders*. Edição revisada. Viena/Genebra, 2020. Apresenta o tratamento comunitário como uma rede que articula comunidade, família, serviços de saúde, assistência social e organizações da sociedade civil.
- **SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA).** *Faith and Community Engagement*. Material destinado a comunidades religiosas e organizações comunitárias que atuam junto a pessoas e famílias afetadas por problemas de saúde mental e uso de substâncias.
- **SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA).** *About Recovery*. Apresenta a recuperação como processo individual e multidimensional, envolvendo saúde, moradia, propósito e comunidade, e reconhece que diferentes caminhos podem incluir tratamento clínico, apoio familiar, pares e abordagens baseadas na fé.
- **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *Role of mutual help groups such as Alcoholics Anonymous (AA)*. mhGAP Evidence Centre. Recomenda que profissionais não especialistas conheçam os grupos de ajuda mútua disponíveis localmente e considerem incentivar sua utilização como parte da rede de apoio.
- **SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA).** *Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT)*. Apresenta um modelo de identificação, intervenção breve e encaminhamento para tratamento, reforçando a importância de reconhecer quando uma pessoa necessita de atendimento especializado.

CAPÍTULO 11 – REINSERÇÃO SOCIAL E RECONSTRUÇÃO DA VIDA: RECUPERAR É APRENDER A VIVER NOVAMENTE

Quando alguém deixa o álcool ou outras drogas depois de um longo período de dependência, uma pergunta começa a aparecer:

“E agora?”

Durante muito tempo, a substância pode ter ocupado grande parte da vida daquela pessoa.

Ela determinava onde ir.

Com quem andar.

Como gastar dinheiro.

Como enfrentar tristeza.

Como comemorar.

Como fugir dos problemas.

Como ocupar o tempo.

Quando o consumo é interrompido, não desaparece apenas a droga.

Pode surgir um enorme espaço vazio.

Por isso, recuperação não significa simplesmente:

“Não usar.”

Significa também:

aprender a viver de outra maneira.

1. ABSTINÊNCIA E RECUPERAÇÃO NÃO SÃO EXATAMENTE A MESMA COISA

A abstinência pode ser uma parte muito importante da recuperação.

Mas imagine alguém que deixou de beber e permanece:

sem rotina;

isolado;

sem atividades;

sem perspectivas;

envolvido nos mesmos conflitos;

frequentando os mesmos ambientes;

sem aprender novas maneiras de enfrentar dificuldades.

A substância saiu, mas grande parte das condições relacionadas ao antigo padrão de vida continua presente.

Por isso, uma recuperação mais ampla envolve diferentes dimensões da existência:

- saúde;
- família;
- relacionamentos;
- moradia;
- estudo;
- trabalho;
- espiritualidade;
- participação na comunidade;
- responsabilidade;
- propósito.

A pergunta deixa de ser apenas:

“Há quanto tempo você não usa?”

E passa também a incluir:

“Que vida você está construindo?”

2. RECONSTRUIR UMA ROTINA

Durante períodos prolongados de consumo problemático, a rotina pode ficar profundamente desorganizada.

Horários deixam de existir.

Compromissos são abandonados.

O sono muda.

A alimentação piora.

Responsabilidades são adiadas.

Por isso, coisas aparentemente simples podem representar grandes avanços:

acordar em determinado horário;

arrumar o lugar onde dorme;

alimentar-se;

cumprir um compromisso;

participar de uma atividade;

estudar;

trabalhar;

descansar adequadamente;

dormir em horário regular.

Uma rotina saudável ajuda a diminuir grandes períodos de ociosidade e oferece previsibilidade à vida.

No começo, essas conquistas podem parecer pequenas.

Mas recuperação é construída também por pequenas ações repetidas.

3. APRENDER NOVAMENTE A ASSUMIR RESPONSABILIDADES

Durante a dependência, outras pessoas podem ter assumido responsabilidades que pertenciam ao indivíduo.

Quando começa a recuperação, essas responsabilidades precisam gradualmente retornar.

Isso pode significar:

cuidar dos próprios documentos;

administrar dinheiro;

cumprir horários;

participar das tarefas da casa;

comparecer aos atendimentos;

resolver problemas sem fugir deles;

cumprir aquilo que prometeu.

Responsabilidade não deve ser confundida com punição.

Ela faz parte da reconstrução da autonomia.

Existe uma diferença enorme entre alguém pensar:

“Estão fazendo tudo por mim.”

e começar a perceber:

“Eu consigo cuidar novamente da minha própria vida.”

4. TRABALHO É IMPORTANTE, MAS NÃO É APENAS DINHEIRO

O trabalho pode exercer um papel importante na reinserção social.

Ele oferece renda, mas também pode proporcionar:

rotina;

responsabilidade;

contato social;

aprendizado;

sentimento de utilidade;

autonomia.

Entretanto, precisamos tomar cuidado para não transformar emprego em medida absoluta da recuperação.

Uma pessoa pode ainda não estar preparada para trabalhar.

Pode precisar primeiro cuidar da saúde.

Pode precisar estudar.

Pode começar com pequenas responsabilidades.

Outra pode encontrar trabalho rapidamente.

Cada trajetória será diferente.

O objetivo não é simplesmente ocupar a pessoa.

É ajudá-la a desenvolver condições para participar novamente da sociedade de maneira saudável e responsável.

5. EDUCAÇÃO TAMBÉM RECONSTRÓI POSSIBILIDADES

Algumas pessoas interromperam os estudos muito cedo.

Outras possuem dificuldades de leitura e escrita.

Algumas nunca tiveram oportunidade de aprender uma profissão.

A recuperação pode abrir uma porta que parecia definitivamente fechada:

voltar a aprender.

Isso pode significar alfabetização.

Retomar a escola.

Fazer um curso profissionalizante.

Aprender um ofício.

Desenvolver uma habilidade.

Educação não serve apenas para conseguir emprego.

Ela também ajuda a pessoa a perceber que ainda consegue aprender, crescer e construir projetos para o futuro.

A pergunta deixa de ser:

“O que perdi?”

E começa lentamente a incluir:

“O que ainda posso construir?”

6.LIDAR COM O DINHEIRO TAMBÉM PRECISA SER REAPRENDIDO

Para algumas pessoas, receber dinheiro pode funcionar como gatilho.

Durante anos, dinheiro e consumo podem ter ficado fortemente associados.

Por isso, reorganizar a vida financeira também pode fazer parte da recuperação.

No início, algumas pessoas podem precisar de ajuda para:

planejar gastos;

separar necessidades de desejos;

evitar dívidas;

organizar pagamentos;

guardar pequenas quantias;

perceber situações nas quais dinheiro aumenta o risco de consumo.

O objetivo não deve ser controlar eternamente o dinheiro da pessoa.

O objetivo é ajudá-la a desenvolver autonomia financeira com responsabilidade.

7. RECONSTRUIR CONFIANÇA LEVA TEMPO

Talvez a pessoa esteja abstinente há algumas semanas e pense:

“Minha família deveria confiar em mim novamente.”

Mas confiança não funciona dessa maneira.

Como vimos no capítulo anterior, anos de mentiras, desaparecimentos, dívidas e promessas quebradas não desaparecem imediatamente.

A confiança é reconstruída por meio de comportamento consistente.

Hoje cumpre uma promessa.

Amanhã também.

Depois novamente.

Pouco a pouco, as pessoas começam a perceber:

“Alguma coisa realmente está diferente.”

Não é necessário exigir que todos esqueçam o passado.

É necessário construir um presente diferente.

8. ALGUMAS RELAÇÕES PRECISARÃO MUDAR

Nem todo relacionamento poderá continuar da mesma maneira.

Se grande parte das amizades estiver ligada ao consumo, talvez seja necessário estabelecer distância, principalmente no início da recuperação.

Isso pode ser doloroso.

Algumas dessas pessoas talvez sejam amigas de muitos anos.

Mas precisamos perguntar:

“Essa relação fortalece ou enfraquece a recuperação?”

Ao mesmo tempo, simplesmente abandonar antigos relacionamentos sem construir novos vínculos pode aumentar a solidão.

Por isso, precisamos novamente falar sobre comunidade.

A pessoa necessita encontrar ambientes nos quais consiga desenvolver relações que não dependam do uso de substâncias.

9. LAZER TAMBÉM PRECISA SER REAPRENDIDO

Pode parecer estranho, mas algumas pessoas em recuperação precisam reaprender a se divertir.

Durante anos:

festa significava álcool;

encontro com amigos significava álcool;

fim de semana significava droga;

comemoração significava consumo.

Então surge a pergunta:

“Como vou me divertir agora?”

A resposta precisa ser descoberta.

Esporte.

Música.

Leitura.

Passeios.

Atividades comunitárias.

Arte.

Conversas.

Jogos.

Igreja.

Natureza.

Projetos pessoais.

Não existe uma única resposta.

O importante é descobrir que prazer, descanso e convivência são possíveis sem a substância.

10. CUIDADO COM A PRESSA DE RECUPERAR TUDO

Quando alguém começa a melhorar, pode querer recuperar rapidamente tudo aquilo que perdeu.

Emprego.

Dinheiro.

Família.

Relacionamento.

Casa.

Respeito.

Anos de vida.

Essa pressa pode produzir enorme frustração.

Algumas coisas realmente poderão ser reconstruídas.

Outras talvez não.

Existem consequências que não conseguimos apagar.

Recuperação também envolve aprender a viver com essa realidade.

Não podemos voltar ao passado.

Mas podemos decidir o que faremos com o presente.

Em vez de tentar recuperar dez anos em dez dias, a pessoa pode aprender a perguntar:

“Qual é a responsabilidade de hoje?”

11. O PASSADO PODE ENSINAR SEM DETERMINAR O FUTURO

Uma pessoa que viveu muitos anos em dependência pode acreditar:

“É isso que eu sou.”

Mas existe uma diferença entre dizer:

“Eu vivi isso.”

e

“Eu sou somente isso.”

A história não precisa ser negada.

Ela pode ser compreendida.

Pode produzir aprendizado.

Pode até servir para ajudar outras pessoas.

Mas não precisa determinar todas as páginas seguintes.

Na recuperação, a pessoa começa a construir uma identidade que não gira exclusivamente ao redor da droga.

Ela pode voltar a ser:

pai;

mãe;

filho;

amigo;

trabalhador;

estudante;

vizinho;

membro de uma comunidade;

alguém capaz de servir.

E muitas outras coisas que talvez ainda nem tenha descoberto.

12. PROPÓSITO PROTEGE A RECUPERAÇÃO

Ter propósito não significa possuir uma grande missão ou realizar algo extraordinário.

Pode começar com algo simples:

“Quero voltar a cuidar dos meus filhos.”

“Quero terminar meus estudos.”

“Quero trabalhar.”

“Quero recuperar minha saúde.”

“Quero servir minha comunidade.”

Quando existe algo pelo qual vale a pena levantar da cama, a vida começa a ganhar outra direção.

Isso não elimina os desejos relacionados à substância.

Não elimina problemas.

Mas acrescenta uma pergunta poderosa diante de determinadas escolhas:

“O que posso perder se voltar para aquele caminho?”

13. NÃO TRANSFORMAR A RECUPERAÇÃO NA ÚNICA IDENTIDADE

Existe ainda um cuidado importante.

No começo, é natural que grande parte da vida esteja concentrada na recuperação.

Mas, com o tempo, queremos que a pessoa desenvolva uma existência maior do que isso.

Ela não precisa passar o resto da vida sendo conhecida apenas como:

“o ex-dependente.”

Sua experiência pode continuar fazendo parte de sua história.

Pode até ajudá-la a servir outras pessoas.

Mas ela também pode descobrir novos interesses, responsabilidades, talentos e sonhos.

O objetivo é que a vida se torne progressivamente maior do que a substância que um dia ocupou seu centro.

14. REINSERÇÃO NÃO ACONTECE SOMENTE PELO ESFORÇO INDIVIDUAL

Seria injusto falar de reinserção social como se tudo dependesse apenas da força de vontade.

Uma pessoa pode desejar trabalhar e não encontrar oportunidade.

Pode desejar estudar e não ter acesso.

Pode sofrer preconceito.

Pode não possuir documentos.

Pode não ter moradia adequada.

Pode viver em uma comunidade com poucos serviços disponíveis.

Essas condições importam.

Por isso, recuperação também pode exigir apoio social, políticas públicas, serviços comunitários e redes de solidariedade.

A responsabilidade pessoal é importante.

Mas as oportunidades existentes ao redor da pessoa também influenciam aquilo que ela consegue construir.

15. CAMININA PARA CRISTO E A RECONSTRUÇÃO DA VIDA

Aqui surge uma oportunidade muito importante para o projeto.

Caminina para Cristo não precisa pensar apenas:

“Como fazemos alguém parar de beber ou usar drogas?”

Pode começar a perguntar:

“Que tipo de vida essa pessoa poderá construir depois?”

Talvez o projeto possa, ao longo do tempo, conhecer pessoas da própria comunidade que estejam dispostas a ajudar.

Alguém que ensine um ofício.

Um comerciante disposto a oferecer uma oportunidade.

Uma pessoa que possa ajudar com alfabetização.

Uma igreja que ofereça atividades.

Uma família que esteja disposta a acompanhar.

Um profissional que possa orientar.

Uma escola.

Um serviço público.

Uma associação comunitária.

Assim, cria-se uma rede.

Talvez Caminina para Cristo não ofereça diretamente todas essas coisas.

Mas poderá aproximar pessoas de oportunidades.

16. A DIMENSÃO ESPIRITUAL DA RECONSTRUÇÃO

Para o cristão, existe ainda uma dimensão profunda de identidade.

A pessoa não precisa permanecer definida para sempre pelo pior período de sua história.

O Evangelho fala de transformação.

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”

2 Coríntios 5:17

Isso não significa que todas as consequências desapareçam imediatamente.

Também não significa que não haverá luta.

Significa que o passado não precisa possuir a palavra final sobre aquilo que uma pessoa pode se tornar.

A nova vida também precisa aparecer nas escolhas diárias:

verdade no lugar da mentira;

responsabilidade no lugar da fuga;

serviço no lugar do egoísmo;

reconciliação onde ela for possível;

disciplina;

trabalho;

cuidado;

fé.

Transformação espiritual e mudança de comportamento não precisam ser adversárias.

Uma pode se expressar através da outra.

PARA REFLETIR

Imagine um homem que permaneceu seis meses sem beber.

Quando perguntam sobre sua recuperação, ele responde:

“Eu parei de beber, mas não sei o que fazer da minha vida.”

Essa frase merece atenção.

Talvez o próximo passo não seja mais falar somente sobre álcool.

Talvez seja perguntar:

“O que você sabe fazer?”

“O que gostaria de aprender?”

“Como está sua relação com sua família?”

“Como passa seus dias?”

“Existe alguma responsabilidade que você possa começar a assumir?”

“Que tipo de homem você deseja ser daqui para frente?”

Essas perguntas também fazem parte da recuperação.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

Recuperação não é somente retirar uma substância da vida. É construir uma vida que possa ser vivida sem depender daquela substância.

Isso envolve:

rotina;

responsabilidade;

relacionamentos;

estudo;

trabalho;

lazer;

comunidade;

autonomia;

fé;

propósito.

Talvez possamos resumir todo este capítulo em duas perguntas.

A primeira é:

“Do que essa pessoa precisa se afastar?”

Mas não podemos parar nela.

Precisamos fazer também a segunda:

“Do que essa pessoa precisa se aproximar?”

É nessa segunda pergunta que começa a reconstrução.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Recovery-oriented services. mhGAP Evidence Centre. A OMS aborda serviços orientados à recuperação incluindo cuidado comunitário continuado, manejo de caso, atividades ocupacionais e apoio entre pares.

- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC); WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Edição revisada. Viena/Genebra, 2020. Os padrões internacionais apresentam a recuperação como processo continuado e destacam necessidades sociais, familiares, ocupacionais e comunitárias além do tratamento do consumo da substância.

- SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA). About Recovery. A SAMHSA descreve quatro grandes dimensões que sustentam a recuperação: saúde, lar, propósito e comunidade.

- SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA). Recovery and Recovery Support. Materiais sobre apoio à recuperação que enfatizam autonomia, participação comunitária, relações de apoio e construção de uma vida significativa.

- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system: alternatives to conviction or punishment. Viena: United Nations. O documento também aborda tratamento, reabilitação e reintegração social como componentes importantes do cuidado às pessoas com transtornos relacionados ao uso de drogas.

- BÍBLIA SAGRADA. 2 Coríntios 5:17. Utilizado neste capítulo como referência à dimensão espiritual de transformação e nova identidade dentro da proposta cristã do projeto Caminina para Cristo.

CAPÍTULO 12 – DO CONHECIMENTO À AÇÃO: PRIMEIROS PASSOS PARA QUEM DESEJA AJUDAR

Chegamos até aqui aprendendo sobre álcool, outras drogas, dependência, cérebro, comportamento, abstinência, recuperação, redução de danos, recaída, família, comunidade e reconstrução da vida.

Mas existe uma pergunta que ainda precisamos responder:

“O que fazemos quando uma pessoa realmente aparece diante de nós pedindo ajuda?”

Essa pergunta é especialmente importante para o Caminina para Cristo.

Eduardo, Ester e aqueles que futuramente participarem do projeto talvez encontrem pessoas em situações muito diferentes.

Alguém pode chegar dizendo:

“Eu quero parar.”

Outro talvez diga:

“Minha família está exagerando. Eu não tenho problema nenhum.”

Uma mãe poderá procurar ajuda para o filho.

Uma esposa poderá chegar desesperada por causa do marido.

Alguém poderá aparecer alcoolizado.

Outra pessoa poderá estar há alguns dias sem consumir e passando mal.

Cada situação exigirá uma resposta diferente.

Por isso, este último capítulo não pretende transformar ninguém em especialista.

Seu objetivo é mais simples:

ajudar quem deseja servir a saber como começar, o que observar, quais são seus limites e quando procurar ajuda especializada.

1. COMECE PELA PESSOA, NÃO PELA DROGA

Quando sabemos que alguém utiliza álcool ou outras drogas, existe uma tendência de concentrar toda a conversa na substância.

“Quanto você bebe?”

“Por que você usa?”

“Quando vai parar?”

Essas perguntas podem ser importantes.

Mas antes existe uma pessoa.

Pergunte seu nome.

Ouça sua história.

Descubra onde vive.

Pergunte sobre sua família.

Procure entender aquilo que está acontecendo.

Uma pessoa pode chegar procurando ajuda para parar de beber e, durante a conversa, revelar:

fome;

violência;

doença;

desemprego;

perda de documentos;

conflitos familiares;

falta de moradia;

solidão;

ou sofrimento emocional intenso.

Se enxergarmos apenas a droga, talvez não consigamos enxergar aquilo que está por trás dela.

A primeira ferramenta de quem deseja ajudar é:

escutar.

2. NÃO COMECE COM UM SERMÃO

No contexto de uma missão cristã, naturalmente desejamos falar de Jesus.

Mas precisamos aprender também o momento de ouvir.

Se alguém chega dizendo:

“Minha vida está destruída por causa da bebida”,

talvez a primeira resposta não precise ser uma longa explicação.

Podemos começar:

“Conte-me o que está acontecendo.”

Às vezes, uma pessoa que passou anos sendo julgada nunca teve oportunidade de contar sua história para alguém disposto a ouvi-la sem interromper.

Ouvir não significa concordar com tudo.

Significa tentar compreender antes de orientar.

3. FAÇA PERGUNTAS SIMPLES E IMPORTANTES

Não é necessário realizar uma entrevista complicada.

Algumas perguntas podem ajudar a compreender melhor a situação.

Por exemplo:

“O que você está usando?”

“Com que frequência?”

“Há quanto tempo?”

“Quando foi a última vez?”

“Você costuma usar sozinho ou com outras pessoas?”

“Já tentou parar?”

“O que aconteceu quando tentou?”

“Já passou mal quando ficou sem usar?”

“Já teve convulsões?”

“Já perdeu a consciência?”

“Está tomando algum medicamento?”

“Existe algum problema de saúde importante?”

“Você tem alguém da família ou alguma pessoa de confiança que saiba que está procurando ajuda?”

“Você quer parar ou ainda não sabe o que deseja fazer?”

Essas perguntas não fornecem um diagnóstico.

Mas ajudam a identificar situações que podem exigir atenção profissional.

4. OBSERVE ANTES DE ORIENTAR

Aquilo que a pessoa diz é importante.

Aquilo que observamos também.

Ela consegue conversar normalmente?

Sabe onde está?

Está muito confusa?

Consegue permanecer acordada?

Está respirando normalmente?

Consegue ficar em pé?

Está extremamente agitada?

Existem ferimentos?

Está tremendo intensamente?

Apresenta comportamento muito diferente do habitual?

Essas observações podem ajudar a perceber que determinada situação não é apenas uma conversa sobre recuperação.

Pode ser uma emergência.

5. SAIBA RECONHECER ALGUNS SINAIS DE PERIGO

Existem momentos em que o principal objetivo deixa de ser aconselhar.

Passa a ser:

PROTEGER A VIDA.

É necessário buscar atendimento de saúde ou emergência disponível na região diante de sinais graves, como:

- dificuldade importante para respirar;
- perda de consciência ou dificuldade para despertar;
- convulsões;
- confusão mental intensa;
- comportamento extremamente desorganizado;
- suspeita de intoxicação grave;

- ferimentos importantes;
- vômitos repetidos acompanhados de alteração importante do estado da pessoa;
- agitação extrema com risco para si ou para outros;
- ameaça ou tentativa de suicídio;
- abstinência grave, especialmente relacionada ao álcool.

Essa lista não contém todas as situações possíveis.

Quando houver dúvida diante de um quadro potencialmente grave, é mais seguro procurar avaliação de saúde do que tentar resolver sozinho.

6. UM CUIDADO ESPECIAL COM O ÁLCOOL

Precisamos repetir algo que apareceu anteriormente porque pode salvar uma vida.

Uma pessoa que desenvolveu forte dependência física do álcool pode apresentar complicações perigosas quando interrompe abruptamente o consumo.

Por isso, se alguém disser:

“Eu bebo muito todos os dias e amanhã vou simplesmente parar”,

precisamos investigar um pouco mais.

Já tentou parar anteriormente?

Teve tremores intensos?

Confusão?

Alucinações?

Convulsões?

Passou muito mal?

Se houver histórico ou sinais de abstinência importante, é necessário procurar avaliação de saúde.

Não devemos transformar:

“Você precisa parar de beber”

em

“Pare imediatamente sozinho, independentemente de sua condição.”

O objetivo é chegar à abstinência com segurança.

7. NÃO PROMETA AQUILO QUE NÃO PODE CUMPRIR

Quem deseja ajudar pode ser tomado pela emoção.

Pode dizer:

“Eu vou resolver sua situação.”

“Você nunca mais vai usar.”

“Vou conseguir um emprego para você.”

“Vou conseguir tratamento.”

“Pode me procurar a qualquer hora.”

Essas promessas podem criar expectativas que não conseguiremos cumprir.

É melhor dizer:

“Vou verificar o que podemos fazer.”

“Vamos procurar uma possibilidade.”

“Não sei resolver isso, mas posso ajudá-lo a procurar quem saiba.”

Honestidade também é cuidado.

8. NÃO TENHA SER O SALVADOR DA PESSOA

Existe uma armadilha especialmente perigosa para quem começa a trabalhar ajudando pessoas.

A sensação de que:

“Essa pessoa depende de mim.”

Com o tempo, o voluntário pode começar a:

resolver todos os problemas;

dar dinheiro constantemente;

atender a qualquer hora;

esconder situações da família;

assumir responsabilidades que pertencem à pessoa;

sentir culpa quando ela recai.

Isso não é saudável.

O objetivo não é criar dependência do cuidador.

É ajudar a pessoa a desenvolver autonomia e construir uma rede de apoio.

Quem ajuda também precisa possuir limites.

9. CONFIDENCIALIDADE E RESPEITO

Quem trabalha com pessoas vulneráveis ouvirá histórias muito pessoais.

Problemas familiares.

Traumas.

Erros.

Crimes.

Vergonhas.

Recaídas.

Conflitos.

Essas histórias não devem virar assunto para conversas informais.

Também não devem ser transformadas em testemunhos públicos sem autorização.

Uma pessoa não perde seu direito à dignidade porque pediu ajuda.

Dentro da equipe, informações devem ser compartilhadas apenas quando realmente necessárias para o cuidado e de maneira responsável.

Existem, porém, situações em que segurança e proteção exigem procurar ajuda externa, especialmente quando há risco grave para a própria pessoa, para terceiros ou para crianças.

Confidencialidade não significa esconder situações de perigo.

10. CUIDADO AO UTILIZAR TESTEMUNHOS

O testemunho pode ser uma ferramenta poderosa no trabalho cristão.

Alguém que superou anos de dependência pode produzir esperança simplesmente dizendo:

“Eu também vivi algo parecido.”

Mas testemunho não deve se transformar em competição.

“Eu passei por coisa pior.”

“Se eu consegui, você também consegue.”

Cada pessoa possui sua própria história.

O testemunho deve abrir uma porta.

Não fechar a conversa.

Uma maneira mais cuidadosa seria:

“Eu também conheci de perto esse sofrimento. Minha história foi assim. A sua pode ser diferente, mas quero que saiba que mudança é possível.”

11. CONSTRUA UMA REDE ANTES DE PRECISAR DELA

Caminina para Cristo não deveria esperar uma emergência acontecer para descobrir onde existe ajuda.

Uma das primeiras tarefas práticas do projeto pode ser construir um pequeno mapa da rede disponível.

Onde fica a unidade de saúde mais próxima?

Onde alguém pode receber atendimento de emergência?

Existe serviço relacionado à saúde mental?

Quem atende casos relacionados ao álcool e outras drogas?

Existem hospitais próximos?

Existem serviços sociais?

Existem organizações comunitárias?

Existem profissionais dispostos a orientar o projeto?

Quem pode ajudar em situações envolvendo crianças?

Como funciona o transporte até esses locais?

Quais números de telefone precisam estar disponíveis?

Essas informações devem ser conhecidas antes da crise.

Uma pequena folha com contatos atualizados pode ser tão importante quanto muitas páginas de teoria.

12. REGISTRE SEM TRANSFORMAR A PESSOA EM UM NÚMERO

À medida que o projeto crescer, poderá ser útil manter registros simples.

Nome.

Contato.

Data do atendimento.

Necessidade apresentada.

Encaminhamento realizado.

Retorno previsto.

Mas esses registros precisam ser protegidos.

Não devem circular indiscriminadamente.

O objetivo é permitir continuidade no acompanhamento, não produzir exposição.

Também é importante registrar apenas aquilo que realmente seja necessário.

13. ACOMPANHAR DEPOIS DO ENCAMINHAMENTO

Encaminhar não significa:

“Agora o problema é deles.”

Imagine que Eduardo acompanhe alguém até um serviço de saúde.

Depois disso, pode perguntar:

“Como você está?”

“Conseguiu continuar o atendimento?”

“Precisa de alguma orientação?”

A igreja e o projeto podem continuar oferecendo aquilo que lhes cabe:

comunidade;

escuta;

oração;

amizade;

apoio familiar;

atividades;

encorajamento;

oportunidades de reinserção.

Tratamento e acompanhamento comunitário podem caminhar juntos.

14. PREPARE UM PLANO SIMPLES PARA CADA PESSOA

Depois de conhecer melhor a situação, podemos ajudar a pessoa a pensar nos próximos passos.

Não precisa ser um documento complicado.

Podemos perguntar:

“Qual é o problema mais urgente?”

“O que você deseja mudar?”

“Qual é o primeiro passo possível?”

“Quem poderá ajudá-lo?”

“Existe algum lugar ou pessoa que você precisa evitar neste momento?”

“O que fará se sentir vontade intensa de usar?”

“Quem pode procurar?”

“Quando vamos conversar novamente?”

Grandes mudanças podem começar com um próximo passo muito pequeno e claramente definido.

15. NEM TODA PESSOA ESTARÁ PRONTA PARA MUDAR

Isso pode ser frustrante.

Alguém pode ouvir.

Concordar.

Chorar.

Prometer.

E depois voltar ao mesmo comportamento.

Outra pessoa talvez nem reconheça que existe um problema.

Quem ajuda precisa compreender que não controla o momento da mudança.

Podemos plantar.

Orientar.

Estabelecer limites.

Manter uma porta aberta.

Mas não podemos decidir pelo outro.

Isso protege também o cuidador da sensação de fracasso.

16. SE HOUVER UM LAPSO, RETOME O CAMINHO

Como aprendemos anteriormente, um episódio de retorno ao uso não precisa significar abandono completo da recuperação.

Se alguém que estava sendo acompanhado voltar a utilizar uma substância, podemos investigar:

“O que aconteceu?”

“O que você estava sentindo?”

“Que sinais apareceram antes?”

“Que decisões aproximaram você novamente do consumo?”

“O que podemos fazer diferente agora?”

Se houver risco médico, ele deve ser tratado primeiro.

Depois, o episódio pode servir para revisar o plano de recuperação.

Não ignoramos o ocorrido.

Mas também não dizemos:

“Você perdeu tudo.”

17. QUEM CUIDA TAMBÉM PRECISA SER CUIDADO

Trabalhar com sofrimento humano pode ser emocionalmente pesado.

Haverá histórias que permanecerão na memória.

Pessoas pelas quais criaremos carinho.

Situações que terminarão bem.

Outras que não terminarão como desejávamos.

Talvez existam recaídas.

Talvez alguém abandone o acompanhamento.

Talvez algumas perdas aconteçam.

Por isso, Eduardo, Ester e futuros voluntários também precisarão cuidar uns dos outros.

Conversar.

Orar.

Dividir responsabilidades.

Descansar.

Reconhecer limites.

Buscar orientação quando necessário.

Nenhum voluntário deveria carregar sozinho todos os problemas de uma comunidade.

18. COMECE PEQUENO E FAÇA BEM FEITO

Talvez exista entusiasmo para começar muitas coisas ao mesmo tempo.

Grupo.

Visitas.

Atendimento.

Prevenção.

Ações com jovens.

Famílias.

Cursos.

Campanhas.

Mas um projeto sustentável pode começar pequeno.

Talvez inicialmente Caminina para Cristo consiga:

receber pessoas;

escutar;

orientar;

visitar famílias;

identificar situações de risco;

encaminhar;

acompanhar;

realizar encontros educativos;

anunciar o Evangelho;

construir uma rede local.

Depois, conforme pessoas forem capacitadas e parcerias surgirem, o trabalho poderá crescer.

Não precisamos fazer tudo hoje.

Precisamos fazer com responsabilidade aquilo que conseguimos fazer hoje.

19. UMA POSSÍVEL SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO

Quando alguém procurar o Caminina para Cristo, uma sequência simples pode ajudar:

1. ACOLHER

Receba a pessoa com respeito.

2. OUVIR

Deixe que conte o que está acontecendo.

3. IDENTIFICAR RISCOS

Observe se existe alguma situação que exija atendimento imediato.

4. COMPREENDER A NECESSIDADE

Uso de substâncias é o único problema ou existem também necessidades familiares, sociais, médicas ou emocionais?

5. DESCOBRIR O QUE A PESSOA DESEJA

Ela quer parar?

Quer diminuir riscos?

Está procurando ajuda para outra pessoa?

Ainda não reconhece o problema?

6. ORIENTAR

Ofereça apenas orientações que estejam dentro daquilo que a equipe está preparada para fazer.

7. ENCAMINHAR

Quando necessário, conecte a pessoa aos serviços adequados.

8. COMBINAR O PRÓXIMO PASSO

Evite terminar apenas com:

“Qualquer coisa, apareça.”

Quando possível, combine algo concreto:

“Vamos conversar novamente na sexta-feira.”

9. ACOMPANHAR

Verifique como a pessoa está e o que aconteceu depois do encaminhamento.

10. REAVALIAR

O plano está funcionando?

Algo precisa mudar?

Essa sequência não é uma fórmula rígida.

É apenas um mapa para ajudar quem está começando.

20. O QUE O CAMININA PARA CRISTO NÃO PRECISA SER

O projeto não precisa ser um hospital.

Não precisa ser uma clínica.

Não precisa substituir psicólogos.

Não precisa substituir médicos.

Não precisa possuir todas as respostas.

Não precisa resolver sozinho todos os problemas de Caminina.

Pode assumir com clareza aquilo que realmente é:

uma iniciativa missionária cristã comprometida em anunciar o Evangelho, aproximar-se das pessoas, oferecer acolhimento, orientação e acompanhamento e construir pontes para outros recursos quando necessário.

Conhecer os próprios limites não diminui uma missão.

Torna seu trabalho mais responsável.

21. CONHECIMENTO, COMPAIXÃO E SABEDORIA

Ao longo desta apostila aprendemos muitas informações.

Mas informação sozinha não transforma uma comunidade.

Precisamos de conhecimento para compreender.

Compaixão para nos aproximar.

E sabedoria para saber o que fazer com aquilo que encontramos.

Conhecimento sem compaixão pode produzir distância.

Compaixão sem conhecimento pode produzir boas intenções e decisões perigosas.

Por isso precisamos dos dois.

22. A DIMENSÃO ESPIRITUAL DO SERVIÇO

Existe uma passagem do Evangelho que resume muito do espírito deste trabalho.

Jesus conta sobre um homem ferido à beira do caminho.

Algumas pessoas passaram.

Um samaritano parou.

Ele viu.

Aproximou-se.

Cuidou das feridas.

Transportou aquele homem.

Providenciou um lugar onde pudesse continuar recebendo cuidado.

E comprometeu-se com aquilo que ainda seria necessário.

Veja a sequência:

ele viu;

aproximou-se;

cuidou;

encaminhou;

e continuou responsável pelo acompanhamento.

A parábola não é um manual sobre dependência química.

Mas apresenta um princípio poderoso para quem deseja servir pessoas feridas:

não basta perceber o sofrimento.

É necessário aproximar-se de maneira responsável.

“Vai, e faz da mesma maneira.”

Lucas 10:37

PARA REFLETIR

Imagine o primeiro dia em que alguém realmente procure o Caminha para Cristo pedindo ajuda.

Talvez Eduardo se lembre de muitas páginas desta apostila.

Talvez não.

Não precisa lembrar de tudo.

Pode começar com cinco perguntas:

“Qual é o seu nome?”

“Conte-me o que está acontecendo.”

“Existe algum perigo ou problema de saúde acontecendo agora?”

“O que você gostaria que mudasse?”

“Como podemos dar o primeiro passo juntos?”

Talvez seja assim que uma grande transformação comece:

não com alguém que possui todas as respostas,

mas com alguém disposto a permanecer ao lado enquanto procura a resposta certa.

IDEIA PRINCIPAL DESTE CAPÍTULO

Quem deseja ajudar pessoas com problemas relacionados ao álcool e outras drogas não precisa possuir todas as respostas.

Precisa aprender a:

ACOLHER.

OUVIR.

OBSERVAR.

IDENTIFICAR RISCOS.

ORIENTAR DENTRO DE SEUS LIMITES.

ENCAMINHAR.

ACOMPANHAR.

ESTABELECER LIMITES.

E CONTINUAR APRENDENDO.

O Caminina para Cristo não precisa começar grande.

Precisa começar responsável.

Porque por trás de cada conceito estudado nesta apostila haverá, um dia, uma pessoa real.

Com nome.

História.

Família.

Feridas.

Escolhas.

Responsabilidades.

E possibilidades.

Quando essa pessoa chegar, talvez a pergunta mais importante não seja:

“Como vamos consertar a vida dela?”

Talvez seja:

“Qual é o próximo passo que podemos ajudá-la a dar?”

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) guideline for mental, neurological and substance use disorders. 3. ed. Genebra: WHO, 2023. Apresenta recomendações baseadas em evidências para identificação e manejo de transtornos relacionados ao uso de substâncias, especialmente em contextos nos quais o atendimento especializado é limitado.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. Version 2.0.

Genebra: WHO. Oferece orientações para avaliação, identificação de situações prioritárias, manejo inicial e encaminhamento em serviços não especializados.

- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC); WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders. Revised edition. Viena/Genebra, 2020. Apresenta princípios internacionais para tratamento baseado em evidências, continuidade do cuidado, integração entre serviços e participação comunitária.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Management of alcohol withdrawal. mhGAP Evidence Centre. Apresenta recomendações para manejo da abstinência de álcool e identificação de pessoas que necessitam de atendimento em ambiente apropriado de saúde.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Community management of opioid overdose. Genebra: WHO, 2014. Embora direcionado especificamente aos opioides, apresenta princípios importantes sobre reconhecimento de overdose, resposta comunitária e necessidade de atendimento de emergência.

- SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA). Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT). Apresenta uma abordagem de identificação precoce, intervenção breve e encaminhamento de pessoas que necessitam de tratamento especializado.

- SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (SAMHSA). Substance Use Disorder Treatment and Family Therapy — TIP 39. Aborda participação familiar, tratamento, comunicação, limites e continuidade do cuidado.

- BÍBLIA SAGRADA. Lucas 10:25-37. Parábola do Bom Samaritano, utilizada neste capítulo como referência à dimensão cristã do cuidado responsável com aquele que sofre.

CONCLUSÃO

CONHECER PARA CUIDAR

Esta apostila começou com uma necessidade muito concreta:

como preparar pessoas dispostas a servir para compreender melhor aqueles que enfrentam problemas relacionados ao consumo de álcool e outras substâncias?

Ao longo destas páginas descobrimos que a resposta não caberia em uma frase.

Começamos falando de substâncias.

Mas logo percebemos que precisaríamos falar do cérebro.

Falamos do cérebro e descobrimos que precisaríamos falar de comportamento.

Falamos de comportamento e chegamos aos pensamentos, aos relacionamentos e ao ambiente.

Falamos de dependência e percebemos que precisaríamos compreender também a abstinência.

Falamos de recuperação e descobrimos que precisaríamos falar de lapso, recaída e prevenção.

Olhamos para a pessoa e percebemos que precisaríamos olhar também para sua família.

Olhamos para a família e chegamos à comunidade e à igreja.

E, finalmente, compreendemos que ajudar alguém a interromper o consumo de uma substância é apenas uma parte do caminho.

Porque depois surge uma pergunta ainda maior:

“Que vida essa pessoa poderá construir daqui para frente?”

A PESSOA ANTES DO PROBLEMA

Talvez uma das principais mensagens desta apostila possa ser resumida em algo muito simples:

nunca permita que o problema faça você esquecer a pessoa.

Dependência pode produzir comportamentos extremamente difíceis.

Pode destruir relacionamentos.

Pode provocar perdas.

Pode gerar mentiras.

Pode produzir dívidas.

Pode causar sofrimento à família.

Pode levar alguém a tomar decisões que jamais imaginou tomar.

Reconhecer a dignidade da pessoa não significa negar essas consequências.

Também não significa retirar sua responsabilidade.

Significa compreender que nenhum ser humano pode ser resumido ao pior período de sua história.

Por trás do comportamento existe uma pessoa.

Com nome.

História.

Família.

Feridas.

Escolhas.

Responsabilidades.

Capacidades.

E possibilidades.

COMPREENDER NÃO SIGNIFICA JUSTIFICAR

Durante esta caminhada aprendemos que dependência é um fenômeno complexo.

Existem alterações no cérebro.

Existem processos de aprendizagem.

Existem gatilhos.

Existem fatores ambientais.

Existem relacionamentos.

Existem padrões de pensamento.

Existem comportamentos que foram sendo construídos e reforçados ao longo do tempo.

Compreender tudo isso não significa dizer:

“A pessoa não possui responsabilidade.”

Significa abandonar explicações simplistas.

A recuperação exige responsabilidade.

Exige decisões.

Exige mudança.

Exige aprender novas maneiras de responder aos problemas.

Exige reconstruir aquilo que for possível.

Mas responsabilidade não precisa caminhar ao lado da humilhação.

Podemos confrontar comportamentos sem destruir a dignidade.

Podemos estabelecer limites sem abandonar.

Podemos dizer a verdade sem perder a compaixão.

RECUPERAÇÃO É MAIS DO QUE PARAR

Talvez alguém consiga deixar uma substância.

Essa conquista é importante.

Mas a recuperação continuará fazendo perguntas.

Como está sua rotina?

Como estão seus relacionamentos?

Como enfrenta frustrações?

O que faz quando surge um gatilho?

Como administra dinheiro?

Como reage diante de conflitos?

Como ocupa seu tempo?

Está reconstruindo confiança?

Existe alguma atividade que lhe dê sentido?

Existe comunidade?

Existe propósito?

A substância pode sair rapidamente do organismo.

Reconstruir uma vida leva tempo.

Por isso, recuperação não deve ser compreendida apenas como ausência de consumo.

Ela também envolve a construção progressiva de uma vida na qual a pessoa consiga viver de maneira mais saudável, responsável e significativa.

NÃO PRECISAMOS FAZER TUDO SOZINHOS

Outra lição atravessou diversos capítulos desta apostila:

conhecer nossos limites também é uma forma de cuidar.

Missionários não precisam se transformar em médicos.

Pastores não precisam se transformar em psicólogos.

Voluntários não precisam possuir todas as respostas.

Famílias não precisam resolver sozinhas aquilo que não conseguem resolver.

Existem situações nas quais precisamos procurar serviços de saúde.

Existem situações que exigem profissionais especializados.

Existem emergências.

Existem momentos em que a melhor frase que podemos dizer é:

“Eu não sei resolver isso sozinho, mas vou ajudá-lo a procurar quem possa.”

Encaminhar não significa abandonar.

Podemos continuar presentes.

Podemos acompanhar.

Podemos visitar.

Podemos ouvir.

Podemos orar.

Podemos incentivar.

Podemos ajudar a pessoa a permanecer vinculada ao cuidado de que necessita.

Ninguém precisa ocupar todos os lugares.

Precisamos aprender a trabalhar juntos.

FÉ E RESPONSABILIDADE

Esta apostila nasceu dentro de uma missão cristã.

Por isso, seria impossível chegar ao final sem falar novamente sobre fé.

Cremos no poder de Deus para transformar vidas.

Cremos no Evangelho.

Cremos em perdão.

Cremos em restauração.

Cremos que histórias podem tomar rumos diferentes.

Mas fé não precisa produzir negligência.

Podemos orar e procurar atendimento.

Podemos anunciar o Evangelho e estudar.

Podemos confiar em Deus e reconhecer os conhecimentos que Ele permite à humanidade desenvolver.

Podemos oferecer cuidado espiritual e, ao mesmo tempo, reconhecer quando alguém necessita de cuidado médico, psicológico ou social.

A fé não precisa nos afastar da responsabilidade.

Ela pode nos levar ainda mais profundamente a ela.

QUANDO O CAMINHA PARA CRISTO ENCONTRAR UMA PESSOA

Um dia, todo o conteúdo destas páginas deixará de ser apenas texto.

Eduardo e Ester encontrarão pessoas.

Talvez alguém chegue pedindo ajuda para parar de beber.

Talvez uma família procure orientação.

Talvez um jovem esteja enfrentando problemas relacionados à cannabis.

Talvez alguém esteja em uma situação que ultrapasse completamente aquilo que a equipe consegue resolver.

Quando isso acontecer, talvez ninguém consiga lembrar de todos os conceitos desta apostila.

E não há problema.

Talvez seja suficiente lembrar alguns princípios:

acolha;

escute;

observe;

não humilhe;

identifique riscos;

não prometa aquilo que não pode cumprir;

reconheça seus limites;

encaminhe quando necessário;

acompanhe;

e continue enxergando a pessoa.

O CONHECIMENTO PRECISA SE TRANSFORMAR EM CUIDADO

Podemos conhecer todas as definições desta apostila e ainda assim não saber cuidar.

Conhecimento precisa encontrar compaixão.

Mas compaixão também precisa encontrar conhecimento.

Foi justamente dessa união que nasceu o título deste material:

DEPENDÊNCIA QUÍMICA — CONHECER PARA CUIDAR.

Conhecemos para não agir apenas por impulso.

Conhecemos para reconhecer perigos.

Conhecemos para abandonar preconceitos.

Conhecemos para fazer perguntas melhores.

Conhecemos para estabelecer limites.

Conhecemos para saber quando podemos ajudar.

E também para saber quando precisamos procurar alguém mais preparado.

Conhecimento não é o destino final desta apostila.

É uma ferramenta.

O destino é o cuidado.

ALGUMAS HISTÓRIAS NÃO MUDARÃO RAPIDAMENTE

Quem começa a ajudar pessoas precisa também estar preparado para uma realidade difícil.

Nem todas as histórias terão mudanças rápidas.

Algumas pessoas recusarão ajuda.

Algumas voltarão ao consumo.

Algumas abandonarão o acompanhamento.

Algumas famílias continuarão enfrentando conflitos.

Talvez existam situações nas quais, apesar de todos os esforços, não veremos o resultado que desejávamos.

Isso não significa que todo cuidado foi inútil.

Não controlamos todas as decisões de outra pessoa.

Podemos oferecer caminhos.

Podemos ensinar.

Podemos acompanhar.

Podemos estabelecer limites.

Podemos permanecer disponíveis dentro daquilo que é saudável e responsável.

Mas não podemos escolher pelo outro.

Por isso, quem cuida também precisa aprender a entregar aquilo que não consegue controlar.

A ESPERANÇA PRECISA CONTINUAR

Por outro lado, também existirão histórias que surpreenderão.

Pessoas consideradas perdidas poderão reconstruir suas vidas.

Relacionamentos poderão ser restaurados.

Pais poderão voltar a conviver com seus filhos.

Alguém poderá voltar a estudar.

Outro poderá aprender uma profissão.

Famílias poderão reconstruir confiança.

Pessoas que um dia precisaram ser ajudadas talvez se tornem capazes de ajudar outras.

Não sabemos antecipadamente qual será o próximo capítulo da história de alguém.

Por isso, precisamos tomar cuidado quando utilizamos palavras definitivas sobre pessoas que ainda estão vivas.

“Não tem jeito.”

“Nunca vai mudar.”

“É caso perdido.”

Enquanto existe vida, a história ainda não terminou.

DE VOLTA A CAMININA

Chegamos, então, ao lugar onde começamos.

Caminina.

Uma comunidade ao sul de Luena, na província do Moxico, Angola.

Foi uma necessidade encontrada ali que colocou estas páginas em movimento.

Talvez os primeiros frutos desta apostila apareçam justamente naquele bairro.

Talvez apareçam muito longe dali.

Não sabemos.

Mas existe algo que podemos desejar.

Que onde quer que este material chegue, ele ajude alguém a olhar de maneira diferente para uma pessoa que sofre.

Que produza menos julgamento precipitado.

Mais responsabilidade.

Menos improvisação.

Mais conhecimento.

Menos abandono.

Mais caminhos para o cuidado.

E que aqueles que trabalham no Caminina para Cristo nunca se esqueçam de que, antes de existir um projeto, existem pessoas.

A MISSÃO CONTINUA

Esta apostila termina.

A missão não.

Ainda haverá muito para aprender.

Novas perguntas surgirão.

Erros precisarão ser corrigidos.

Novos conhecimentos precisarão ser incorporados.

Parcerias precisarão ser construídas.

Pessoas precisarão ser ouvidas.

E talvez este material seja apenas uma pequena ferramenta dentro de uma história muito maior que ainda está começando.

No início destas páginas fizemos muitas perguntas.

Ao final, talvez possamos guardar uma certeza simples:

não precisamos possuir todas as respostas para começar a cuidar.

Mas precisamos ter humildade suficiente para continuar aprendendo enquanto cuidamos.

“Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.”
Gálatas 6:2

Que o conhecimento nos torne mais responsáveis.

Que a responsabilidade nunca nos torne indiferentes.

Que a compaixão nunca nos torne imprudentes.

Que a fé produza serviço.

E que, diante de cada pessoa que encontrarmos pelo caminho, nunca esqueçamos:

há sempre uma história por trás daquilo que conseguimos ver.

CONHECER PARA COMPREENDER.

COMPREENDER PARA CUIDAR.

CUIDAR SEM PERDER DE VISTA A PESSOA.

Caminina para Cristo
Luena — Moxico — Angola

SOBRE O JESUS NA WEB E ESTA PUBLICAÇÃO

O Jesus na Web nasceu com o propósito de utilizar os recursos do ambiente digital para compartilhar a mensagem do Evangelho, produzir conteúdos de formação cristã e colocar conhecimento e tecnologia a serviço da missão.

É também por meio do Jesus na Web que esta apostila será disponibilizada gratuitamente, para que aquilo que começou como resposta a uma necessidade missionária em Caminina possa alcançar outras pessoas, igrejas, famílias, voluntários e projetos que enfrentem realidades semelhantes.

Mas existe uma parte desta história que considero importante contar a quem chegou até estas páginas.

ENTRE O CONHECIMENTO E A EXPERIÊNCIA

Meu nome é Aliano Rafael.

Meu interesse pelo tema da dependência química não nasceu apenas dos estudos e pesquisas realizados para preparar esta apostila.

Eu também conheço essa realidade pela experiência.

Durante muitos anos da minha vida vivi em meio à dependência química e experimentei algumas de suas consequências mais duras.

Conheci perdas.

Conheci rupturas.

Conheci a vida nas ruas.

Conheci lugares e situações em que parecia não existir qualquer perspectiva de mudança.

Por isso, muitos dos assuntos tratados nesta apostila não são para mim apenas conceitos encontrados em livros, artigos ou documentos técnicos.

Sei o que significa perceber que, pouco a pouco, a vida foi sendo organizada em torno de uma substância.

Sei também que interromper o uso não significa que tudo aquilo que foi construído durante anos desapareça imediatamente.

A recuperação não termina simplesmente quando a pessoa deixa de usar.

Ainda hoje vivo um processo de reconstrução.

Existem consequências que permanecem.

Existem hábitos que precisam continuar sendo revistos.

Existem maneiras de pensar e agir que precisam ser transformadas.

Existem responsabilidades que precisam ser assumidas.

Existem escolhas que precisam ser feitas diariamente.

E existe uma vida que precisa continuar sendo aprendida e construída.

Contudo, viver essa experiência não me transforma em especialista.

Minha história é minha história.

Ela pode possuir pontos em comum com a experiência de outras pessoas, mas não pode ser utilizada como explicação para todas elas.

Foi justamente por reconhecer isso que, ao preparar esta apostila, não quis depender apenas daquilo que vivi.

Minha experiência me ajudou a fazer perguntas.

O estudo me ajudou a compreender que as respostas precisavam ir além da minha própria história.

Por isso, procurei aproximar neste trabalho três elementos que considero importantes:

a experiência de quem conheceu a dependência por dentro;

o conhecimento produzido por profissionais e instituições que estudam e trabalham com essa realidade;

e a fé cristã, que sustenta minha esperança de que uma história não precisa terminar no lugar em que parecia estar condenada a permanecer.

UMA RESPOSTA DE ORAÇÃO

Durante muito tempo, uma das minhas orações ao Senhor tem sido:

“Senhor, usa a minha vida em tua obra.”

Eu desejava participar da missão.

Desejava que aquilo que Deus estava realizando em minha vida pudesse, de alguma maneira, também servir a outras pessoas.

Ao mesmo tempo, minhas limitações físicas muitas vezes me fizeram pensar sobre como isso poderia acontecer.

Quando pensava em missões, imaginava principalmente aquele que vai.

Aquele que atravessa fronteiras.

Aquele que chega pessoalmente ao campo missionário.

E, diante da minha própria condição, algumas dessas possibilidades pareciam distantes.

Então surgiu Caminina.

Meu contato com o missionário Eduardo Kanganjo e com a realidade encontrada no bairro Caminina, em Luena, Angola, começou a me mostrar uma possibilidade que eu ainda não havia compreendido completamente.

Talvez eu não precisasse estar fisicamente em Angola para começar a servir uma necessidade existente ali.

Havia algo que eu podia oferecer.

Aquilo que vivi.

Aquilo que estou aprendendo.

Minha disposição para estudar.

Minha capacidade de escrever.

O conhecimento que adquiri trabalhando com tecnologia.

E, principalmente, a disposição de colocar essas coisas a serviço de alguém que está no campo missionário.

Foi assim que esta apostila começou a nascer.

E, enquanto trabalhava nela, compreendi algo que se tornou muito importante para mim.

Durante tanto tempo eu havia olhado para aquilo que minhas limitações não me permitiam fazer.

Caminina me fez olhar para aquilo que ainda estava em minhas mãos.

Eu podia estudar.

Podia pesquisar.

Podia escrever.

Podia organizar conhecimento.

Podia utilizar a tecnologia.

Podia compartilhar gratuitamente.

Podia servir alguém que estava servindo do outro lado do oceano.

Por isso, esta publicação possui para mim um significado que ultrapassa a produção de um material educativo.

Ela representa uma resposta de oração.

Não porque eu considere este trabalho extraordinário, mas porque através dele comecei a compreender que participar da missão não significa que todos ocuparão o mesmo lugar ou realizarão a mesma tarefa.

Alguns irão.

Alguns permanecerão.

Alguns pregarão.

Alguns ensinarão.

Alguns contribuirão.

Alguns intercederão.

Alguns produzirão ferramentas.

Existem muitas maneiras de servir.

O importante é colocar aquilo que recebemos a serviço do Reino de Deus.

UMA PONTE ENTRE BRASIL E ANGOLA

Esta apostila nasceu de uma ponte.

De um lado, Caminina.

Uma comunidade em Luena, na província do Moxico, Angola, onde missionários encontraram pessoas e necessidades reais.

Do outro, o Brasil.

Um computador.

Livros, documentos e pesquisas.

Uma história de dependência e recuperação.

Conhecimentos adquiridos ao longo do caminho.

E alguém que havia pedido a Deus uma oportunidade de ser útil em sua obra.

A distância entre esses dois lugares é de milhares de quilômetros.

Mas a missão encontrou uma maneira de aproximá-los.

Agora essa ponte pode continuar.

Ao disponibilizar gratuitamente este material no Jesus na Web, aquilo que nasceu de uma necessidade de Caminina poderá chegar a outras pessoas e outros lugares.

Talvez seja utilizado por um missionário.

Talvez por um pastor.

Talvez por um voluntário.

Talvez por uma família tentando compreender aquilo que está acontecendo dentro de casa.

Talvez por alguém que esteja começando sua própria caminhada de recuperação.

Não sabemos até onde ele chegará.

Mas sabemos para que ele foi escrito.

Se esta apostila ajudar alguém a olhar para uma pessoa que sofre com menos preconceito e mais compreensão;

se preparar um voluntário para agir com maior responsabilidade;

se ajudar uma família a compreender que amar também pode significar estabelecer limites;

se fazer uma igreja perceber que oração, conhecimento e cuidado profissional podem caminhar juntos;

se ajudar alguém a reconhecer uma situação de risco e procurar atendimento;

ou se contribuir, ainda que de maneira pequena, para preservar uma vida;

então este trabalho terá cumprido seu propósito.

O JESUS NA WEB

O Jesus na Web continuará sendo um espaço dedicado ao anúncio do Evangelho e à produção de conteúdos que possam servir à Igreja, à missão e às pessoas.

Esta apostila passa a fazer parte desse propósito.

Ela será disponibilizada gratuitamente porque foi assim que nasceu: como serviço.

Caminina também me ensinou algo sobre aquilo que a missão pode significar em nosso tempo.

Uma necessidade surgida em uma comunidade de Angola atravessou o oceano.

Encontrou alguém disposto a aprender no Brasil.

Transformou-se em estudo.

O estudo transformou-se em escrita.

A escrita transformou-se nesta apostila.

E agora, através da internet, aquilo que nasceu dessa ponte poderá novamente atravessar fronteiras.

Talvez eu ainda não saiba todos os lugares para onde Deus poderá conduzir esse trabalho.

Mas hoje compreendo melhor uma coisa:

não precisamos esperar possuir aquilo que não temos para começar a servir.

Podemos começar colocando nas mãos de Deus aquilo que já temos.

Aquilo que sabemos.

Aquilo que aprendemos.

Aquilo que vivemos.

E aquilo que ainda somos capazes de fazer.

“Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,

assim é Cristo.”

1 Coríntios 12:12

Aliano Rafael
Jesus na Web
Brasil

FONTES E REFERÊNCIAS

Esta apostila foi preparada com o propósito de oferecer informação acessível, responsável e útil para missionários, líderes cristãos, voluntários, famílias e outras pessoas que desejam compreender melhor a dependência química e os caminhos possíveis para o cuidado.

Para sua elaboração, foram consultados materiais técnicos, documentos institucionais e publicações de organizações que atuam nas áreas de saúde, prevenção, tratamento e recuperação relacionados ao uso de álcool e outras substâncias.

As referências específicas utilizadas em cada tema encontram-se indicadas ao final dos respectivos capítulos.

Entre as principais instituições consultadas ao longo deste trabalho estão:

- Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO);
- Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC);
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA);
- National Institute on Drug Abuse (NIDA).

A utilização dessas fontes teve como objetivo fazer com que a experiência pessoal, a prática comunitária e a reflexão cristã presentes nesta obra fossem acompanhadas por informações fundamentadas em conhecimento técnico.

Este material possui caráter educativo.

Ele não substitui avaliação, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento realizado por profissionais e serviços de saúde.

A ciência e as recomendações na área da saúde também continuam avançando. Por isso, este material não deve ser considerado uma palavra definitiva sobre o tema.

Quem cuida também precisa continuar aprendendo.

SOBRE AS REFERÊNCIAS BÍBLICAS

As passagens bíblicas utilizadas ao longo desta apostila aparecem nos capítulos em que são aplicadas.

A presença das Escrituras neste material expressa sua origem e finalidade cristãs.

A fé é apresentada como parte importante do acolhimento, da esperança, da construção de sentido e da caminhada espiritual, sem ser utilizada como substituta dos cuidados médicos, psicológicos, sociais ou de outros atendimentos profissionais quando estes forem necessários.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA — CONHECER PARA CUIDAR

Conhecimento para compreender.

Compreensão para cuidar.

Responsabilidade para reconhecer nossos limites.

Compaixão para nunca perder de vista a pessoa.

CONHEÇA E APOIE O CAMINHA PARA CRISTO

UMA MISSÃO EM LUENA — MOXICO — ANGOLA

Foi de uma necessidade encontrada no bairro Caminina que nasceu a apostila que você acaba de ler.

O Caminina para Cristo integra o Projeto Missionário Moxico e é desenvolvido pela Agência Missionária Hora de Profetizar (AMHP), em parceria com a Igreja Cafarnaum Internacional (ICI).

O trabalho é conduzido localmente pelos missionários Eduardo e Ester Kanganjo, que vivem em Luena com seus filhos e estão envolvidos diretamente com a comunidade.

O propósito do projeto é anunciar o Evangelho, fazer discípulos, contribuir para a formação de uma comunidade cristã local e servir pessoas de maneira responsável diante das necessidades encontradas no campo missionário.

UMA OBRA QUE JÁ COMEÇOU

Embora o planejamento inicial previsse etapas posteriores de implantação, o trabalho em Caminina já começou a produzir seus primeiros passos.

Em relatório referente a setembro de 2026, os missionários registraram:

- 50 pessoas evangelizadas;
- 11 pessoas interessadas em caminhar com Jesus e receber discipulado;
- início de uma célula;
- realização de três cultos, com 17, 22 e 31 participantes;
- início do curso “A Vida Abundante”, com 7 participantes.

São números simples.

Mas por trás de cada número existe uma pessoa.

E uma obra missionária não é construída apenas com números.

Ela é construída com presença, relacionamento, perseverança, oração e serviço.

DESAFIOS E NECESSIDADES

Entre as necessidades apresentadas pelo trabalho missionário estão:

- Bíblias e materiais para discipulado;
- um espaço adequado para a realização dos cultos;
- recursos para o trabalho de evangelização com crianças, incluindo lanches;
- sustento e necessidades da família missionária;
- recursos para continuidade e desenvolvimento das ações locais.

Além das contribuições materiais, o projeto necessita de pessoas dispostas a interceder.

VOCÊ PODE PARTICIPAR

Nem todos poderão estar fisicamente em Caminina.

Mas existem diferentes maneiras de participar de uma missão.

Você pode:

- orar pelos missionários Eduardo e Ester e por seus filhos;
- interceder pelas pessoas que estão conhecendo o Evangelho;
- orar pelas crianças e famílias de Caminina;
- divulgar o projeto;
- contribuir com materiais;
- apoiar financeiramente, conforme suas possibilidades;
- apresentar o projeto à sua igreja ou comunidade cristã.

Toda contribuição financeira é voluntária.

Esta apostila é e continuará sendo disponibilizada gratuitamente. O acesso a este material não está condicionado a qualquer contribuição.

COMO CONTRIBUIR — BRASIL

PIX

11874530130

Titular:

Pedro Capingana Manuel

As contribuições recebidas no Brasil por meio desta chave são destinadas ao apoio do trabalho missionário Caminina para Cristo.

APOIO EM ANGOLA

IBAN:

0006 000065984923 3018 9

Titular:

António Eduardo Jamba Kanganjo

CONTATO COM O PROJETO

WhatsApp:

+244 927 136 471

E-mail:

jambaeduardo78@gmail.com

Antes de realizar uma contribuição, recomendamos confirmar os dados diretamente com a liderança do projeto, especialmente caso este material esteja sendo consultado algum tempo depois de sua publicação.

MAIS DO QUE CONTRIBUIR

Talvez você não possa contribuir financeiramente.

Isso não significa que não possa participar.

Ore.

Compartilhe.

Apresente Caminina a outras pessoas.

E, principalmente, permita que esta história também lhe faça uma pergunta:

“O que existe hoje em minhas mãos que pode ser colocado a serviço de Deus?”

“Até aqui nos ajudou o Senhor.”

1 Samuel 7:12

CAMININA PARA CRISTO

Luena — Província do Moxico — Angola

Agência Missionária Hora de Profetizar — AMHP

Igreja Cafarnaum Internacional — ICI

Jesus na Web

Brasil